

MENOPAUSE DINI

Memahami Perubahan, Memperkuat Peran Perawat
dalam Deteksi, Pencegahan, dan Asuhan Holistik



Dr. Irna Nursanti, SKp., M.Kep., Sp.Mat.
Ns. Dewi Anggraini., S.Kep., M.S.
Dhea Natasha, S.Kep., Ns., M.Sc., PhD.
Diana Irawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.KMB.

Editor: Prof. Dr. Nilawati Uly, S.Si., Apt., M.Kes.

Menopause Dini:

**Memahami Perubahan,
Menguatkan Peran Perawat dalam Deteksi,
Pencegahan, dan Asuhan Holistik**

Dr. Irna Nursanti, SKp., M.Kep., Sp.Mat.

Ns. Dewi Anggraini., S.Kep., M.S.

Dhea Natasha, S.Kep., Ns., M.Sc., PhD.

Diana Irawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.KMB.

Editor: Prof. Dr. Nilawati Uly, S.Si., Apt., M.Kes.



Menopause Dini: Memahami Perubahan, Memperkuat Peran Perawat dalam Deteksi, Pencegahan, dan Asuhan Holistik

Penulis:

Dr. Irna Nursanti, SKp., M.Kep., Sp.Mat.

Ns. Dewi Anggraini., S.Kep., M.S.

Dhea Natasha, S.Kep., Ns., M.Sc., PhD.

Diana Irawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.KMB.

Editor: Prof. Dr. Nilawati Uly, S.Si., Apt., M.Kes.

ISBN : 978-634-7556-47-9

Desain Sampul : Ivan Zumarano

Penata Letak : Achmad Faisal

Cetakan Pertama : Februari, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal & @optimal.penerbit

Tiktok : @bimbelukomoptimal

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena buku *Menopause Dini: Memahami Perubahan, Memperkuat Peran Perawat dalam Deteksi, Pencegahan, dan Asuhan Holistik* dapat tersusun dengan baik. Buku ini lahir dari kebutuhan akan referensi praktis dan komprehensif mengenai menopause dini, khususnya dalam lingkup keperawatan maternitas dan kesehatan reproduksi. Di lapangan, masih banyak perempuan usia produktif yang mengalami gejala menopause dini tanpa pemahaman yang memadai, sehingga deteksi dan penanganan sering terlambat. Kondisi ini berdampak pada kesehatan fisik, psikologis, serta kualitas hidup perempuan dan keluarganya. Perawat memiliki posisi strategis untuk melakukan edukasi, pencegahan, dan pendampingan sejak dini.

Melalui buku ini, kami berupaya menyajikan pembahasan yang runtut, sederhana, dan aplikatif, mulai dari konsep dasar, faktor risiko, hingga asuhan keperawatan holistik berbasis SDKI, SLKI, dan SIKI. Materi disusun untuk membantu mahasiswa dan praktisi menghubungkan teori dengan praktik klinik sehari-hari. Penekanan diberikan pada peran perawat sebagai educator dan advocate yang memberdayakan pasien serta keluarga. Harapannya, buku ini dapat menjadi panduan belajar sekaligus pegangan praktik dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, empatik, dan berbasis bukti.

Kami menyadari buku ini masih memiliki keterbatasan, sehingga saran dan masukan sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan praktik keperawatan, khususnya di bidang maternitas dan kesehatan reproduksi.

Tim Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
 BAB 1 Mengapa Menopause Dini perlu Diperhatikan?	1
A. Situasi Epidemiologi Global dan Indonesia.....	1
B. Dampak terhadap Kesehatan Perempuan	3
C. Peran Perawat dalam Deteksi Dini dan Pencegahan.....	5
 BAB 2 Anatomi, Fisiologi, dan Regulasi Hormonal Sistem Reproduksi Perempuan	8
A. Organ Reproduksi Perempuan dan Fungsinya	8
B. Siklus Menstruasi dan Perubahan Alaminya.....	10
C. Mekanisme Hormonal: FSH, LH, Estrogen, Progesteron.....	11
D. Proses Penuaan Ovarium	13
 BAB 3 Memahami Menopause dan Menopause Dini	15
A. Apa itu Menopause Dini?	15
B. Perimenopause vs Menopause Dini	17
C. Tanda dan Gejala yang Perlu Diwaspadai.....	18
 BAB 4 Patofisiologi dan Faktor Risiko Menopause Dini.....	21
A. Proses Biologis yang Mendasari.....	21
B. Faktor Genetik	23
C. Status Gizi dan Gaya Hidup	24
D. Penyakit Kronis dan Tindakan Medis.....	27
E. Faktor Psikososial dan Lingkungan.....	30
 BAB 5 Dampak Menopause Dini Terhadap Kesehatan dan Kualitas Hidup	36
A. Perubahan Fisik.....	36
B. Dampak Psikologis dan Emosional	38
C. Perubahan dalam Seksualitas	41
D. Risiko Jangka Panjang: Osteoporosis dan Kardiovaskular	43

BAB 6 Pengkajian Keperawatan pada Perempuan dengan Menopause Dini.....	46
A. Anamnesis Komprehensif	46
B. Pemeriksaan Fisik	49
C. Pengkajian Psikososial.....	52
D. Pemeriksaan Penunjang	57
 BAB 7 Menyusun Diagnosis dan Rencana Asuhan Keperawatan	60
 BAB 8 Intervensi Keperawatan dan Penatalaksanaan Kolaboratif... 	64
A. Edukasi dan Konseling Kesehatan.....	64
B. Manajemen Gejala	66
C. Pengaturan Nutrisi dan Aktivitas Fisik.....	68
D. Dukungan Psikologis.....	70
E. Farmakologi/ <i>Hormone Replacement Therapy</i> (HRT) dan Rujukan.....	72
 BAB 9 Pendidikan dan Promosi Kesehatan.....	75
A. Strategi Edukasi Pasien dan Keluarga	75
B. Program Pencegahan Di Komunitas.....	78
C. Peran Perawat Sebagai <i>Educator</i> dan <i>Advocate</i>	80
 Daftar Pustaka.....	83

BAB 1

Mengapa Menopause Dini perlu Diperhatikan?

A. Situasi Epidemiologi Global dan Indonesia

Penghentian haid permanen pada usia muda (sebelum 40 tahun), yang sering disebut *premature ovarian insufficiency* (POI) atau menopause dini, bukan kasus langka sekaligus membawa konsekuensi kesehatan jangka panjang yang serius. Beberapa tinjauan besar dan artikel ringkasan klinis menunjukkan estimasi prevalensi POI berada di kisaran $\approx 1\%$ hingga sekitar 3–4% pada populasi umum, sementara angka untuk **menopause dini / menopause awal** (mis. <45 tahun) bisa jauh lebih tinggi tergantung definisi dan metode studi (Kapoor, 2023; Federici et al., 2024). Studi-meta dan survei populasi juga melaporkan variasi regional yang nyata: beberapa analisis menemukan prevalensi POI yang lebih tinggi di negara dengan Human Development Index menengah-rendah, dan terdapat perbedaan antar-wilayah (Rostami Dovom et al., 2021; Federici et al., 2024).

Perbedaan angka antar studi sering disebabkan oleh cara pengukuran (mis. apakah menghitung semua wanita dalam populasi sebagai penyebut atau hanya wanita yang sudah menopause), cakupan usia, dan faktor iatrogenik seperti kemoterapi atau pembedahan ooforektomi yang meningkatkan angka menopause dini pada kelompok tertentu. Meta-analisis dan studi populasi terbaru melaporkan rentang prevalensi POI antara $\approx 1\%$ sampai sekitar 3–4%, dan proporsi untuk menopause sebelum 45 tahun (*early menopause*) bisa mencapai puluhan persen pada beberapa sampel tergantung karakteristik demografi dan reproduksi (Rostami Dovom et al., 2021; Jambarsang et al., 2023; Federici et al., 2024).

Untuk konteks Indonesia, data survei dan studi lokal menunjukkan jumlah wanita usia menopause yang besar dan tren kenaikan seiring penuaan demografi: publikasi BPS dan laporan populasi terbaru menggambarkan persentase wanita menopause yang substansial pada tingkat nasional dan provinsi, sedangkan studi daerah melaporkan variasi usia menopause rata-rata sekitar akhir 40-an (Zilfia, 2023; Badan Pusat Statistik [BPS], 2023). Studi populasi di beberapa wilayah Indonesia bahkan menemukan insiden menopause dini/awal yang dipengaruhi oleh kondisi sosio-demografis, status gizi, riwayat reproduksi, serta paparan pekerjaan atau lingkungan (Zilfia, 2023; Jambarsang et al., 2023).

Bagi perawat dan mahasiswa keperawatan, implikasinya jelas: angka POI/menopause dini yang tidak sedikit artinya tenaga keperawatan perlu cakap pada deteksi dini gejala (mis. perubahan siklus, *hot flushes*, gangguan *mood*), pengkajian risiko jangka panjang (osteoporosis, penyakit kardiovaskular), serta edukasi dan rujukan yang tepat sesuai pedoman interdisipliner (Kapoor, 2023; Federici et al., 2024).

Usia masuk menopause dan frekuensi masalah terkait tidak seragam di seluruh wilayah Indonesia, ada variasi antar provinsi dan terutama antara kota-kota besar versus daerah pedesaan. Secara demografi, provinsi-provinsi dengan populasi wanita dewasa yang besar (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan) memperlihatkan beban *absolute* perempuan menopause yang lebih besar karena jumlah penduduknya, tetapi pola usia menopause dan jenis keluhan bisa berbeda tergantung faktor sosial ekonomi, akses layanan kesehatan, dan perilaku kesehatan setempat (BPS, 2023).

Studi lapangan di beberapa kota besar menyingkap gambaran klinis yang berguna untuk perawat. Survei di Batam, Makassar, dan Surabaya menunjukkan bahwa sebagian besar responden memasuki menopause pada rentang usia 45–55 tahun, dan gejala yang paling sering dilaporkan adalah kelelahan fisik/mental serta nyeri sendi, informasi yang menegaskan bahwa masalah vasomotor dan muskuloskeletal sangat nyata di konteks perkotaan (Permana et al., 2023). Studi lain pada populasi perkotaan (mis. Denpasar) juga menemukan pola gejala yang serupa: banyak wanita melaporkan kombinasi keluhan somatik, psikologis, dan urogenital saat transisi menopause (Diyu, 2022).

Di level provinsi, data sensus dan survei (BPS) menunjukkan bahwa provinsi dengan urbanisasi tinggi tidak hanya memiliki lebih banyak wanita usia menopause, tetapi juga lebih baik dalam pencatatan dan akses ke fasilitas Kesehatan, sehingga angka yang terlihat (mis. prevalensi gejala yang tercatat) seringkali lebih tinggi secara terdeteksi di kota besar dibandingkan daerah terpencil, bukan karena penyakitnya lebih sering terjadi, tetapi karena akses diagnosis dan laporan lebih baik (BPS, 2023). Sebaliknya, di beberapa provinsi dengan wilayah pedesaan luas ditemukan bahwa menopause sering diderita tanpa pengakuan formal atau perawatan yang memadai; studi lintas wilayah mencatat perbedaan pelaporan dan penanganan yang dipengaruhi faktor pendidikan, ekonomi, dan jarak ke layanan kesehatan (Anas et al., 2022).

Perbandingan urban vs rural di Indonesia menunjukkan dua pola penting yang relevan bagi perawat. Pertama, beberapa penelitian dan tinjauan Asia-Indonesia melaporkan bahwa wanita perkotaan cenderung mengalami menopause pada usia sedikit lebih lambat daripada wanita pedesaan, kemungkinan terkait nutrisi, status kesehatan umum, dan akses perawatan reproduksi, sehingga rata-rata usia menopause bisa lebih tinggi di kota besar (Agrawal, 2025). Kedua, wanita di daerah pedesaan sering melaporkan gejala yang lebih berat atau berdampak lebih besar pada kualitas hidup karena keterbatasan akses layanan, tingkat pendidikan kesehatan yang lebih rendah, dan beban kerja fisik yang lebih tinggi (studi komparatif urban-rural; Ma'rifah, 2019; beberapa studi lapangan di provinsi).

Di samping itu, angka menopause dini (*premature ovarian insufficiency*) dan menopause awal menunjukkan variasi antar daerah yang dipengaruhi faktor iatrogenik (mis. pembedahan, kemoterapi), status gizi, merokok, dan faktor genetik. Pada provinsi dengan fasilitas kanker atau layanan bedah besar (mis. kota-kota besar), proporsi menopause yang dipicu tindakan medis bisa relatif lebih tinggi karena lebih banyak pasien menerima terapi yang berisiko menurunkan fungsi ovarium (literatur klinis & survei rumah sakit). Namun, jumlah kasus yang tercatat tetap bergantung pada pelaporan dan registrasi (Permana et al., 2023; BPS, 2023).

B. Dampak terhadap Kesehatan Perempuan

Perubahan fungsi ovarium pada menopause dini membawa konsekuensi yang tidak hanya berkaitan dengan berhentinya menstruasi, tetapi juga menyentuh hampir seluruh sistem tubuh. Penurunan kadar estrogen terjadi lebih cepat dan lebih lama dibandingkan menopause fisiologis pada usia normal, sehingga perempuan mengalami periode defisiensi hormon yang

lebih panjang. Kondisi ini berhubungan dengan peningkatan risiko gangguan metabolik, kardiovaskular, tulang, serta kesehatan mental dalam jangka panjang (Faubion, 2023).

Keluhan fisik sering muncul sebagai tanda awal. Gejala vasomotor seperti *hot flushes*, keringat malam, jantung berdebar, dan gangguan tidur merupakan masalah yang paling banyak dilaporkan. Gejala ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, konsentrasi kerja, serta kualitas istirahat. Pada beberapa perempuan, keluhan berlangsung bertahun-tahun dan menurunkan produktivitas. Studi klinis dan pedoman praktik menyebutkan bahwa lebih dari setengah perempuan menopause mengalami gejala vasomotor sedang hingga berat (The North American Menopause Society [NAMS], 2022).

Dampak pada kesehatan tulang juga signifikan. Estrogen berperan mempertahankan kepadatan tulang melalui keseimbangan antara pembentukan dan resorpsi tulang. Saat hormon ini menurun, proses resorpsi lebih dominan sehingga massa tulang berkurang lebih cepat. Perempuan dengan menopause dini memiliki risiko osteoporosis dan fraktur yang lebih tinggi dibandingkan yang menopause pada usia normal. Risiko ini semakin besar bila disertai status gizi rendah, kurang aktivitas fisik, atau kekurangan vitamin D dan kalsium (Shuster, Rhodes, Gostout, Grossardt, & Rocca, 2021).

Sistem kardiovaskular ikut terdampak. Estrogen sebelumnya memberi efek protektif terhadap pembuluh darah dan profil lipid. Ketika kadarnya menurun, terjadi peningkatan kolesterol LDL, penurunan HDL, serta perubahan fungsi endotel. Sejumlah penelitian *kohort* menunjukkan bahwa perempuan dengan menopause dini memiliki peluang lebih besar mengalami penyakit jantung koroner, hipertensi, dan stroke di usia yang lebih muda. Perubahan ini menjadikan deteksi faktor risiko kardiovaskular sebagai bagian penting dari asuhan keperawatan (Santoro et al., 2021).

Selain keluhan fisik, aspek psikologis sering kali tidak kalah berat. Perubahan hormon dapat memengaruhi neurotransmitter yang berkaitan dengan suasana hati, sehingga muncul kecemasan, mudah marah, gangguan konsentrasi, bahkan depresi. Perempuan yang mengalami menopause dini juga dapat merasa kehilangan peran reproduksi atau khawatir terhadap citra diri dan relasi pasangan. Studi kesehatan mental menunjukkan peningkatan gejala depresi dan penurunan kualitas hidup pada kelompok ini dibandingkan perempuan seusianya yang masih menstruasi (Gordon, Whitcomb, & Randolph, 2020).

Fungsi seksual dan kesehatan urogenital turut berubah. Kekeringan vagina, nyeri saat berhubungan, penurunan libido, dan infeksi saluran kemih berulang sering dilaporkan. Kondisi ini berkaitan dengan atrofi mukosa urogenital akibat rendahnya estrogen. Dampaknya tidak hanya pada kenyamanan fisik, tetapi juga hubungan interpersonal dan kepuasan hidup. Pedoman klinis terbaru menekankan perlunya edukasi terbuka serta intervensi sederhana seperti pelumas, latihan dasar panggul, atau terapi hormonal lokal sesuai indikasi (NAMS, 2022).

Jika dilihat secara keseluruhan, menopause dini memengaruhi kualitas hidup secara multidimensi: fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Perempuan mungkin membatasi aktivitas, menarik diri dari lingkungan sosial, atau merasa tidak percaya diri. Konsep ini dipertegas dalam panduan Eropa tentang *premature ovarian insufficiency* yang menyatakan bahwa pendekatan perawatan harus bersifat komprehensif, tidak hanya mengobati gejala tetapi juga memberikan dukungan psikososial dan edukasi jangka panjang (ESHRE Guideline Group, 2024). Bagi perawat, pemahaman menyeluruh terhadap dampak ini membantu dalam melakukan pengkajian holistik dan menyusun intervensi yang lebih tepat sasaran.

C. Peran Perawat dalam Deteksi Dini dan Pencegahan

Kontak perawat yang intens dan berkelanjutan dengan perempuan usia reproduksi hingga usia lanjut menempatkan profesi ini pada posisi strategis untuk mengenali tanda awal menopause dini. Perubahan pola menstruasi, keluhan vasomotor, gangguan tidur, kelelahan yang tidak biasa, serta perubahan suasana hati sering kali muncul lebih dulu dalam interaksi pelayanan primer. Pedoman klinis dan tinjauan praktik menegaskan bahwa pengenalan dini gejala dan faktor risiko oleh perawat dapat mempercepat penanganan dan menurunkan dampak kesehatan jangka panjang (Faubion, 2023; ESHRE Guideline Group, 2024).

Peran utama perawat pada tahap deteksi dini dimulai dari pengkajian yang sistematis dan berkesinambungan. Anamnesis sederhana terkait usia *menarche*, keteraturan siklus, riwayat *amenore*, status gizi, kebiasaan merokok, serta riwayat penyakit kronis atau terapi medis berisiko (kemoterapi, pembedahan ovarium) dapat memberikan petunjuk awal. Literatur terbaru menekankan bahwa skrining berbasis wawancara dan observasi klinis sudah cukup efektif sebagai langkah awal sebelum pemeriksaan penunjang, khususnya di layanan primer (Santoro et al., 2021; Kapoor, 2023).

Dalam aspek pencegahan, perawat berperan sebagai edukator kesehatan yang menjembatani informasi ilmiah dengan kebutuhan sehari-hari perempuan. Edukasi mengenai gaya hidup sehat, seperti pemenuhan gizi seimbang, aktivitas fisik teratur, pengendalian stres, serta berhenti merokok, terbukti berkontribusi pada kesehatan ovarium dan menurunkan risiko komplikasi pascamenopause. Pendekatan promosi kesehatan yang konsisten membantu perempuan memahami bahwa menopause dini bukan sekadar masalah reproduksi, tetapi berkaitan erat dengan kesehatan tulang, jantung, dan kesehatan mental (Shuster et al., 2021; NAMS, 2022).

Di wilayah **perkotaan (urban)**, perawat umumnya bekerja dengan dukungan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dan akses rujukan yang lebih cepat. Tantangan utama di lingkungan ini sering berkaitan dengan gaya hidup sedentari, stres kerja, dan paparan faktor risiko metabolik. Perawat dapat berperan aktif melalui *skrining* rutin, konseling individual, pemantauan faktor risiko kardiovaskular, serta koordinasi dengan tenaga kesehatan lain untuk tindak lanjut pemeriksaan hormonal atau densitas tulang bila diperlukan. Literatur praktik klinik menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif di *setting* urban meningkatkan deteksi menopause dini yang berkaitan dengan faktor iatrogenik atau penyakit kronis (Santoro et al., 2021; Kapoor, 2023).

Sebaliknya, di wilayah **pedesaan (rural)**, peran perawat sering lebih luas dan bersifat komunitas. Keterbatasan akses layanan spesialisik membuat perawat puskesmas dan perawat komunitas menjadi ujung tombak dalam edukasi dan pemantauan jangka panjang. Banyak perempuan di daerah rural menganggap perubahan menstruasi sebagai proses alami yang tidak perlu dikonsultasikan, sehingga gejala menopause dini berisiko terlewat. Studi kesehatan masyarakat menekankan pentingnya edukasi berbasis komunitas, kunjungan rumah, dan pemanfaatan kegiatan posyandu atau kelompok perempuan untuk meningkatkan kesadaran dan deteksi dini (WHO, 2022; ESHRE Guideline Group, 2024).

Selain edukasi dan skrining, perawat juga memiliki peran penting dalam pencegahan dampak lanjutan melalui dukungan psikososial. Mendengarkan keluhan, memvalidasi pengalaman pasien, dan memberikan informasi yang benar dapat mengurangi kecemasan serta stigma yang sering menyertai menopause dini. Pendekatan caring dan holistik ini terbukti meningkatkan kepatuhan terhadap anjuran kesehatan dan kualitas hidup perempuan, baik di *setting* urban maupun rural (Gordon et al., 2020; Faubion, 2023).

Secara keseluruhan, peran perawat dalam deteksi dini dan pencegahan menopause dini tidak terbatas pada aspek klinis semata. Perawat berfungsi sebagai pengkaji awal, pendidik, konselor, serta penghubung layanan kesehatan. Dengan menyesuaikan strategi intervensi terhadap konteks wilayah urban dan rural, perawat dapat berkontribusi nyata dalam menekan dampak jangka panjang menopause dini dan meningkatkan kualitas hidup perempuan (ESHRE Guideline Group, 2024; NAMS, 2022).

BAB 2

Anatomi, Fisiologi, dan Regulasi Hormonal Sistem Reproduksi Perempuan

A. Organ Reproduksi Perempuan dan Fungsinya

Pemahaman mengenai struktur organ reproduksi perempuan menjadi dasar penting sebelum membahas perubahan hormonal dan menopause dini. Pengetahuan anatomi membantu perawat mengenali fungsi normal, memahami asal keluhan pasien, serta mengaitkan perubahan fisiologis dengan manifestasi klinis yang muncul. Literatur kebidanan dan kesehatan perempuan menekankan bahwa penguasaan anatomi reproduksi mempermudah proses pengkajian, edukasi, dan deteksi gangguan sejak dini (Hickey & Elliott, 2022).

Organ reproduksi perempuan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu **organ internal** dan **organ eksternal**. Organ internal meliputi ovarium, tuba falopi, uterus, dan vagina, sedangkan organ eksternal dikenal sebagai vulva. Masing-masing struktur memiliki fungsi spesifik namun saling terhubung secara fungsional melalui sistem hormonal dan vaskular. Keterpaduan ini memungkinkan terjadinya ovulasi, fertilisasi, implantasi, serta siklus menstruasi secara teratur (Tortora & Derrickson, 2021).

Ovarium berperan sebagai pusat fungsi reproduksi sekaligus kelenjar endokrin. Di dalamnya terdapat folikel yang menyimpan oosit serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini mengatur siklus menstruasi, kesehatan tulang, fungsi kardiovaskular, hingga keseimbangan suasana hati. Cadangan folikel akan menurun secara bertahap seiring usia. Saat jumlahnya berkurang drastis, produksi hormon ikut menurun dan memicu transisi menuju menopause. Kondisi ini menjadikan ovarium sebagai organ kunci dalam pembahasan menopause dini (Kapoor, 2023).

Di sisi lain, **tuba falopi** berfungsi sebagai saluran transportasi ovum dari ovarium menuju uterus sekaligus lokasi terjadinya fertilisasi. Struktur ini memiliki silia dan kontraksi otot halus yang membantu pergerakan sel telur. Gangguan anatomi atau inflamasi pada tuba dapat memengaruhi kesuburan, walaupun tidak secara langsung memengaruhi waktu menopause. Bagi perawat, pemahaman fungsi tuba penting saat menjelaskan proses reproduksi dan konsekuensi klinis pada pasien (Hickey & Elliott, 2022).

Uterus atau rahim merupakan organ berotot dengan tiga lapisan utama: endometrium, miometrium, dan perimetrium. Endometrium mengalami penebalan dan peluruhan setiap siklus menstruasi sebagai respons terhadap perubahan hormonal ovarium. Ketika kadar estrogen menurun pada masa transisi menopause, lapisan ini menjadi lebih tipis dan perdarahan menstruasi berangsur berhenti. Perubahan ini menjelaskan mengapa amenore menjadi salah satu tanda awal gangguan fungsi ovarium (Santoro et al., 2021).

Selanjutnya, **vagina dan vulva** berperan dalam fungsi seksual, proteksi, dan jalur keluarnya darah menstruasi. Jaringan mukosa vagina sangat dipengaruhi estrogen sehingga tetap elastis dan lembap pada usia reproduktif. Penurunan hormon menyebabkan dinding vagina menjadi lebih tipis, kering, dan mudah iritasi. Kondisi ini sering menimbulkan keluhan dispareunia atau infeksi berulang pada perempuan menopause dini. Aspek anatomi ini penting dipahami perawat saat memberikan edukasi mengenai kesehatan urogenital (The North American Menopause Society [NAMS], 2022).

Secara keseluruhan, struktur organ reproduksi bekerja sebagai satu sistem terpadu yang sangat sensitif terhadap perubahan hormonal. Gangguan pada ovarium akan berdampak pada organ lain melalui mekanisme umpan balik hormonal. Pendekatan holistik terhadap anatomi dan fisiologi ini membantu perawat menghubungkan antara keluhan pasien, proses biologis, dan intervensi yang tepat. Perspektif sistemik seperti ini direkomendasikan dalam praktik keperawatan kesehatan perempuan modern (ESHRE Guideline Group, 2024).

B. Siklus Menstruasi dan Perubahan Alaminya

Setiap bulan tubuh perempuan usia reproduktif mengalami rangkaian perubahan biologis yang teratur sebagai persiapan kehamilan. Rangkaian ini dikenal sebagai siklus menstruasi. Prosesnya melibatkan kerja sama antara otak, kelenjar hipofisis, ovarium, dan uterus melalui mekanisme hormonal yang saling memberi umpan balik. Pemahaman mengenai siklus ini penting bagi mahasiswa keperawatan karena banyak keluhan pasien, mulai dari nyeri haid, perdarahan tidak teratur, hingga gangguan kesuburan, berasal dari perubahan pada salah satu tahap siklus tersebut (Santoro et al., 2021).

Pengendali utama siklus menstruasi berada pada **poros hipotalamus–hipofisis–ovarium (HPO axis)**. Hipotalamus melepaskan hormon GnRH yang merangsang hipofisis anterior untuk menghasilkan FSH (*follicle stimulating hormone*) dan LH (*luteinizing hormone*). Kedua hormon ini bekerja langsung pada ovarium untuk mematangkan folikel dan memicu produksi estrogen serta progesteron. Mekanisme ini berlangsung secara ritmis, sehingga kadar hormon naik dan turun secara teratur setiap bulan (Kapoor, 2023).

Secara klinis, siklus menstruasi dibagi menjadi **empat fase utama: fase menstruasi, fase folikular, ovulasi, dan fase luteal**. Pada fase menstruasi, lapisan endometrium yang tidak dibuahi akan luruh dan keluar sebagai darah haid. Fase ini menandai hari pertama siklus. Perdarahan biasanya berlangsung 3–7 hari. Literatur klinis menyebutkan bahwa kehilangan darah yang terlalu banyak atau terlalu lama perlu dievaluasi karena dapat mengindikasikan gangguan hormonal atau struktural (Hickey & Elliott, 2022). Setelah menstruasi berakhir, tubuh memasuki **fase folikular**. FSH meningkat dan merangsang beberapa folikel di ovarium untuk berkembang, tetapi umumnya hanya satu yang menjadi folikel dominan. Folikel ini menghasilkan estrogen yang makin tinggi. Estrogen berfungsi menebalkan kembali endometrium sebagai persiapan implantasi. Pada fase ini, perempuan sering merasa lebih bertenaga karena pengaruh estrogen terhadap metabolisme dan suasana hati (Santoro et al., 2021).

Lonjakan estrogen memicu **ovulasi**, yaitu pelepasan sel telur matang dari ovarium. Lonjakan LH yang tajam menjadi penanda utama terjadinya ovulasi, biasanya sekitar hari ke-14 pada siklus 28 hari, meskipun waktu ini bisa berbeda pada tiap individu. Ovulasi merupakan periode paling subur. Pengetahuan ini membantu perawat saat memberikan edukasi terkait perencanaan kehamilan atau kontrasepsi alami (Kapoor, 2023).

Tahap berikutnya adalah **fase luteal**. Sisa folikel berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan progesteron. Hormon ini menjaga endometrium tetap tebal dan siap menerima embrio. Bila tidak terjadi pembuahan, kadar progesteron menurun, lapisan rahim meluruh, dan siklus kembali ke fase menstruasi. Fluktuasi progesteron sering dikaitkan dengan gejala pramenstruasi seperti kembung, perubahan emosi, dan nyeri payudara (The North American Menopause Society [NAMS], 2022).

Seiring bertambahnya usia atau ketika cadangan folikel menurun, keteraturan siklus mulai berubah. Siklus dapat menjadi lebih pendek, lebih panjang, atau tidak teratur. Ketidakteraturan ini sering menjadi tanda awal penurunan fungsi ovarium dan perlu dikaji oleh tenaga kesehatan. Pedoman terbaru menekankan bahwa perubahan pola haid harus dicatat secara sistematis karena dapat menjadi petunjuk dini gangguan reproduksi, termasuk transisi menuju menopause atau menopause dini (ESHRE Guideline Group, 2024).

Bagi perawat, memahami alur siklus menstruasi memudahkan dalam melakukan pengkajian, menentukan waktu edukasi kesehatan reproduksi, serta menjelaskan kepada pasien mengapa suatu keluhan muncul pada fase tertentu. Pendekatan ini membuat komunikasi lebih sederhana dan berbasis fisiologi, sehingga mahasiswa keperawatan dapat menghubungkan teori dengan praktik klinik secara lebih jelas (Hickey & Elliott, 2022).

C. Mekanisme Hormonal: FSH, LH, Estrogen, Progesteron

Aktivitas sistem reproduksi perempuan dikendalikan oleh kerja sama hormon yang bergerak seperti “rantai komando” dari otak menuju ovarium. Komunikasi ini terjadi melalui poros **hipotalamus–hipofisis–ovarium (HPO axis)**. Hipotalamus mengirim sinyal awal, hipofisis menerjemahkannya menjadi hormon perangsang, lalu ovarium merespons dengan memproduksi hormon reproduksi utama. Pola naik-turun hormon inilah yang mengatur ovulasi, menstruasi, hingga transisi menuju menopause. Literatur endokrinologi reproduksi menekankan bahwa gangguan kecil pada poros ini dapat langsung memengaruhi keteraturan siklus haid (Santoro et al., 2021).

Proses dimulai dari pelepasan **GnRH (gonadotropin-releasing hormone)** oleh hipotalamus secara pulsatif. Sinyal ini merangsang hipofisis anterior untuk menghasilkan dua hormon penting, yaitu **FSH (follicle stimulating hormone)** dan **LH (luteinizing hormone)**. FSH dan LH dikenal sebagai gonadotropin karena secara langsung bekerja pada gonad, yaitu ovarium.

Irama pelepasan GnRH menentukan kadar FSH dan LH dalam darah, sehingga ritme ini sangat penting untuk menjaga siklus tetap teratur (Kapoor, 2023).

FSH berperan utama pada fase awal siklus. Hormon ini merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel ovarium. Setiap folikel mengandung satu oosit (sel telur) dan sel-sel granulosa yang memproduksi estrogen. Ketika FSH meningkat, beberapa folikel berkembang, tetapi biasanya hanya satu yang menjadi folikel dominan. Proses ini menjelaskan mengapa pada umumnya hanya satu ovum dilepaskan setiap siklus. Kadar FSH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mengganggu pematangan folikel dan menyebabkan siklus tidak teratur (ESHRE Guideline Group, 2024).

Selanjutnya, **LH** memiliki peran penting menjelang pertengahan siklus. Peningkatan estrogen dari folikel dominan memicu lonjakan LH yang tajam, dikenal sebagai *LH surge*. Lonjakan ini menandai terjadinya **ovulasi**, yaitu pelepasan sel telur matang dari ovarium. Setelah ovulasi, LH membantu pembentukan korpus luteum yang bertugas menghasilkan progesteron. Tanpa *LH surge*, ovulasi tidak terjadi sehingga kehamilan tidak mungkin terjadi pada siklus tersebut (Santoro et al., 2021).

Dari sisi hormon ovarium, **estrogen** memiliki banyak fungsi protektif. Hormon ini menebalkan endometrium, menjaga elastisitas vagina, mendukung kepadatan tulang, serta berperan dalam regulasi *mood* dan metabolisme. Selama fase folikular, kadar estrogen meningkat bertahap seiring pertumbuhan folikel. Kadar yang cukup membuat tubuh berada dalam kondisi “siap hamil”. Penurunan estrogen, seperti yang terjadi pada menopause dini, sering memunculkan keluhan *hot flushes*, kekeringan vagina, dan gangguan tidur (The North American Menopause Society [NAMS], 2022).

Berbeda dengan estrogen, **progesteron** dominan pada fase luteal. Hormon ini dihasilkan oleh korpus luteum setelah ovulasi. Fungsinya menjaga ketebalan endometrium agar embrio dapat berimplantasi, menurunkan kontraksi rahim, serta memberi efek menenangkan pada sistem saraf. Bila tidak terjadi pembuahan, kadar progesteron turun sehingga lapisan rahim luruh sebagai menstruasi. Fluktuasi progesteron sering dikaitkan dengan gejala pramenstruasi seperti kembung, mudah lelah, dan perubahan emosi (Hickey & Elliott, 2022).

Interaksi antara FSH, LH, estrogen, dan progesteron diatur melalui **mekanisme umpan balik (feedback)**. Saat estrogen rendah, hipofisis meningkatkan FSH. Ketika estrogen tinggi, pelepasan FSH ditekan tetapi memicu *LH surge*. Pada fase luteal, progesteron menekan kembali FSH dan LH agar tidak terjadi

ovulasi kedua. Sistem ini menjaga keseimbangan hormonal secara dinamis. Jika fungsi ovarium menurun, misalnya pada menopause dini, estrogen dan progesteron berkurang sehingga FSH dan LH meningkat sebagai kompensasi. Peningkatan FSH menjadi salah satu penanda laboratorium yang sering dipakai dalam diagnosis gangguan fungsi ovarium (Kapoor, 2023; ESHRE Guideline Group, 2024).

Bagi mahasiswa keperawatan, memahami mekanisme hormonal ini membantu mengaitkan teori dengan praktik klinik. Keluhan pasien seperti haid tidak teratur, infertilitas, atau gejala vasomotor dapat ditelusuri berdasarkan perubahan hormon yang mendasarinya. Pendekatan fisiologis membuat proses pengkajian lebih logis dan memudahkan edukasi kepada pasien (Santoro et al., 2021).

D. Proses Penuaan Ovarium

Perjalanan reproduksi perempuan tidak berlangsung tetap sepanjang hidup, karena ovarium secara alami mengalami proses penuaan biologis dari waktu ke waktu. Sejak masa pubertas, jumlah folikel di dalam ovarium terus berkurang pada setiap siklus menstruasi. Cadangan ini disebut *ovarian reserve* dan jumlahnya tidak dapat diperbarui kembali. Ketika jumlah folikel menurun, kemampuan ovarium memproduksi hormon juga ikut berkurang. Penurunan bertahap ini merupakan mekanisme dasar transisi menuju menopause dan dijelaskan dalam tinjauan endokrinologi reproduksi terbaru (Kapoor, 2023).

Sejak lahir, seorang perempuan memiliki sekitar satu hingga dua juta oosit, namun hanya sebagian kecil yang bertahan hingga usia dewasa. Setiap bulan, banyak folikel mengalami proses atresia atau degenerasi alami meskipun tidak terjadi ovulasi. Kehilangan folikel yang terus-menerus menyebabkan cadangan ovarium menyusut lebih cepat pada dekade usia 30–40 tahun. Pada fase ini, siklus menstruasi mulai menunjukkan variasi panjang dan volume perdarahan. Perubahan tersebut dianggap sebagai tanda awal penuaan ovarium secara fisiologis (Santoro et al., 2021).

Respons ovarium terhadap hormon FSH dan LH juga ikut berubah seiring berkurangnya cadangan folikel. Folikel yang tersisa menjadi kurang sensitif terhadap stimulasi hormonal sehingga pematangan sel telur tidak optimal. Tubuh mencoba mengompensasi dengan meningkatkan kadar FSH dalam darah. Nilai FSH yang tinggi sering dipakai sebagai indikator laboratorium adanya penurunan fungsi ovarium. Temuan ini sering dijelaskan dalam

pedoman klinis untuk penilaian gangguan reproduksi perempuan (ESHRE Guideline Group, 2024).

Penurunan produksi estrogen dan progesteron menjadi konsekuensi berikutnya dari penuaan ovarium. Estrogen yang lebih rendah menyebabkan endometrium lebih tipis dan menstruasi menjadi jarang atau tidak teratur. Pada saat yang sama, efek protektif estrogen terhadap tulang, pembuluh darah, dan mukosa vagina ikut menurun. Perempuan dapat mulai merasakan gejala seperti *hot flushes*, gangguan tidur, nyeri sendi, atau kekeringan vagina. Keluhan ini dijelaskan secara luas dalam literatur manajemen menopause modern (The North American Menopause Society [NAMS], 2022).

Tidak semua perempuan mengalami penuaan ovarium dengan kecepatan yang sama. Faktor genetik, status gizi, kebiasaan merokok, stres kronis, penyakit autoimun, serta tindakan medis seperti kemoterapi atau operasi ovarium dapat mempercepat penurunan fungsi. Bila proses ini terjadi sebelum usia 40 tahun, kondisi tersebut dikenal sebagai *premature ovarian insufficiency* atau menopause dini. Keadaan ini berhubungan dengan risiko kesehatan jangka panjang yang lebih besar dibandingkan menopause pada usia normal. Tinjauan klinis terbaru menekankan pentingnya deteksi dini pada kelompok berisiko (Faubion, 2023).

Pemahaman tentang proses penuaan ovarium membantu tenaga keperawatan mengaitkan antara teori fisiologi dengan praktik klinik sehari-hari. Perubahan siklus haid, peningkatan kadar FSH, serta munculnya keluhan vasomotor dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari berkurangnya cadangan folikel. Pengetahuan ini mempermudah proses pengkajian, interpretasi data laboratorium, serta pemberian edukasi yang tepat kepada pasien dan keluarga. Pendekatan yang berbasis fisiologi membuat komunikasi kesehatan menjadi lebih jelas, rasional, dan mudah diterima. Integrasi konsep ini dalam asuhan rutin direkomendasikan dalam literatur praktik kesehatan perempuan modern (Kapoor, 2023; Santoro et al., 2021).

BAB 3

Memahami Menopause dan Menopause Dini

A. Apa itu Menopause Dini?

Perubahan fungsi reproduksi perempuan pada usia dewasa akhir ditandai dengan berhentinya siklus menstruasi secara permanen sebagai bagian dari proses penuaan biologis. Kondisi ini dikenal sebagai menopause dan terjadi ketika ovarium tidak lagi menghasilkan hormon estrogen dan progesteron dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan siklus haid. Secara klinis, menopause didefinisikan setelah seorang perempuan tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut tanpa penyebab lain seperti kehamilan atau penyakit tertentu. Definisi ini digunakan secara luas dalam praktik klinik dan penelitian kesehatan perempuan. Pedoman internasional menyatakan bahwa menopause merupakan diagnosis retrospektif berdasarkan riwayat haid, bukan semata hasil laboratorium (The North American Menopause Society [NAMS], 2022).

Transisi menuju menopause tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui beberapa tahap. Fase awal disebut perimenopause, yaitu periode ketika siklus mulai tidak teratur disertai keluhan vasomotor atau perubahan emosi. Setelah menstruasi berhenti total selama satu tahun, perempuan memasuki fase postmenopause. Tahapan ini penting dipahami karena gejala sering muncul sebelum haid benar-benar berhenti. Literatur klinis menekankan bahwa pengenalan tahap-tahap ini membantu tenaga kesehatan menginterpretasi keluhan pasien dengan lebih akurat (Santoro et al., 2021).

Selain menopause fisiologis pada usia sekitar 45-55 tahun, terdapat klasifikasi berdasarkan waktu terjadinya. Menopause sebelum usia 45 tahun disebut menopause awal (*early menopause*), sedangkan berhentinya fungsi ovarium sebelum usia 40 tahun dikenal sebagai menopause dini atau *premature ovarian insufficiency (POI)*. POI ditandai dengan gangguan fungsi ovarium yang lebih cepat sehingga kadar estrogen rendah muncul lebih awal.

Kondisi ini dapat bersifat spontan atau dipicu tindakan medis seperti kemoterapi, radioterapi, maupun pembedahan ovarium. Tinjauan endokrinologi terbaru menegaskan bahwa POI memiliki dampak kesehatan jangka panjang yang lebih besar dibanding menopause fisiologis (Kapoor, 2023).

Penegakan diagnosis dilakukan melalui kombinasi data klinis dan pemeriksaan penunjang. Riwayat amenore 12 bulan tetap menjadi kriteria utama untuk menopause fisiologis. Pada kasus usia muda atau dicurigai POI, pemeriksaan hormon seperti FSH, estradiol, dan AMH dapat membantu menilai cadangan ovarium. Kadar FSH yang meningkat secara konsisten disertai estrogen rendah sering dijadikan indikator penurunan fungsi ovarium. Pedoman Eropa menyarankan pengukuran FSH berulang untuk memastikan diagnosis, terutama pada perempuan di bawah 40 tahun (ESHRE Guideline Group, 2024).

Pendekatan diagnosis juga perlu mempertimbangkan kondisi lain yang menyerupai menopause. Gangguan tiroid, hiperprolaktinemia, stres berat, malnutrisi, atau penggunaan kontrasepsi hormonal dapat menyebabkan amenore sementara. Evaluasi menyeluruh membantu membedakan antara gangguan hormonal sementara dengan kegagalan ovarium permanen. Ketelitian dalam pengkajian mencegah kesalahan diagnosis dan intervensi yang tidak tepat. Literatur praktik klinik menyarankan penggunaan anamnesis terarah dan pemeriksaan fisik komprehensif sebelum menetapkan kesimpulan (Santoro et al., 2021).

Pemahaman mengenai definisi, klasifikasi, dan kriteria diagnosis memberi dasar yang kuat dalam asuhan keperawatan kesehatan perempuan. Informasi ini membantu tenaga kesehatan menjelaskan kondisi pasien secara sederhana namun ilmiah. Edukasi yang tepat dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesiapan menghadapi perubahan tubuh. Pengetahuan diagnostik juga mendukung deteksi dini kasus menopause dini yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Rekomendasi praktik terbaru menempatkan tenaga keperawatan sebagai bagian penting dalam skrining dan edukasi pada tahap ini (Faubion, 2023; NAMS, 2022).

B. Perimenopause vs Menopause Dini

Perubahan reproduksi perempuan menjelang akhir masa subur tidak terjadi secara mendadak, melainkan melalui fase transisi yang bertahap. Fase ini dikenal sebagai perimenopause dan ditandai dengan fluktuasi hormon yang menyebabkan siklus haid mulai tidak teratur. Pada periode ini, ovarium masih bekerja tetapi responsnya terhadap rangsangan hormonal sudah menurun. Banyak perempuan masih mengalami menstruasi meskipun jaraknya memanjang atau volumenya berubah. Literatur klinis menjelaskan bahwa perimenopause merupakan proses fisiologis normal dalam penuaan reproduksi (Santoro et al., 2021).

Selama perimenopause, kadar estrogen dapat naik turun secara tidak stabil dari bulan ke bulan. Kondisi ini memicu gejala seperti *hot flushes*, keringat malam, gangguan tidur, mudah lelah, dan perubahan suasana hati. Sebagian perempuan juga melaporkan nyeri payudara atau perdarahan yang lebih banyak dari biasanya. Meskipun menimbulkan keluhan, fungsi ovarium sebenarnya belum berhenti sepenuhnya. Pedoman praktik kesehatan perempuan menyebutkan bahwa fase ini dapat berlangsung beberapa tahun sebelum menopause terjadi (The North American Menopause Society [NAMS], 2022).

Berbeda dengan perimenopause yang bersifat alami, menopause dini menggambarkan berhentinya fungsi ovarium pada usia yang jauh lebih muda. Kondisi ini terjadi sebelum usia 40 tahun dan dikenal sebagai *premature ovarian insufficiency* atau POI. Ovarium tidak lagi mampu menghasilkan estrogen dalam jumlah adekuat sehingga menstruasi berhenti atau sangat jarang terjadi. Keadaan tersebut bukan bagian dari penuaan normal, melainkan gangguan fungsi reproduksi. Tinjauan endokrinologi modern mengklasifikasikan POI sebagai kondisi patologis yang memerlukan evaluasi medis khusus (Kapoor, 2023).

Perbedaan utama antara perimenopause dan menopause dini dapat dilihat dari usia, mekanisme, dan pola siklus haid. Pada perimenopause, usia umumnya berada di atas 40 tahun dengan haid yang masih muncul meski tidak teratur. Pada menopause dini, usia lebih muda dengan amenore yang menetap dan kadar hormon ovarium sangat rendah. Kadar FSH biasanya meningkat tajam pada POI, sedangkan pada perimenopause peningkatan terjadi secara bertahap. Pedoman Eropa menegaskan bahwa pemeriksaan hormonal berulang membantu membedakan kedua kondisi ini secara objektif (ESHRE Guideline Group, 2024).

Dampak kesehatan yang ditimbulkan juga berbeda tingkat keparahannya. Perimenopause sering menimbulkan keluhan sementara yang berangsur membaik setelah memasuki postmenopause. Menopause dini memberikan paparan defisiensi estrogen lebih lama sehingga risiko osteoporosis, penyakit jantung, dan gangguan psikologis meningkat. Perempuan dengan POI memerlukan pemantauan kesehatan jangka panjang dan terkadang terapi pengganti hormon. Kajian klinis terbaru menyoroti bahwa komplikasi jangka panjang pada POI lebih besar dibandingkan menopause fisiologis (Faubion, 2023).

Dalam praktik pelayanan kesehatan, kedua kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan karena gejalanya tampak mirip. Siklus haid tidak teratur, rasa panas, dan perubahan emosi dapat muncul pada keduanya. Perbedaan usia onset dan hasil pemeriksaan laboratorium menjadi petunjuk penting dalam pengkajian. Anamnesis menyeluruh mengenai riwayat reproduksi, penyakit, serta tindakan medis sebelumnya sangat membantu proses diagnosis. Pendekatan sistematis ini direkomendasikan dalam literatur praktik klinik agar tidak terjadi salah klasifikasi (Santoro et al., 2021).

C. Tanda dan Gejala yang Perlu Diwaspadai

Perubahan hormonal pada masa transisi menopause memengaruhi banyak sistem tubuh sehingga keluhan yang muncul tidak hanya terbatas pada gangguan haid. Penurunan estrogen dan progesteron berdampak pada fungsi termoregulasi, metabolisme, tulang, kardiovaskular, hingga kesehatan psikologis. Akibatnya, gejala yang dirasakan perempuan dapat bersifat fisik, emosional, maupun sosial. Pola keluhan sering muncul bertahap dan berbeda pada tiap individu. Literatur klinis menyebutkan bahwa variasi gejala dipengaruhi usia, status kesehatan, dan sensitivitas tubuh terhadap perubahan hormon (Santoro et al., 2021).

Keluhan yang paling sering dilaporkan adalah **gejala vasomotor**, yaitu rasa panas mendadak pada wajah dan dada (*hot flushes*) serta keringat malam. Sensasi ini dapat berlangsung beberapa detik hingga menit dan sering mengganggu tidur. Tidur yang tidak berkualitas menyebabkan kelelahan, sulit konsentrasi, dan penurunan produktivitas di siang hari. Gejala vasomotor dialami oleh lebih dari setengah perempuan selama transisi menopause. Posisi ini dijelaskan sebagai manifestasi paling khas dalam pedoman manajemen menopause (The North American Menopause Society [NAMS], 2022).

Selain itu, **perubahan pola menstruasi** sering menjadi tanda awal yang mudah dikenali. Siklus dapat memanjang, memendek, atau tidak teratur sebelum akhirnya berhenti total. Volume perdarahan juga bisa lebih banyak atau lebih sedikit dari biasanya. Ketidakteraturan ini berkaitan dengan ovulasi yang tidak konsisten akibat penurunan fungsi ovarium. Tinjauan fisiologi reproduksi menyatakan bahwa gangguan siklus merupakan indikator klinis penting pada fase transisi hormonal (Kapoor, 2023).

Aspek **psikologis dan kognitif** juga sering terdampak. Sebagian perempuan melaporkan mudah cemas, mudah tersinggung, suasana hati berubah-ubah, atau merasa sedih tanpa sebab jelas. Gangguan tidur memperberat keluhan ini sehingga konsentrasi dan daya ingat menurun. Perubahan neurotransmitter akibat rendahnya estrogen diduga berperan dalam gejala emosional tersebut. Penelitian kesehatan mental menunjukkan adanya peningkatan risiko depresi selama masa transisi menopause (Gordon et al., 2020).

Sistem **urogenital dan seksual** mengalami perubahan akibat menurunnya elastisitas jaringan mukosa. Dinding vagina menjadi lebih tipis dan kering sehingga dapat menimbulkan nyeri saat berhubungan, rasa terbakar, atau infeksi berulang. Beberapa perempuan juga mengeluhkan penurunan libido dan inkontinensia urin ringan. Keluhan ini sering tidak disampaikan secara terbuka karena dianggap sensitif. Pedoman klinis menyarankan tenaga kesehatan aktif menanyakan gejala urogenital saat pengkajian (NAMS, 2022). Dalam jangka panjang, **dampak metabolik dan muskuloskeletal** mulai terlihat. Kepadatan tulang menurun sehingga risiko osteoporosis dan fraktur meningkat. Perubahan profil lipid dan fungsi pembuluh darah dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Nyeri sendi, kekakuan otot, serta kenaikan berat badan juga cukup sering dilaporkan. Risiko ini lebih besar pada perempuan dengan menopause dini karena paparan defisiensi estrogen lebih lama. Bukti ilmiah menegaskan perlunya skrining faktor risiko kardiovaskular dan tulang sejak awal (Faubion, 2023; Santoro et al., 2021).

Untuk memudahkan pengkajian, manifestasi klinis utama dapat dirangkum sebagai berikut (Santoro et al., 2021; NAMS, 2022):

- Gejala vasomotor: *hot flushes*, keringat malam
- Gangguan menstruasi: siklus tidak teratur, amenore
- Psikologis: cemas, depresi, mudah marah, sulit fokus
- Urogenital: vagina kering, dispareunia, infeksi berulang
- Muskuloskeletal & metabolik: nyeri sendi, osteoporosis, peningkatan risiko jantung

Pengenalan gejala secara menyeluruh membantu proses pengkajian menjadi lebih sistematis dan mencegah keluhan terlewat. Pendekatan ini memudahkan edukasi serta perencanaan intervensi yang sesuai kebutuhan individu. Literatur praktik kesehatan perempuan merekomendasikan deteksi dini dan konseling aktif pada setiap kunjungan layanan kesehatan (ESHRE Guideline Group, 2024).

BAB 4

Patofisiologi dan Faktor Risiko Menopause Dini

A. Proses Biologis yang Mendasari

Fungsi reproduksi perempuan bergantung pada ketersediaan folikel ovarium yang cukup dan produksi hormon yang stabil. Ketika cadangan folikel menurun lebih cepat dari seharusnya, ovarium kehilangan kemampuan mempertahankan siklus menstruasi normal. Proses ini menjadi dasar terjadinya menopause dini atau *premature ovarian insufficiency* (POI). Gangguan tersebut tidak hanya berkaitan dengan usia, tetapi juga dengan kerusakan biologis pada jaringan ovarium. Literatur endokrinologi modern menggambarkan POI sebagai kegagalan fungsi ovarium sebelum usia 40 tahun akibat gangguan seluler dan hormonal (Kapoor, 2023).

Sejak masa janin, jumlah oosit telah ditentukan dan tidak dapat bertambah kembali. Setiap bulan, sebagian besar folikel mengalami atresia alami meskipun tidak terjadi ovulasi. Kehilangan folikel yang terus-menerus membuat cadangan ovarium semakin menipis. Pada kondisi tertentu, laju kehilangan ini menjadi lebih cepat sehingga fungsi reproduksi berhenti lebih awal. Mekanisme penurunan cadangan folikel dipandang sebagai proses utama dalam patofisiologi menopause dini (Santoro et al., 2021).

Gangguan pada poros hipotalamus–hipofisis–ovarium juga berperan penting dalam perubahan biologis tersebut. Ovarium yang kurang responsif terhadap FSH dan LH menghasilkan estrogen dalam jumlah rendah. Penurunan estrogen memicu hipofisis meningkatkan produksi FSH sebagai bentuk kompensasi. Kadar FSH yang tinggi tetapi tidak efektif merangsang ovarium menjadi ciri khas disfungsi ovarium. Pola hormonal ini sering ditemukan pada pemeriksaan laboratorium perempuan dengan POI (ESHRE Guideline Group, 2024).

Secara seluler, kerusakan dapat terjadi pada sel granulosa dan sel teka yang berperan memproduksi hormon. Stres oksidatif, inflamasi kronis, dan apoptosis sel mempercepat kematian folikel. Akibatnya, kualitas oosit menurun dan proses ovulasi terganggu. Jaringan ovarium menjadi kurang aktif secara metabolik. Tinjauan patofisiologi terbaru menyebutkan bahwa faktor molekuler tersebut mempercepat penuaan ovarium (Faubion, 2023).

Faktor genetik juga memiliki kontribusi yang cukup besar. Mutasi atau kelainan kromosom tertentu dapat mengganggu pembentukan dan pematangan folikel sejak awal kehidupan. Contoh yang sering disebut adalah kelainan kromosom X atau riwayat keluarga dengan menopause dini. Perempuan dengan predisposisi genetik cenderung mengalami penurunan fungsi ovarium lebih cepat dibanding populasi umum. Bukti genetik ini dijelaskan dalam beberapa studi reproduksi molekuler terkini (Kapoor, 2023). Selain faktor bawaan, mekanisme autoimun dapat merusak jaringan ovarium. Sistem imun yang seharusnya melindungi tubuh justru menyerang sel ovarium sehingga fungsi hormon terganggu. Kondisi ini sering berkaitan dengan penyakit autoimun lain seperti tiroiditis atau lupus. Kerusakan imunologis menyebabkan folikel tidak berkembang secara normal. Literatur klinis menyebutkan bahwa etiologi autoimun ditemukan pada sebagian kasus POI idiopatik (ESHRE Guideline Group, 2024).

Paparan tindakan medis tertentu juga berperan dalam kerusakan biologis ovarium. Kemoterapi, radioterapi, dan pembedahan ovarium dapat menghancurkan jaringan folikel secara langsung. Zat sitotoksik mempercepat kematian sel sehingga cadangan ovarium menurun drastis dalam waktu singkat. Efek ini sering disebut sebagai menopause iatrogenik. Tinjauan onkologi reproduksi melaporkan bahwa pasien kanker usia muda memiliki risiko tinggi mengalami gangguan fungsi ovarium setelah terapi (Faubion, 2023).

Secara ringkas, mekanisme biologis menopause dini melibatkan kombinasi penurunan cadangan folikel, gangguan hormonal, kerusakan seluler, faktor genetik, serta paparan eksternal. Proses tersebut menyebabkan produksi estrogen menurun dan siklus haid berhenti lebih cepat dari usia normal. Pemahaman terhadap mekanisme ini membantu tenaga kesehatan mengaitkan antara penyebab biologis dan gejala klinis pasien. Pendekatan berbasis fisiologi memudahkan pengkajian risiko serta perencanaan pencegahan. Literatur praktik kesehatan perempuan menekankan bahwa deteksi dini faktor biologis dapat mengurangi komplikasi jangka panjang (Santoro et al., 2021; Kapoor, 2023).

B. Faktor Genetik

Tidak semua kasus menopause dini dipicu oleh gaya hidup atau penyakit tertentu. Sebagian perempuan mengalami penurunan fungsi ovarium lebih cepat karena faktor bawaan sejak lahir. Susunan genetik memengaruhi jumlah awal folikel, kualitas oosit, serta respons ovarium terhadap hormon. Variasi gen ini dapat menentukan kapan fungsi reproduksi mulai menurun. Literatur endokrinologi reproduksi menegaskan bahwa faktor genetik merupakan salah satu penyebab utama pada kasus *premature ovarian insufficiency* (POI) yang tidak diketahui penyebabnya (Kapoor, 2023).

Riwayat keluarga sering menjadi petunjuk awal adanya pengaruh genetik. Perempuan dengan ibu atau saudara perempuan yang mengalami menopause dini memiliki risiko lebih tinggi mengalami kondisi serupa. Pola ini menunjukkan adanya pewarisan sifat biologis terkait kecepatan penuaan ovarium. Dalam praktik klinik, pertanyaan mengenai usia menopause anggota keluarga penting dimasukkan dalam anamnesis. Bukti epidemiologis menunjukkan bahwa faktor herediter berkontribusi signifikan terhadap variasi usia menopause (Faubion, 2023).

Kelainan kromosom merupakan bentuk faktor genetik yang paling jelas terlihat. Contoh yang sering dibahas adalah gangguan pada kromosom X, seperti sindrom Turner atau mosaikisme kromosom. Kelainan ini menyebabkan perkembangan ovarium tidak sempurna sehingga jumlah folikel sangat sedikit sejak awal kehidupan. Akibatnya, produksi estrogen menurun lebih cepat dan menstruasi berhenti lebih awal. Pedoman ESHRE menyebutkan bahwa evaluasi genetik perlu dipertimbangkan pada perempuan muda dengan amenore primer atau sekunder yang tidak jelas penyebabnya (ESHRE Guideline Group, 2024).

Selain kelainan kromosom besar, mutasi pada gen tertentu juga dapat memengaruhi fungsi ovarium. Beberapa gen berperan dalam pembentukan folikel, pematangan oosit, serta regulasi hormon reproduksi. Gangguan pada gen tersebut dapat mempercepat apoptosis sel granulosa dan mempercepat kehilangan folikel. Penurunan kualitas sel telur terjadi lebih dini sehingga ovulasi menjadi jarang. Kajian molekuler terbaru mengaitkan mutasi gen reproduksi dengan meningkatnya risiko POI (Kapoor, 2023).

Salah satu kondisi genetik yang banyak diteliti adalah ***fragile X premutation (FMR1)***. Perempuan pembawa premutasi gen FMR1 memiliki risiko lebih tinggi mengalami kegagalan ovarium sebelum usia 40 tahun. Mekanismenya berkaitan dengan gangguan fungsi sel ovarium dan percepatan penuaan

folikel. Kondisi ini sering tidak bergejala pada masa kanak-kanak sehingga baru terdeteksi saat gangguan haid muncul. Literatur klinis merekomendasikan skrining genetik pada pasien POI dengan riwayat keluarga tertentu (Faubion, 2023).

Dari sisi patofisiologi, faktor genetik bekerja melalui beberapa mekanisme biologis. Folikel dapat terbentuk lebih sedikit sejak awal, mengalami kerusakan lebih cepat, atau kurang responsif terhadap FSH dan LH. Ketika cadangan folikel sangat rendah, produksi estrogen menurun dan kadar FSH meningkat. Pola hormonal ini sama dengan yang ditemukan pada menopause alami, tetapi terjadi pada usia lebih muda. Gambaran tersebut dijelaskan dalam pedoman diagnosis gangguan ovarium prematur (ESHRE Guideline Group, 2024).

Untuk memudahkan pemahaman, faktor genetik yang berhubungan dengan menopause dini dapat dirangkum sebagai berikut (Kapoor, 2023; Faubion, 2023):

- Riwayat keluarga menopause dini
- Kelainan kromosom X (misalnya sindrom Turner, mosaikisme)
- Mutasi gen pengatur perkembangan folikel
- *Fragile X premutation* (FMR1)
- Gangguan pembentukan atau fungsi sel granulosa

Pengetahuan mengenai faktor genetik membantu tenaga kesehatan melakukan pengkajian risiko lebih awal. Identifikasi pasien dengan riwayat keluarga atau kelainan bawaan memungkinkan rujukan dan pemeriksaan lanjutan dilakukan lebih cepat. Edukasi yang tepat juga membantu pasien memahami bahwa kondisi ini bukan kesalahan pribadi, melainkan bagian dari faktor biologis. Pendekatan ini mendukung konseling yang empatik dan berbasis bukti. Literatur praktik kesehatan perempuan menekankan pentingnya integrasi aspek genetik dalam manajemen POI (ESHRE Guideline Group, 2024; Kapoor, 2023).

C. Status Gizi dan Gaya Hidup

Kondisi tubuh sehari-hari memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan ovarium dan waktu terjadinya menopause. Asupan gizi, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, serta tingkat stres dapat mempercepat atau memperlambat penurunan fungsi reproduksi. Ovarium memerlukan energi dan nutrisi yang cukup untuk memproduksi hormon secara optimal. Ketika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, proses pematangan folikel dapat terganggu. Literatur kesehatan reproduksi menunjukkan bahwa faktor gaya

hidup berkontribusi nyata terhadap variasi usia menopause (Santoro et al., 2021).

Status gizi menjadi salah satu faktor utama yang sering dikaji dalam praktik klinik. Indeks massa tubuh (IMT) yang terlalu rendah berhubungan dengan cadangan lemak tubuh yang sedikit sehingga produksi estrogen menurun. Jaringan lemak berperan dalam konversi hormon androgen menjadi estrogen melalui proses aromatisasi. Perempuan dengan kekurangan gizi kronis atau diet sangat ketat berisiko mengalami gangguan haid hingga amenore. Hubungan antara malnutrisi dan gangguan fungsi ovarium dijelaskan dalam tinjauan endokrinologi terbaru (Kapoor, 2023).

Sebaliknya, kelebihan berat badan dan obesitas juga membawa konsekuensi tersendiri. Lemak berlebih dapat menyebabkan resistensi insulin dan peradangan kronis tingkat rendah yang mengganggu keseimbangan hormonal. Kondisi metabolik ini memengaruhi kualitas folikel dan ovulasi. Obesitas juga berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular setelah menopause. Bukti klinis menunjukkan bahwa berat badan tidak ideal, baik terlalu rendah maupun terlalu tinggi, sama-sama berisiko bagi kesehatan reproduksi (Faubion, 2023).

Kebiasaan merokok memiliki dampak biologis yang lebih langsung terhadap ovarium. Zat toksik dalam rokok dapat merusak sel granulosa dan mempercepat kematian folikel. Paparan nikotin dan radikal bebas meningkatkan stres oksidatif pada jaringan reproduksi. Perempuan perokok dilaporkan mengalami menopause 1–2 tahun lebih cepat dibandingkan non-perokok. Temuan ini konsisten dalam berbagai studi epidemiologi internasional (ESHRE Guideline Group, 2024).

Aktivitas fisik yang seimbang justru memberi efek protektif. Olahraga teratur membantu menjaga berat badan ideal, meningkatkan sirkulasi darah, dan menurunkan stres. Namun latihan fisik yang terlalu berat tanpa asupan nutrisi cukup dapat menekan produksi hormon reproduksi. Atlet atau perempuan dengan aktivitas ekstrem kadang mengalami amenore fungsional. Literatur kesehatan perempuan menekankan pentingnya keseimbangan antara aktivitas dan nutrisi (Santoro et al., 2021).

Tingkat stres psikologis juga memengaruhi poros hipotalamus–hipofisis–ovarium. Stres kronis meningkatkan hormon kortisol yang dapat menghambat pelepasan GnRH. Gangguan ini menyebabkan FSH dan LH tidak stabil sehingga siklus menstruasi terganggu. Dalam jangka panjang, ketidakseimbangan tersebut dapat mempercepat penurunan fungsi

ovarium. Kajian klinis menyebutkan bahwa manajemen stres menjadi bagian penting dari promosi kesehatan reproduksi (Faubion, 2023).

Dalam konteks Indonesia, kondisi gizi dan gaya hidup perempuan sangat dipengaruhi oleh budaya, pekerjaan sehari-hari, serta lingkungan tempat tinggal. Perempuan yang tinggal di wilayah pedesaan dan perkotaan menghadapi tantangan kesehatan reproduksi yang berbeda. Faktor sosial ekonomi, pendidikan kesehatan, serta akses layanan medis ikut membentuk pola tersebut. Situasi ini membuat risiko gangguan fungsi ovarium tidak merata di setiap daerah. Data kependudukan dan kesehatan menunjukkan adanya kesenjangan status kesehatan perempuan antarwilayah di Indonesia (Badan Pusat Statistik [BPS], 2023).

Pada wilayah **rural**, sebagian perempuan masih menghadapi masalah kekurangan gizi, anemia, serta asupan protein yang kurang memadai. Aktivitas fisik berat di sektor pertanian, pekerjaan rumah tangga, dan kerja informal meningkatkan kebutuhan energi harian. Ketika kebutuhan nutrisi tidak terpenuhi, tubuh menghemat energi dengan menekan fungsi reproduksi. Kondisi ini dapat memicu siklus haid tidak teratur hingga amenore fungsional. Literatur fisiologi reproduksi menjelaskan bahwa malnutrisi kronis berhubungan dengan penurunan produksi estrogen dan gangguan ovulasi (Santoro et al., 2021).

Sebaliknya, perempuan di wilayah **urban** cenderung menghadapi pola hidup sedentari dengan aktivitas fisik minimal. Konsumsi makanan cepat saji, tinggi gula, dan tinggi lemak lebih sering ditemukan pada kelompok ini. Peningkatan berat badan, obesitas, serta stres kerja dapat mengganggu keseimbangan hormon reproduksi. Gangguan metabolik seperti resistensi insulin dan inflamasi kronis ikut memengaruhi kualitas folikel ovarium. Tinjauan klinis menyebutkan bahwa obesitas dan stres berkepanjangan berkontribusi terhadap percepatan penuaan ovarium (Faubion, 2023).

Perbedaan karakteristik antara rural dan urban menunjukkan bahwa faktor risiko menopause dini tidak selalu sama, tetapi sama-sama signifikan. Pendekatan promotif perlu disesuaikan dengan konteks lokal, misalnya edukasi gizi dan suplementasi zat besi di pedesaan, serta program aktivitas fisik dan manajemen stres di perkotaan. Perawat komunitas memiliki peran penting dalam mengidentifikasi kebiasaan hidup yang berisiko dan memberikan intervensi sederhana berbasis keluarga.

Strategi yang kontekstual membuat pesan kesehatan lebih mudah diterima masyarakat. Pendekatan berbasis populasi seperti ini direkomendasikan dalam praktik kesehatan perempuan modern (ESHRE Guideline Group, 2024; Santoro et al., 2021).

D. Penyakit Kronis dan Tindakan Medis

Kesehatan ovarium tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh kondisi sistemik tubuh secara keseluruhan. Penyakit kronis yang berlangsung lama dapat mengganggu keseimbangan hormonal dan metabolisme sel reproduksi. Ketika tubuh berada dalam keadaan inflamasi atau stres metabolik berkepanjangan, fungsi ovarium ikut terdampak. Proses ini dapat mempercepat penurunan cadangan folikel dan mengganggu ovulasi. Literatur kesehatan reproduksi menyebutkan bahwa penyakit kronis menjadi salah satu faktor penting pada terjadinya menopause dini (Faubion, 2023).

Gangguan endokrin seperti diabetes melitus dan penyakit tiroid sering dikaitkan dengan ketidakteraturan siklus haid. Resistensi insulin pada diabetes memengaruhi kerja hormon reproduksi dan kualitas oosit. Disfungsi tiroid juga dapat mengubah pelepasan GnRH, FSH, dan LH sehingga ovulasi terganggu. Siklus menstruasi menjadi lebih jarang atau tidak teratur. Kajian klinis menunjukkan bahwa perempuan dengan gangguan metabolik memiliki risiko gangguan fungsi ovarium lebih tinggi dibanding populasi sehat (Santoro et al., 2021).

Survei kesehatan nasional di Indonesia menunjukkan bahwa masalah **ketidakteraturan siklus menstruasi** cukup sering terjadi pada perempuan usia reproduktif, yang bisa menjadi tanda awal gangguan fungsi ovarium bila berlangsung terus-menerus. Berdasarkan **Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018**, sekitar **13,7% perempuan berusia 10–59 tahun** melaporkan mengalami menstruasi tidak teratur dalam satu tahun terakhir, menunjukkan bahwa satu dari sembilan perempuan mengalami gangguan siklus yang nyata dalam periode tersebut (Riskesdas, 2018). Survei yang sama juga melaporkan bahwa di kalangan **remaja usia 15–19 tahun**, prevalensi menstruasi tidak teratur mencapai sekitar **11,7%, dan di beberapa kota besar angka ini lebih tinggi sekitar 14,9%**. Perbedaan prevalensi antarwilayah lokal juga terlihat, misalnya pada survey di beberapa provinsi seperti Sumatera Barat yang mencapai hampir 19% dan di provinsi lain di kisaran 10–11% (Fitri, Sofianita, & Octaria, 2024).

Gangguan siklus menstruasi dapat mencerminkan **ketidakseimbangan hormon, gangguan ovulasi, atau dampak kondisi kesehatan lain** (misalnya stres, nutrisi buruk, atau penyakit kronis) yang berpengaruh pada sistem reproduksi perempuan. Angka-angka ini memberikan gambaran bahwa masalah reproduksi yang terkait hormon tidak hanya terjadi sporadis, tetapi dialami oleh bagian substansial populasi perempuan Indonesia. Meskipun data nasional yang secara khusus mengukur **menopause dini atau kegagalan ovarium prematur (POI)** di Indonesia belum tersedia secara representatif, tingginya prevalensi gangguan haid ini menunjukkan adanya kelompok perempuan yang berisiko lebih tinggi mengalami gangguan fungsi ovarium jangka panjang. Hal ini penting dipahami dalam konteks layanan kesehatan reproduksi dan pencegahan, terutama di tingkat primer dan komunitas. Data seperti ini sering dijadikan dasar dalam perencanaan program kesehatan wanita yang lebih terfokus pada deteksi dini dan edukasi siklus menstruasi yang sehat.

Penyakit autoimun juga berperan dalam kerusakan jaringan ovarium. Pada kondisi ini, sistem imun menyerang sel tubuh sendiri, termasuk sel granulosa dan folikel. Kerusakan imunologis menghambat produksi estrogen dan mempercepat kematian oosit. Beberapa penyakit yang sering dikaitkan antara lain tiroiditis autoimun, lupus, dan penyakit Addison. Pedoman ESHRE menjelaskan bahwa etiologi autoimun ditemukan pada sebagian kasus *premature ovarian insufficiency* yang tidak diketahui penyebabnya (ESHRE Guideline Group, 2024).

Infeksi kronis dan penyakit inflamasi sistemik dapat menimbulkan dampak serupa. Peradangan jangka panjang meningkatkan pelepasan sitokin proinflamasi yang merusak sel ovarium. Lingkungan sel yang tidak stabil mempercepat proses apoptosis folikel. Akibatnya, cadangan ovarium berkurang lebih cepat dari normal. Mekanisme inflamasi ini dijelaskan dalam tinjauan patofisiologi gangguan reproduksi perempuan (Kapoor, 2023).

Paparan terapi medis tertentu dapat memengaruhi fungsi ovarium secara langsung karena sifatnya yang merusak sel reproduksi. Beberapa prosedur pengobatan tidak hanya menargetkan sel penyakit, tetapi juga berdampak pada jaringan sehat yang aktif membelah, termasuk folikel ovarium. Sel folikel memiliki aktivitas metabolik tinggi sehingga sensitif terhadap obat sitotoksik dan radiasi. Ketika kerusakan terjadi, cadangan oosit menurun lebih cepat dari proses penuaan normal. Mekanisme inilah yang mendasari terjadinya menopause dini akibat faktor iatrogenik atau terapi medis (Faubion, 2023). Kemoterapi merupakan penyebab medis yang paling sering dikaitkan dengan gangguan fungsi ovarium. Obat kemoterapi bekerja dengan

menghentikan pembelahan sel kanker, tetapi efeknya juga mengenai sel granulosa dan oosit di ovarium. Kerusakan ini dapat bersifat akut sehingga menstruasi berhenti segera setelah beberapa siklus terapi. Pada sebagian pasien, amenore hanya sementara, namun pada kasus lain dapat menjadi permanen. Tinjauan klinis menunjukkan bahwa jenis obat, dosis, dan usia pasien memengaruhi tingkat kerusakan ovarium setelah kemoterapi (Kapoor, 2023).

Radioterapi pada area panggul atau abdomen bawah juga memberikan risiko yang signifikan terhadap kesehatan reproduksi. Radiasi dapat merusak DNA sel ovarium dan mengganggu proses pembelahan sel, sehingga folikel kehilangan kemampuan berkembang. Efek ini sering bersifat irreversibel, terutama bila paparan dosis tinggi atau diberikan berulang. Perempuan usia muda justru lebih rentan karena jaringan ovarium masih aktif secara biologis. Pedoman praktik reproduksi menyarankan konseling fertilitas sebelum terapi radiasi dimulai untuk meminimalkan dampak jangka panjang (ESHRE Guideline Group, 2024).

Tindakan bedah ginekologi juga dapat memicu penurunan fungsi ovarium, baik secara langsung maupun tidak langsung. Operasi pengangkatan ovarium menyebabkan berhentinya produksi hormon secara tiba-tiba, sedangkan pembedahan parsial dapat mengganggu aliran darah ke jaringan ovarium. Gangguan perfusi ini membuat sel-sel folikel kekurangan oksigen dan nutrisi sehingga fungsi hormon menurun lebih cepat. Dalam praktik klinik, kondisi ini dikenal sebagai menopause iatrogenik dan perlu diantisipasi melalui edukasi serta pemantauan siklus haid pascaoperasi. Literatur kesehatan perempuan menekankan pentingnya kolaborasi antara dokter dan perawat untuk mempersiapkan pasien menghadapi perubahan reproduksi setelah tindakan medis (Santoro et al., 2021).

Penggunaan obat jangka panjang tertentu juga dapat memengaruhi keseimbangan hormon. Beberapa terapi immunosupresif atau obat sitotoksik memiliki efek samping pada sistem reproduksi. Penekanan fungsi hormonal menyebabkan ovulasi tidak teratur atau berhenti sementara. Pada sebagian kasus, efeknya bisa menetap. Kajian farmakologi reproduksi menyarankan pemantauan siklus haid pada pasien yang menggunakan obat-obatan tersebut (Kapoor, 2023).

Dari sudut pandang klinis, faktor penyakit dan tindakan medis sering saling berkaitan. Pasien kanker, penyakit autoimun, atau gangguan metabolik biasanya menjalani terapi yang juga berisiko bagi ovarium. Kombinasi antara penyakit dasar dan efek terapi memperbesar kemungkinan terjadinya

menopause dini. Situasi ini memerlukan pengkajian komprehensif dan kolaborasi antarprofesi. Pendekatan multidisiplin direkomendasikan dalam pedoman praktik kesehatan perempuan (Faubion, 2023).

Pemahaman mengenai faktor medis ini membantu tenaga keperawatan melakukan skrining lebih awal pada kelompok berisiko. Riwayat penyakit kronis, terapi kanker, atau pembedahan ginekologi perlu digali secara detail saat pengkajian. Edukasi mengenai kemungkinan perubahan siklus haid juga penting diberikan sebelum tindakan medis dilakukan. Deteksi dini memungkinkan perencanaan pencegahan dan dukungan psikologis yang lebih baik. Literatur praktik klinik menegaskan bahwa peran keperawatan sangat penting dalam pemantauan jangka panjang kesehatan reproduksi perempuan (ESHRE Guideline Group, 2024; Santoro et al., 2021).

E. Faktor Psikososial dan Lingkungan

Kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga oleh kondisi psikologis dan lingkungan tempat hidup sehari-hari. Tubuh merespons stres emosional, tekanan sosial, serta paparan lingkungan melalui perubahan hormonal yang kompleks. Sistem reproduksi sangat sensitif terhadap perubahan tersebut karena dikendalikan langsung oleh otak dan sistem endokrin. Ketika keseimbangan ini terganggu dalam waktu lama, fungsi ovarium dapat ikut terpengaruh. Literatur kesehatan perempuan menempatkan faktor psikososial sebagai komponen penting dalam risiko gangguan fungsi ovarium, termasuk menopause dini (Faubion, 2023).

Stres kronis menjadi salah satu faktor psikologis yang paling sering dikaitkan dengan gangguan siklus haid. Tekanan emosional meningkatkan hormon kortisol yang dapat menghambat pelepasan GnRH dari hipotalamus. Penurunan GnRH berdampak pada turunnya FSH dan LH sehingga ovulasi menjadi tidak teratur. Jika kondisi ini berlangsung lama, produksi estrogen ikut menurun. Mekanisme ini dijelaskan dalam tinjauan endokrinologi reproduksi sebagai hubungan langsung antara stres dan disfungsi ovarium (Santoro et al., 2021).

Gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan juga memiliki dampak fisiologis terhadap sistem hormonal. Perubahan neurotransmiter memengaruhi regulasi hipotalamus dan mengganggu irama hormonal normal. Perempuan dengan beban psikologis berat sering melaporkan siklus haid memanjang atau berhenti sementara. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan emosional berperan dalam stabilitas reproduksi. Studi

kesehatan mental perempuan menegaskan bahwa depresi berkaitan dengan gangguan menstruasi dan kualitas hidup yang lebih rendah (Gordon et al., 2020).

Faktor sosial ekonomi turut memberi pengaruh tidak langsung terhadap kesehatan ovarium. Pendapatan rendah dapat membatasi akses terhadap gizi yang baik, layanan kesehatan, dan informasi reproduksi. Perempuan mungkin menunda pemeriksaan ketika muncul gangguan haid. Kurangnya dukungan sosial juga meningkatkan stres psikologis. Pedoman kesehatan masyarakat menyatakan bahwa determinan sosial kesehatan memengaruhi risiko gangguan reproduksi pada populasi perempuan (World Health Organization [WHO], 2022).

Lingkungan kerja juga berkontribusi terhadap perubahan hormonal. Pekerjaan dengan beban fisik berat atau jam kerja panjang dapat menyebabkan kelelahan kronis. Tubuh yang terus-menerus berada dalam kondisi stres fisik cenderung menekan fungsi reproduksi sebagai mekanisme adaptasi. Beberapa perempuan pekerja *shift* malam mengalami gangguan ritme sirkadian yang memengaruhi sekresi hormon. Gangguan ritme biologis ini dikaitkan dengan ketidakaturan menstruasi dalam beberapa penelitian klinis (Santoro et al., 2021).

Paparan bahan kimia lingkungan turut mendapat perhatian dalam kajian terbaru. Zat seperti pestisida, logam berat, dan *endocrine disrupting chemicals* dapat mengganggu kerja hormon estrogen. Senyawa ini meniru atau menghambat aktivitas hormon alami sehingga keseimbangan endokrin berubah. Dalam jangka panjang, paparan tersebut berpotensi mempercepat penurunan cadangan folikel. Literatur reproduksi modern menyebutkan bahwa faktor lingkungan perlu dipertimbangkan dalam evaluasi kasus menopause dini (Kapoor, 2023).

Kondisi tempat tinggal juga memengaruhi kesehatan reproduksi perempuan. Wilayah dengan polusi udara tinggi atau sanitasi buruk dapat meningkatkan stres oksidatif dan inflamasi sistemik. Proses inflamasi kronis berdampak pada kualitas sel ovarium. Perempuan yang tinggal di lingkungan dengan akses kesehatan terbatas mungkin tidak mendapatkan deteksi dini gangguan haid. Faktor lingkungan fisik dan akses layanan ini termasuk determinan penting dalam kesehatan perempuan (WHO, 2022).

Perkembangan kota-kota besar di Indonesia membawa perubahan besar pada pola hidup dan kualitas lingkungan masyarakat. Urbanisasi yang cepat sering diikuti peningkatan kepadatan penduduk, kemacetan, serta paparan

polusi udara yang tinggi. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada penyakit pernapasan, tetapi juga memengaruhi sistem hormonal melalui stres oksidatif dan inflamasi kronis. Paparan jangka panjang terhadap polutan dapat mengganggu fungsi sel, termasuk sel ovarium. Laporan kesehatan lingkungan menegaskan bahwa kualitas udara perkotaan berhubungan dengan berbagai masalah kesehatan reproduksi perempuan (World Health Organization [WHO], 2022).

Di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan, tingkat polusi udara sering melebihi batas aman harian. Partikel halus (PM_{2.5}), asap kendaraan, dan emisi industri dapat masuk ke sirkulasi darah dan memicu peradangan sistemik. Inflamasi ini meningkatkan stres oksidatif yang berpotensi merusak jaringan reproduksi, termasuk folikel ovarium. Beberapa studi reproduksi modern menunjukkan bahwa paparan polusi kronis dikaitkan dengan gangguan ovulasi dan ketidakaturan menstruasi. Mekanisme tersebut dijelaskan sebagai salah satu faktor lingkungan yang dapat mempercepat penuaan ovarium (Kapoor, 2023).

Masalah kualitas air juga menjadi perhatian penting di wilayah perkotaan. Akses terhadap air bersih tidak selalu merata, terutama di kawasan padat penduduk atau permukiman informal. Air yang terkontaminasi logam berat, limbah domestik, atau bahan kimia industri dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan sistemik. Paparan bahan toksik tertentu diketahui berperan sebagai *endocrine disrupting chemicals* yang mengganggu kerja hormon estrogen. Literatur kesehatan masyarakat menyebutkan bahwa paparan zat kimia lingkungan dapat memengaruhi keseimbangan hormon reproduksi perempuan (WHO, 2022).

Selain faktor fisik, kehidupan perkotaan sering disertai tekanan psikososial yang tinggi. Beban kerja panjang, waktu perjalanan yang lama, serta tuntutan ekonomi meningkatkan stres kronis pada perempuan usia produktif. Stres ini memengaruhi poros hipotalamus–hipofisis–ovarium dan dapat mengganggu pelepasan hormon reproduksi. Siklus haid menjadi tidak teratur atau lebih pendek akibat gangguan regulasi hormonal. Kajian klinis menunjukkan bahwa stres kronis berhubungan dengan disfungsi menstruasi dan penurunan kualitas hidup perempuan (Santoro et al., 2021).

Gabungan antara polusi udara, kualitas air yang kurang baik, dan tekanan psikososial menjadikan lingkungan perkotaan sebagai faktor risiko kompleks bagi kesehatan reproduksi. Dampaknya mungkin tidak terlihat secara langsung, tetapi berlangsung perlahan melalui proses inflamasi, toksisitas, dan gangguan hormonal. Perempuan yang tinggal di kota besar

membutuhkan pemantauan kesehatan reproduksi yang lebih aktif, termasuk edukasi dan skrining rutin. Pendekatan promotif seperti gaya hidup sehat, pengurangan paparan polutan, dan manajemen stres menjadi bagian penting dalam pencegahan. Literatur praktik kesehatan perempuan menekankan bahwa faktor lingkungan harus dipertimbangkan dalam penilaian risiko menopause dini (Faubion, 2023; Kapoor, 2023).

Dalam konteks budaya Indonesia, tekanan sosial dan peran ganda perempuan sering menambah beban psikologis. Banyak perempuan harus menjalankan tanggung jawab rumah tangga sekaligus bekerja di luar rumah. Tuntutan ini dapat menyebabkan kelelahan mental dan fisik yang berkepanjangan. Di beberapa daerah, pembicaraan tentang kesehatan reproduksi masih dianggap tabu sehingga keluhan jarang disampaikan. Situasi ini membuat gangguan hormonal tidak terdeteksi lebih awal dalam praktik pelayanan kesehatan.

Perbedaan antara wilayah urban dan rural juga terlihat pada faktor psikososial. Di perkotaan, stres kerja, kemacetan, dan gaya hidup cepat sering mendominasi. Di pedesaan, beban kerja fisik berat dan keterbatasan fasilitas kesehatan lebih menonjol. Kedua kondisi tersebut sama-sama berpotensi memengaruhi keseimbangan hormon reproduksi. Pendekatan kesehatan masyarakat perlu disesuaikan dengan karakteristik lingkungan masing-masing wilayah (WHO, 2022).

Nilai budaya dan norma sosial di Indonesia masih menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama urusan domestik. Peran sebagai ibu, istri, dan pengelola rumah tangga sering dianggap kewajiban utama meskipun perempuan juga bekerja di luar rumah. Kombinasi tanggung jawab ganda ini meningkatkan beban fisik dan mental sehari-hari. Kelelahan kronis dapat memengaruhi keseimbangan hormon melalui peningkatan kortisol dan stres berkepanjangan. Literatur kesehatan perempuan menunjukkan bahwa tekanan psikososial jangka panjang berhubungan dengan gangguan siklus menstruasi dan fungsi reproduksi (Santoro et al., 2021).

Di beberapa komunitas, pembicaraan mengenai menstruasi, infertilitas, atau menopause masih dianggap hal yang tabu. Perempuan cenderung menyimpan keluhan sendiri karena takut dianggap lemah atau tidak subur. Akibatnya, gejala seperti haid tidak teratur atau amenore sering tidak dilaporkan ke tenaga kesehatan. Keterlambatan mencari bantuan menyebabkan gangguan fungsi ovarium tidak terdeteksi pada tahap awal. Pendekatan kesehatan masyarakat menekankan bahwa stigma budaya

menjadi hambatan penting dalam pelayanan kesehatan reproduksi (World Health Organization [WHO], 2022).

Tradisi tertentu juga dapat memengaruhi pola nutrisi dan kesehatan perempuan. Di beberapa daerah, perempuan makan terakhir setelah anggota keluarga lain sehingga asupan gizinya kurang optimal. Kondisi ini berisiko menyebabkan anemia dan kekurangan energi kronis. Kekurangan nutrisi berdampak pada produksi hormon reproduksi dan kualitas ovulasi. Kajian klinis menyebutkan bahwa malnutrisi berkaitan dengan gangguan menstruasi dan penurunan fungsi ovarium (Faubion, 2023).

Selain itu, ekspektasi sosial mengenai peran perempuan sebagai pengasuh utama keluarga sering membatasi waktu untuk perawatan diri. Banyak perempuan menunda pemeriksaan kesehatan karena lebih memprioritaskan kebutuhan anak dan keluarga. Kebiasaan ini membuat skrining kesehatan reproduksi jarang dilakukan secara rutin. Gangguan hormonal yang sebenarnya dapat ditangani lebih awal menjadi terlambat teridentifikasi. Literatur praktik kesehatan perempuan menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan agar lebih aktif menjaga kesehatannya sendiri (Kapoor, 2023).

Tabel 4.1 Faktor Psikososial & Budaya Indonesia, Dampak Hormonal, dan Implikasi Keperawatan

Faktor psikososial & budaya	Mekanisme biologis/hormonal	Dampak klinis pada reproduksi
Beban peran ganda (rumah tangga + kerja)	Stres kronis ↑ kortisol → hambatan GnRH → FSH/LH tidak stabil	Siklus haid tidak teratur, anovulasi, kelelahan
Tekanan ekonomi/kemiskinan	Asupan gizi rendah → estrogen rendah	Amenore fungsional, anemia, gangguan ovulasi
Budaya tabu bicara menstruasi/menopause	Keterlambatan mencari layanan → gangguan tidak tertangani	Diagnosis terlambat POI/menopause dini
Perempuan makan terakhir/kurang prioritas nutrisi	Defisit energi kronis → gangguan hormon reproduksi	Haid jarang, infertilitas, penurunan berat badan
Stres kerja urban (shift, lembur, commuting lama)	Gangguan ritme sirkadian → disrupsi hormonal	PMS berat, insomnia, haid tidak teratur
Polusi udara perkotaan (PM2.5, emisi)	Stres oksidatif & inflamasi → kerusakan folikel	Penuaan ovarium lebih cepat

Air tercemar/kimia (endocrine disruptors)	Gangguan reseptor estrogen	Ketidakseimbangan hormon
Dukungan sosial rendah	Tekanan psikologis ↑	Depresi, gangguan libido, kualitas hidup menurun
Beban kerja fisik berat (rural/pertanian)	Defisit energi & stres fisik	Amenore fungsional
Kurangnya literasi kesehatan reproduksi	Perilaku pencegahan rendah	Gejala diabaikan

Secara keseluruhan, faktor psikososial dan lingkungan bekerja melalui jalur stres hormonal, inflamasi, serta perubahan perilaku kesehatan. Dampaknya mungkin tidak terlihat secara langsung, tetapi dapat mempercepat penurunan fungsi ovarium jika berlangsung lama. Pemahaman terhadap aspek ini membantu tenaga keperawatan melakukan pengkajian yang lebih holistik, tidak hanya fokus pada gejala fisik. Edukasi mengenai manajemen stres, dukungan sosial, dan lingkungan sehat menjadi bagian penting dari pencegahan. Literatur praktik kesehatan perempuan merekomendasikan pendekatan biopsikososial dalam penanganan menopause dini (Faubion, 2023; Santoro et al., 2021).

BAB 5

Dampak Menopause Dini Terhadap Kesehatan dan Kualitas Hidup

A. Perubahan Fisik

Perubahan fisik pada menopause dini muncul ketika kadar estrogen menurun lebih cepat dari usia reproduksi normal. Hormon estrogen memiliki peran penting dalam menjaga fungsi berbagai sistem tubuh, bukan hanya sistem reproduksi. Ketika produksi hormon ini turun mendadak, tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Akibatnya, banyak keluhan somatik muncul dalam waktu relatif singkat. Literatur klinis menjelaskan bahwa defisiensi estrogen dini memicu gangguan multisistem pada perempuan usia muda (Faubion, 2023).

Keluhan yang paling sering dirasakan adalah gejala vasomotor seperti *hot flashes* dan keringat malam. Sensasi panas biasanya muncul tiba-tiba di wajah, leher, dan dada, kemudian diikuti berkeringat berlebihan. Episode ini dapat terjadi berulang kali dalam sehari dan mengganggu aktivitas. Pada malam hari, keringat berlebih menyebabkan tidur terbangun dan istirahat menjadi tidak berkualitas. Pedoman praktik menopause menyebutkan bahwa lebih dari separuh perempuan dengan defisiensi estrogen mengalami gejala vasomotor sedang hingga berat (The North American Menopause Society [NAMS], 2022).

Gangguan tidur menjadi dampak fisik berikutnya yang sering dikeluhkan. Perempuan dapat mengalami sulit tidur, sering terbangun, atau merasa tidak segar saat bangun pagi. Kurang tidur memicu kelelahan, sakit kepala, dan penurunan konsentrasi di siang hari. Kondisi ini juga memengaruhi produktivitas kerja dan aktivitas sosial. Hubungan antara menopause dan

gangguan tidur dijelaskan dalam tinjauan klinis kesehatan perempuan modern (Santoro et al., 2021).

Perubahan pada sistem muskuloskeletal juga cukup nyata. Estrogen berperan mempertahankan keseimbangan antara pembentukan dan resorpsi tulang. Ketika hormon menurun, proses kehilangan massa tulang berlangsung lebih cepat. Kepadatan tulang berkurang sehingga risiko osteopenia dan osteoporosis meningkat. Risiko ini lebih besar pada menopause dini karena paparan defisiensi hormon berlangsung lebih lama (ESHRE Guideline Group, 2024).

Selain tulang, keluhan nyeri sendi dan otot sering dilaporkan. Beberapa perempuan merasa tubuh lebih kaku terutama pada pagi hari. Nyeri ringan pada punggung, lutut, atau bahu dapat muncul tanpa penyebab jelas. Penurunan estrogen diduga memengaruhi jaringan kolagen dan pelumasan sendi. Literatur menyebutkan bahwa keluhan muskuloskeletal termasuk gejala somatik umum pada transisi menopause (Santoro et al., 2021).

Sistem kardiovaskular turut mengalami perubahan akibat defisiensi estrogen. Hormon ini sebelumnya membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan profil lipid yang sehat. Penurunan estrogen dapat meningkatkan kolesterol LDL dan menurunkan HDL. Kondisi tersebut memperbesar risiko aterosklerosis dan penyakit jantung koroner. Tinjauan epidemiologi menunjukkan bahwa perempuan dengan menopause dini memiliki risiko kardiovaskular lebih tinggi dibandingkan menopause fisiologis (Faubion, 2023).

Perubahan metabolik juga sering muncul dalam bentuk kenaikan berat badan. Distribusi lemak tubuh bergeser ke area perut sehingga lingkaran pinggang meningkat. Metabolisme basal cenderung melambat sehingga pembakaran kalori berkurang. Kombinasi ini meningkatkan risiko sindrom metabolik dan diabetes tipe 2. Studi klinis mengaitkan defisiensi estrogen dengan perubahan komposisi tubuh dan resistensi insulin (Santoro et al., 2021).

Pada sistem urogenital, penurunan estrogen menyebabkan atrofi mukosa vagina dan saluran kemih. Dinding vagina menjadi lebih tipis, kering, dan kurang elastis. Keluhan yang sering muncul antara lain rasa terbakar, gatal, atau nyeri saat berhubungan seksual. Beberapa perempuan juga mengalami infeksi saluran kemih berulang. Pedoman NAMS menekankan bahwa gejala genitourinari merupakan dampak fisik penting yang memengaruhi kenyamanan hidup (NAMS, 2022).

Kulit dan rambut turut mengalami perubahan seiring penurunan hormon. Produksi kolagen berkurang sehingga kulit terasa lebih kering dan elastisitas menurun. Rambut dapat menjadi lebih tipis atau mudah rontok. Proses penyembuhan luka juga cenderung lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Perubahan ini berkaitan dengan fungsi estrogen dalam mempertahankan struktur jaringan ikat (Kapoor, 2023).

B. Dampak Psikologis dan Emosional

Perubahan hormonal pada menopause dini tidak hanya memengaruhi tubuh, tetapi juga kondisi emosional dan mental. Penurunan kadar estrogen berhubungan erat dengan regulasi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin. Kedua zat ini berperan dalam menjaga suasana hati, motivasi, dan rasa nyaman. Ketika keseimbangannya terganggu, perempuan lebih mudah mengalami perubahan emosi. Literatur klinis menyebutkan bahwa gangguan psikologis sering muncul bersamaan dengan gejala fisik menopause (Santoro et al., 2021).

Keluhan yang paling sering dilaporkan adalah perubahan suasana hati yang cepat atau *mood swing*. Perempuan dapat merasa mudah marah, sensitif, atau sedih tanpa penyebab jelas. Kondisi ini sering membingungkan pasien maupun keluarga. Fluktuasi hormon membuat respons emosional menjadi kurang stabil. Gejala tersebut dijelaskan sebagai efek langsung dari defisiensi estrogen pada sistem saraf pusat (Kapoor, 2023).

Kecemasan juga menjadi masalah psikologis yang cukup dominan. Rasa khawatir berlebihan, gelisah, atau sulit tenang sering muncul terutama pada malam hari. Gangguan tidur akibat *hot flushes* dapat memperburuk perasaan cemas. Kombinasi kelelahan dan kecemasan menurunkan kualitas hidup sehari-hari. Penelitian kesehatan perempuan menunjukkan bahwa risiko ansietas meningkat selama transisi menopause (Gordon et al., 2020).

Gambaran perubahan suasana hati (*mood swing*) sering terlihat jelas dalam keseharian pasien. Seorang perempuan dapat merasa baik pada pagi hari, namun beberapa jam kemudian menjadi mudah tersinggung tanpa alasan yang jelas. Respons emosinya tampak berlebihan terhadap situasi kecil, misalnya suara bising atau komentar sederhana dari anggota keluarga. Perubahan ini bukan semata-mata faktor kepribadian, tetapi berkaitan dengan fluktuasi hormon estrogen yang memengaruhi kerja neurotransmitter otak. Literatur klinis menjelaskan bahwa defisiensi estrogen berhubungan langsung dengan ketidakstabilan emosi selama transisi menopause (Kapoor, 2023).

Sebagai contoh, seorang pasien usia 38 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan cepat marah dan sering menangis dalam dua bulan terakhir. Ia merasa bersalah karena mudah membentak anaknya, padahal sebelumnya dikenal sabar. Selain itu, pasien melaporkan haid mulai jarang dan muncul rasa panas di malam hari. Kondisi ini membuatnya sulit tidur dan semakin mudah lelah pada siang hari. Kombinasi gejala fisik dan emosional seperti ini sering ditemukan pada perempuan dengan penurunan kadar estrogen (Santoro et al., 2021).

Contoh lain terlihat pada perempuan pekerja kantoran yang mengeluhkan sulit fokus dan mudah cemas saat bekerja. Ia merasa tidak percaya diri ketika presentasi karena pikirannya terasa “kosong” dan mudah lupa. Keluhan tersebut muncul bersamaan dengan menstruasi yang tidak teratur dan nyeri sendi ringan. Situasi ini membuat performa kerja menurun dan meningkatkan stres psikologis. Studi kesehatan mental perempuan menyebutkan bahwa gangguan kognitif ringan dan kecemasan sering menyertai transisi menopause (Gordon et al., 2020).

Depresi merupakan kondisi yang perlu mendapat perhatian khusus. Perempuan dengan menopause dini memiliki risiko depresi lebih tinggi dibandingkan mereka yang mengalami menopause pada usia normal. Perasaan kehilangan fungsi reproduksi, perubahan citra diri, serta kekhawatiran tentang kesehatan sering memperberat kondisi ini. Gejala dapat berupa hilang minat, mudah lelah, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Literatur epidemiologi menegaskan adanya hubungan signifikan antara defisiensi estrogen dan gangguan depresi (Gordon et al., 2020).

Gambaran depresi pada menopause dini sering muncul secara perlahan dan tidak selalu dikenali sejak awal. Seorang perempuan dapat merasa kehilangan semangat melakukan aktivitas yang sebelumnya disukai. Perasaan sedih berlangsung hampir setiap hari tanpa pemicu yang jelas. Energi tubuh menurun meskipun tidak melakukan pekerjaan berat. Kondisi ini berkaitan dengan penurunan estrogen yang memengaruhi regulasi serotonin di otak (Gordon et al., 2020).

Sebagai contoh, seorang pasien berusia 37 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan cepat lelah, sulit tidur, dan tidak bersemangat bekerja. Ia mengatakan sudah dua bulan terakhir tidak tertarik mengikuti kegiatan sosial atau bertemu teman. Pasien juga merasa dirinya “tidak berguna” karena menstruasi berhenti dan khawatir tidak bisa memiliki anak lagi. Nafsu makan menurun dan berat badan turun beberapa kilogram. Riwayat menunjukkan

haid tidak teratur selama setahun terakhir, disertai *hot flushes* yang sering muncul malam hari (Santoro et al., 2021).

Dalam wawancara lanjutan, pasien mengaku sering menangis sendiri dan merasa putus asa tanpa alasan jelas. Keluarga awalnya mengira pasien hanya kelelahan biasa. Namun gejala menetap lebih dari dua minggu dan mengganggu fungsi sehari-hari. Kondisi ini sesuai dengan tanda depresi ringan hingga sedang. Literatur kesehatan mental menyatakan bahwa perempuan dengan defisiensi estrogen dini memiliki risiko depresi lebih tinggi dibandingkan populasi umum (Faubion, 2023).

Gangguan kognitif ringan juga dapat muncul selama periode ini. Beberapa perempuan melaporkan sulit berkonsentrasi atau mudah lupa. Keluhan ini sering disebut sebagai *brain fog*. Aktivitas kerja atau belajar menjadi terasa lebih berat dari biasanya. Penurunan fungsi kognitif dikaitkan dengan perubahan hormon yang memengaruhi aliran darah otak dan neurotransmitter (Santoro et al., 2021).

Masalah psikologis sering diperparah oleh gangguan tidur kronis. Kurang tidur memengaruhi stabilitas emosi dan kemampuan berpikir jernih. Tubuh yang tidak cukup istirahat lebih rentan terhadap stres. Siklus kelelahan dan emosi negatif dapat berulang setiap hari. Literatur klinis menyatakan bahwa manajemen tidur menjadi bagian penting dalam perawatan menopause (NAMS, 2022).

Aspek citra tubuh juga mengalami perubahan. Kenaikan berat badan, kulit kering, atau rambut rontok dapat menurunkan rasa percaya diri. Beberapa perempuan merasa tidak lagi menarik atau produktif. Perasaan ini dapat memengaruhi hubungan interpersonal dan kehidupan sosial. Studi psikososial menunjukkan bahwa persepsi diri memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan mental perempuan menopause (Faubion, 2023).

Hubungan dengan pasangan dan keluarga kadang ikut terdampak. Penurunan libido atau dispareunia dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan intim. Kurangnya komunikasi sering menyebabkan kesalahpahaman. Kondisi emosional yang tidak stabil juga memengaruhi pola interaksi sehari-hari. Literatur praktik kesehatan perempuan menekankan pentingnya dukungan keluarga dalam menghadapi masa transisi ini (Kapoor, 2023).

Lingkungan sosial dan budaya dapat memperberat beban psikologis. Di beberapa masyarakat, menopause dianggap tanda penuaan atau penurunan peran perempuan. Stigma ini membuat sebagian perempuan

merasa tidak dihargai. Tekanan sosial dapat menambah kecemasan dan menurunkan harga diri. Pendekatan biopsikososial direkomendasikan untuk memahami dampak budaya terhadap kesehatan mental perempuan (World Health Organization [WHO], 2022).

Perubahan fisik pada menopause dini seperti kenaikan berat badan, kulit kering, rambut rontok, atau vagina kering bukan hanya masalah penampilan, tetapi juga menyentuh persepsi diri (*body image*). Estrogen berperan menjaga elastisitas kulit, distribusi lemak, dan fungsi seksual, sehingga ketika hormon ini turun, perubahan tubuh terasa lebih cepat dan nyata. Perempuan usia 30–40 tahun yang seharusnya masih merasa produktif dapat merasa “menua lebih cepat” dibanding teman sebayanya. Persepsi negatif terhadap tubuh ini menurunkan rasa percaya diri dan memicu stres emosional. Literatur klinis menyebutkan bahwa gangguan citra tubuh berkaitan erat dengan depresi, kecemasan, dan penurunan kualitas hidup pada perempuan dengan menopause dini (Faubion, 2023).

Dampak psikologis tersebut kemudian memengaruhi hubungan interpersonal. Penurunan libido atau nyeri saat berhubungan (*dispareunia*) dapat menyebabkan jarak emosional dengan pasangan. Pasien mungkin menghindari kontak intim karena takut nyeri atau merasa tidak menarik. Pasangan yang tidak memahami kondisi ini dapat menafsirkan sebagai penolakan. Kesalahpahaman ini berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga. Pedoman praktik kesehatan perempuan menekankan pentingnya komunikasi dan dukungan keluarga selama masa transisi menopause (Kapoor, 2023).

C. Perubahan dalam Seksualitas

Kehidupan seksual perempuan dipengaruhi oleh interaksi antara hormon, kondisi fisik, emosi, dan hubungan interpersonal. Ketika fungsi ovarium menurun lebih cepat pada menopause dini, keseimbangan tersebut ikut berubah. Penurunan estrogen dan androgen memengaruhi respons seksual secara langsung. Tubuh menjadi kurang responsif terhadap rangsangan, sementara kenyamanan saat berhubungan berkurang. Literatur kesehatan perempuan menjelaskan bahwa disfungsi seksual merupakan keluhan yang cukup sering pada perempuan dengan *premature ovarian insufficiency* (Faubion, 2023).

Estrogen berperan menjaga elastisitas dan kelembapan jaringan vagina. Ketika kadar hormon ini menurun, dinding vagina menjadi lebih tipis dan kering. Pelumasan alami berkurang sehingga gesekan saat hubungan

seksual meningkat. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa perih atau nyeri (*dispareunia*). Pedoman klinis menyebutkan bahwa perubahan genitourinari termasuk gejala fisik yang paling memengaruhi kenyamanan seksual (The North American Menopause Society [NAMS], 2022).

Selain rasa nyeri, beberapa perempuan melaporkan penurunan libido. Hasrat seksual berkurang karena kombinasi faktor hormonal, kelelahan, dan stres emosional. Penurunan androgen seperti testosteron juga memengaruhi motivasi dan gairah seksual. Situasi ini sering membuat pasien merasa “tidak seperti dulu”. Tinjauan endokrinologi reproduksi menyebutkan bahwa libido berkaitan erat dengan keseimbangan hormon ovarium (Kapoor, 2023).

Gangguan tidur dan *hot flushes* ikut memperburuk fungsi seksual. Tidur yang tidak nyenyak menyebabkan tubuh mudah lelah dan tidak bertenaga. Kondisi ini menurunkan minat terhadap aktivitas intim. Perempuan mungkin lebih memilih istirahat dibandingkan berhubungan seksual. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas tidur berkorelasi dengan kepuasan seksual pada masa menopause (Santoro et al., 2021).

Faktor psikologis juga berperan penting dalam pengalaman seksual. Perubahan bentuk tubuh, kenaikan berat badan, atau rambut rontok dapat menurunkan rasa percaya diri. Perempuan mungkin merasa kurang menarik di hadapan pasangan. Perasaan negatif terhadap citra tubuh dapat menghambat respons seksual. Literatur psikososial menyatakan bahwa *body image* berhubungan kuat dengan kepuasan seksual perempuan (Faubion, 2023).

Hubungan dengan pasangan sering terpengaruh secara tidak langsung. Ketika pasien menghindari hubungan karena nyeri atau takut tidak nyaman, pasangan bisa salah memahami sebagai penolakan. Kurangnya komunikasi dapat memicu konflik rumah tangga. Stres relasi kemudian memperparah gangguan emosional. Pedoman praktik kesehatan perempuan menekankan pentingnya keterlibatan pasangan dalam edukasi menopause (NAMS, 2022).

Dalam konteks budaya Indonesia, pembicaraan tentang seksualitas masih dianggap sensitif. Banyak perempuan merasa malu mengungkapkan keluhan seksual kepada tenaga kesehatan. Akibatnya, masalah tidak tertangani dan berlangsung lama. Padahal gangguan seksual dapat memengaruhi kualitas hidup dan keharmonisan keluarga. Pendekatan komunikasi yang empatik sangat dibutuhkan dalam pelayanan keperawatan (World Health Organization [WHO], 2022).

Sebagai contoh, seorang perempuan usia 38 tahun mengeluhkan nyeri saat berhubungan sejak enam bulan terakhir. Ia menghindari hubungan intim karena takut sakit, tetapi tidak berani menceritakan keluhan kepada suami. Suami menganggap pasien tidak tertarik lagi sehingga muncul ketegangan dalam rumah tangga. Setelah dilakukan pengkajian, ditemukan adanya kekeringan vagina dan *hot flushes*. Kasus seperti ini menunjukkan hubungan langsung antara perubahan fisik, psikologis, dan relasi seksual (Santoro et al., 2021).

Contoh lain terlihat pada pasien yang merasa kehilangan gairah seksual setelah mengalami menopause dini. Ia merasa cepat lelah, mudah cemas, dan tidak percaya diri dengan perubahan tubuhnya. Kombinasi faktor ini membuatnya menolak aktivitas intim meskipun tidak ada nyeri. Edukasi mengenai perubahan hormon dan strategi adaptasi membantu pasien memahami kondisinya. Literatur menyebutkan bahwa intervensi edukatif dan konseling dapat meningkatkan kepuasan seksual perempuan menopause (Kapoor, 2023).

D. Risiko Jangka Panjang: Osteoporosis dan Kardiovaskular

Penurunan fungsi ovarium pada usia muda membawa konsekuensi kesehatan yang tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang. Defisiensi estrogen yang terjadi lebih awal membuat tubuh kehilangan efek protektif hormon tersebut lebih lama dibandingkan menopause fisiologis. Estrogen sebenarnya berperan menjaga kesehatan tulang, jantung, dan pembuluh darah. Ketika kadar hormon turun, berbagai sistem tubuh menjadi lebih rentan terhadap penyakit degeneratif. Literatur kesehatan perempuan menyebutkan bahwa menopause dini berkaitan dengan peningkatan risiko osteoporosis dan penyakit kardiovaskular (Faubion, 2023).

Salah satu dampak paling jelas terlihat pada sistem tulang. Estrogen membantu menjaga keseimbangan antara pembentukan tulang baru dan resorpsi tulang lama. Tanpa estrogen yang cukup, proses resorpsi berlangsung lebih cepat daripada pembentukan. Kepadatan mineral tulang menurun secara bertahap sehingga tulang menjadi rapuh. Proses ini dijelaskan sebagai dasar terjadinya osteoporosis pada perempuan dengan defisiensi estrogen (ESHRE Guideline Group, 2024).

Perempuan dengan menopause dini mengalami paparan kehilangan hormon lebih lama, sehingga kehilangan massa tulang terjadi lebih cepat. Penurunan densitas tulang dapat dimulai sejak usia 30–40 tahun. Akibatnya, risiko osteopenia dan osteoporosis muncul lebih awal dibandingkan populasi umum. Tulang yang rapuh meningkatkan kemungkinan fraktur, terutama pada panggul, pergelangan tangan, dan tulang belakang. Tinjauan klinis menegaskan bahwa usia menopause lebih muda berkorelasi dengan risiko fraktur yang lebih tinggi (Santoro et al., 2021).

Gejala osteoporosis sering tidak terasa sampai terjadi patah tulang. Banyak pasien merasa sehat dan aktif tanpa menyadari kepadatan tulangnya sudah menurun. Fraktur dapat terjadi hanya karena jatuh ringan atau aktivitas sehari-hari. Kondisi ini menyebabkan nyeri kronis, keterbatasan gerak, dan penurunan kemandirian. Literatur praktik kesehatan merekomendasikan skrining densitas tulang pada perempuan dengan menopause dini (Faubion, 2023).

Sebagai contoh, seorang perempuan usia 42 tahun dengan riwayat menopause dini mengalami patah tulang pergelangan tangan setelah terpeleset di kamar mandi. Benturan yang relatif ringan ternyata menyebabkan fraktur karena tulangnya sudah rapuh. Pemeriksaan lanjutan menunjukkan densitas tulang rendah. Pasien baru menyadari bahwa berhentinya menstruasi beberapa tahun sebelumnya berkaitan dengan kondisi tersebut. Kasus ini menggambarkan hubungan langsung antara defisiensi estrogen dan risiko osteoporosis (ESHRE Guideline Group, 2024).

Selain tulang, sistem kardiovaskular juga terdampak signifikan. Estrogen membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan profil lipid yang sehat. Hormon ini meningkatkan kolesterol HDL dan menurunkan LDL. Ketika estrogen menurun, kadar LDL cenderung meningkat dan pembuluh darah menjadi kaku. Perubahan ini meningkatkan risiko aterosklerosis dan penyakit jantung koroner (NAMS, 2022).

Gangguan metabolik seperti resistensi insulin dan peningkatan lemak abdominal juga lebih sering muncul. Lemak yang menumpuk di sekitar perut berkaitan dengan sindrom metabolik. Sindrom ini meliputi hipertensi, dislipidemia, dan peningkatan gula darah. Kombinasi faktor tersebut memperbesar risiko serangan jantung dan stroke. Literatur epidemiologi menyatakan bahwa perempuan dengan menopause dini memiliki risiko kardiovaskular lebih tinggi dibandingkan menopause normal (Santoro et al., 2021).

Sebagai ilustrasi, seorang pasien usia 40 tahun dengan menopause dini datang untuk pemeriksaan rutin. Ia mengeluhkan cepat lelah saat naik tangga dan berat badan bertambah. Hasil laboratorium menunjukkan kolesterol LDL tinggi dan tekanan darah meningkat. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya, tetapi defisiensi estrogen menjadi faktor risiko penting. Kondisi ini menunjukkan bagaimana perubahan hormonal dapat memengaruhi kesehatan jantung (Faubion, 2023).

Risiko jangka panjang tersebut dapat berdampak pada kualitas hidup secara keseluruhan. Fraktur tulang membatasi aktivitas fisik, sedangkan penyakit jantung menurunkan daya tahan tubuh. Pasien mungkin kehilangan produktivitas kerja dan kemandirian. Beban ekonomi dan psikologis juga meningkat akibat pengobatan jangka panjang. Pedoman kesehatan perempuan menyarankan pencegahan sejak dini melalui gaya hidup sehat dan pemantauan rutin (NAMS, 2022).

BAB 6

Pengkajian Keperawatan pada Perempuan dengan Menopause Dini

A. Anamnesis Komprehensif

Langkah awal dalam asuhan keperawatan pada perempuan dengan dugaan menopause dini dimulai dari pengkajian riwayat kesehatan secara menyeluruh. Informasi yang lengkap membantu perawat memahami hubungan antara keluhan fisik, psikologis, dan perubahan hormonal. Menopause dini sering muncul dengan gejala yang samar sehingga mudah disalahartikan sebagai kelelahan biasa atau stres. Wawancara terarah membantu mengidentifikasi tanda awal penurunan fungsi ovarium. Pedoman praktik klinis menekankan bahwa penilaian klinis tetap menjadi dasar utama sebelum pemeriksaan penunjang dilakukan (ESHRE Guideline Group, 2024).

Riwayat menstruasi menjadi fokus pertama dalam anamnesis. Perawat perlu menanyakan usia menarke, pola siklus sebelumnya, serta perubahan yang terjadi dalam satu hingga dua tahun terakhir. Informasi seperti haid yang makin jarang, volume berkurang, atau amenore lebih dari tiga bulan sangat penting dicatat. Pertanyaan sederhana seperti “Sejak kapan haid mulai tidak teratur?” sering membantu membuka cerita pasien. Literatur reproduksi menyebutkan bahwa gangguan siklus merupakan indikator awal disfungsi ovarium (Santoro et al., 2021).

Keluhan fisik yang menyertai juga perlu dieksplorasi secara sistematis. Perawat dapat menanyakan adanya *hot flushes*, keringat malam, gangguan tidur, nyeri sendi, atau kekeringan vagina. Gejala tersebut sering dianggap tidak berhubungan oleh pasien, padahal berasal dari defisiensi estrogen. Pengkajian yang rinci membantu mengaitkan keluhan menjadi satu gambaran klinis. Pendekatan ini direkomendasikan dalam pedoman

manajemen menopause modern (The North American Menopause Society [NAMS], 2022).

Aspek psikologis tidak boleh diabaikan selama wawancara. Perubahan emosi, kecemasan, mudah marah, atau perasaan sedih perlu ditanyakan secara empatik. Banyak pasien merasa ragu membicarakan masalah mental jika tidak ditanya langsung. Pertanyaan terbuka seperti “Bagaimana suasana hati akhir-akhir ini?” dapat memudahkan komunikasi. Literatur kesehatan mental menunjukkan bahwa gangguan psikologis sering menyertai defisiensi estrogen dini (Gordon et al., 2020).

Riwayat kesehatan dahulu memberikan petunjuk mengenai faktor risiko medis. Perawat perlu menanyakan penyakit kronis seperti diabetes, gangguan tiroid, atau penyakit autoimun. Riwayat kemoterapi, radioterapi, atau operasi ovarium juga penting karena dapat menyebabkan menopause iatrogenik. Informasi ini membantu menentukan penyebab potensial gangguan fungsi ovarium. Tinjauan klinis menyebutkan bahwa kondisi medis tertentu berkontribusi pada terjadinya *premature ovarian insufficiency* (Kapoor, 2023).

Riwayat keluarga turut memiliki nilai diagnostik. Perawat dapat menanyakan apakah ibu atau saudara perempuan mengalami menopause dini. Pola herediter sering ditemukan pada sebagian kasus. Data ini membantu mengidentifikasi faktor genetik sebagai penyebab. Pedoman reproduksi menyarankan pencatatan riwayat keluarga sebagai bagian dari pengkajian rutin (ESHRE Guideline Group, 2024).

Gaya hidup sehari-hari juga perlu digali secara detail. Pertanyaan mengenai pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, dan tingkat stres dapat memberikan gambaran faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Status gizi rendah atau obesitas dapat memengaruhi keseimbangan hormon. Stres kronis juga mengganggu regulasi poros hipotalamus–hipofisis–ovarium. Literatur menunjukkan bahwa gaya hidup berkontribusi terhadap variasi usia menopause (Santoro et al., 2021).

Aspek sosial dan relasi interpersonal perlu dikaji karena berkaitan dengan kualitas hidup pasien. Perawat dapat menanyakan dukungan keluarga, hubungan dengan pasangan, serta dampak gejala terhadap pekerjaan. Masalah seksual atau konflik rumah tangga sering tersembunyi bila tidak ditanyakan secara sensitif. Lingkungan sosial yang kurang mendukung dapat memperburuk kondisi psikologis.

Pendekatan biopsikososial direkomendasikan dalam praktik kesehatan perempuan modern (Faubion, 2023).

Sebagai contoh, seorang pasien usia 38 tahun datang dengan keluhan cepat lelah dan sulit tidur. Saat diwawancarai lebih lanjut, ia menyebutkan haid berhenti sejak enam bulan lalu, sering merasa panas malam hari, dan mudah marah. Pasien juga memiliki riwayat operasi kista ovarium dua tahun sebelumnya. Data ini mengarah pada kemungkinan penurunan fungsi ovarium. Contoh tersebut menunjukkan bagaimana anamnesis komprehensif membantu menghubungkan berbagai keluhan menjadi satu diagnosis klinis (Kapoor, 2023).

Ringkasan Poin-Poin Anamnesis Komprehensif pada Dugaan Menopause Dini

1. Tujuan umum anamnesis

- Mengidentifikasi hubungan antara keluhan fisik, psikologis, dan perubahan hormonal
- Mengenali tanda awal penurunan fungsi ovarium
- Menjadi dasar keputusan sebelum pemeriksaan penunjang

2. Riwayat menstruasi (fokus utama)

- Usia menarke
- Pola siklus sebelumnya (teratur/tidak, lama siklus)
- Perubahan 1–2 tahun terakhir
- Haid makin jarang, volume berkurang, atau amenore ≥ 3 bulan
- Waktu mulai ketidakteraturan (“Sejak kapan haid berubah?”)

3. Keluhan fisik khas defisiensi estrogen

- *Hot flushes* / rasa panas mendadak
- Keringat malam
- Gangguan tidur
- Nyeri sendi/otot
- Kekeringan vagina atau nyeri saat hubungan seksual

4. Aspek psikologis/emosional

- *Mood swing*, mudah marah
- Cemas atau gelisah
- Sedih berkepanjangan
- Penurunan motivasi atau konsentrasi
- Gangguan tidur terkait stres

5. Riwayat kesehatan dahulu (faktor medis)

- Diabetes, gangguan tiroid

- Penyakit autoimun
- Kemoterapi/radioterapi
- Operasi ovarium/rahim
- Obat jangka panjang tertentu

6. Riwayat keluarga

- Ibu/saudara perempuan menopause dini
- Riwayat infertilitas keluarga
- Kelainan genetik/kromosom

7. Gaya hidup

- Pola makan dan status gizi
- Aktivitas fisik/olahraga
- Merokok atau alkohol
- Tingkat stres kerja/rumah tangga
- Pola tidur

8. Aspek sosial & relasi

- Dukungan keluarga
- Hubungan dengan pasangan
- Masalah seksual
- Dampak keluhan terhadap pekerjaan
- Stigma atau hambatan budaya

B. Pemeriksaan Fisik

Setelah anamnesis lengkap dilakukan, tahap berikutnya adalah pemeriksaan fisik untuk mengonfirmasi temuan klinis dan menilai dampak sistemik dari penurunan hormon ovarium. Pemeriksaan ini membantu perawat mengidentifikasi tanda objektif yang mungkin tidak disadari pasien. Banyak perubahan akibat defisiensi estrogen terjadi perlahan sehingga perlu pengamatan teliti. Pendekatan yang sistematis membuat data yang diperoleh lebih akurat dan mudah diinterpretasi. Pedoman klinis menyarankan evaluasi fisik menyeluruh pada perempuan dengan dugaan *premature ovarian insufficiency* (ESHRE Guideline Group, 2024).

Penilaian umum dimulai dari observasi kondisi pasien secara keseluruhan. Perawat memperhatikan tingkat kesadaran, penampilan, status gizi, serta tanda kelelahan. Wajah tampak pucat, lingkaran mata gelap, atau postur lesu dapat mengindikasikan gangguan tidur kronis. Indeks massa tubuh juga penting dicatat karena berat badan terlalu rendah atau berlebih memengaruhi keseimbangan hormon. Literatur kesehatan reproduksi

menyebutkan bahwa status nutrisi berkaitan erat dengan fungsi ovarium (Santoro et al., 2021).

Tanda vital perlu diukur sebagai bagian dari skrining risiko jangka panjang. Tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu memberikan gambaran kondisi kardiovaskular dan metabolik. Hipertensi atau denyut jantung cepat dapat menjadi indikator awal gangguan kardiometabolik. Perempuan dengan menopause dini memiliki risiko lebih tinggi terhadap penyakit jantung. Tinjauan klinis menekankan pentingnya pemantauan rutin parameter ini (Faubion, 2023).

Pemeriksaan antropometri membantu menilai perubahan komposisi tubuh. Lingkar pinggang, berat badan, dan indeks massa tubuh perlu diukur secara berkala. Peningkatan lemak abdominal sering terjadi akibat defisiensi estrogen. Kondisi ini berkaitan dengan sindrom metabolik dan resistensi insulin. Literatur epidemiologi menyebutkan bahwa distribusi lemak sentral meningkat pada masa transisi menopause (Santoro et al., 2021).

Kulit dan rambut juga memberikan petunjuk klinis yang bermakna. Perawat dapat menilai adanya kulit kering, penurunan elastisitas, atau keriput lebih cepat. Rambut mungkin tampak menipis atau mudah rontok. Perubahan ini berhubungan dengan berkurangnya kolagen akibat rendahnya estrogen. Tinjauan fisiologi reproduksi menjelaskan bahwa estrogen berperan dalam menjaga kesehatan jaringan ikat (Kapoor, 2023).

Sistem muskuloskeletal perlu diperiksa untuk menilai risiko osteoporosis. Perawat dapat menanyakan nyeri tulang, nyeri punggung, atau kekakuan sendi, kemudian melakukan inspeksi dan palpasi sederhana. Postur tubuh yang membungkuk atau penurunan tinggi badan dapat mengarah pada kerapuhan tulang belakang. Kekuatan otot dan keseimbangan juga dinilai untuk mencegah risiko jatuh. Pedoman ESHRE merekomendasikan evaluasi dini pada perempuan dengan risiko kehilangan massa tulang (ESHRE Guideline Group, 2024).

Pemeriksaan payudara tetap menjadi bagian penting dalam pengkajian kesehatan perempuan. Inspeksi dilakukan untuk melihat bentuk, simetri, dan perubahan kulit. Palpasi bertujuan mendeteksi adanya benjolan atau nyeri. Walaupun tidak langsung berkaitan dengan menopause dini, skrining ini penting sebagai upaya promotif preventif. Literatur praktik klinik menganjurkan pemeriksaan payudara rutin pada setiap kunjungan kesehatan reproduksi (NAMS, 2022).

Evaluasi genitourinari membantu mengidentifikasi dampak lokal defisiensi estrogen. Perawat dapat menanyakan keluhan kekeringan vagina, nyeri saat hubungan seksual, atau infeksi saluran kemih berulang. Pada pemeriksaan, mukosa mungkin tampak pucat, tipis, dan kurang elastis. Kondisi ini dikenal sebagai atrofi urogenital. Pedoman menopause modern menyebutkan bahwa gejala genitourinari merupakan tanda khas defisiensi estrogen (NAMS, 2022).

Sebagai contoh, seorang pasien usia 40 tahun datang dengan keluhan haid berhenti dan nyeri sendi. Pemeriksaan menunjukkan IMT meningkat, tekanan darah sedikit tinggi, kulit kering, dan mukosa vagina tampak tipis. Data objektif ini mendukung keluhan subjektif pasien tentang *hot flushes* dan kelelahan. Temuan tersebut membantu perawat menyimpulkan adanya dampak sistemik dari penurunan hormon. Kasus seperti ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan fisik terstruktur dalam pengkajian klinis (Faubion, 2023).

Ringkasan Poin-Poin Pemeriksaan Fisik Komprehensif pada Dugaan Menopause Dini

1. Tujuan pemeriksaan

- Mengidentifikasi tanda objektif defisiensi estrogen
- Menilai dampak sistemik (tulang, jantung, metabolik, urogenital)
- Deteksi dini komplikasi jangka panjang
- Dasar perencanaan intervensi & rujukan

2. Observasi umum

- Tingkat kesadaran & tampilan umum
- Kelelahan, lesu, gangguan tidur
- Status gizi (kurus/*overweight*/obesitas)
- Postur tubuh
- Ekspresi emosional (cemas/sedih)

3. Tanda vital (skrining risiko kardiovaskular & metabolik)

- Tekanan darah
- Nadi
- Respirasi
- Suhu

4. Antropometri (risiko sindrom metabolik)

- Berat badan
- Tinggi badan
- Indeks Massa Tubuh (IMT)
- Lingkar pinggang (lemak abdominal)

5. Kulit & rambut (tanda penurunan kolagen akibat defisiensi estrogen)

- Kulit kering/kusam
- Elastisitas menurun
- Keriput dini
- Rambut menipis/rontok

6. Muskuloskeletal (tulang & sendi) (skrining osteoporosis)

- Nyeri sendi/tulang
- Kekakuan pagi hari
- Postur membungkuk
- Penurunan tinggi badan
- Risiko jatuh/keseimbangan

7. Kardiovaskular (risiko penyakit jantung)

- Tekanan darah tinggi
- Edema
- Sesak/cepat lelah saat aktivitas
- Riwayat nyeri dada/palpitasi

8. Payudara (skrining kesehatan reproduksi umum)

- Inspeksi bentuk & simetri
- Perubahan kulit/puting
- Palpasi benjolan

9. Genitourinari (tanda atrofi urogenital)

- Keluhan vagina kering
- Nyeri saat hubungan seksual
- Gatal/iritasi
- Infeksi saluran kemih berulang
- Mukosa tipis/pucat

C. Pengkajian Psikososial

Pendekatan keperawatan pada perempuan dengan menopause dini tidak cukup hanya menilai kondisi fisik. Perubahan hormonal sering memengaruhi emosi, pola pikir, hubungan sosial, dan peran sehari-hari. Banyak keluhan yang muncul bersifat subjektif sehingga perlu digali melalui komunikasi terapeutik. Pengkajian psikososial membantu perawat memahami pengalaman pasien secara menyeluruh. Literatur kesehatan perempuan menekankan bahwa aspek biopsikososial sama pentingnya dengan pemeriksaan klinis (Faubion, 2023).

Perubahan suasana hati menjadi salah satu area yang perlu dievaluasi terlebih dahulu. Penurunan estrogen berhubungan dengan gangguan regulasi serotonin dan dopamin di otak. Kondisi ini membuat pasien lebih mudah cemas, sedih, atau tersinggung. Gejala emosional sering muncul bersamaan dengan *hot flushes* dan gangguan tidur. Studi klinis menunjukkan bahwa gangguan *mood* meningkat selama transisi menopause (Santoro et al., 2021).

Perawat perlu menanyakan secara langsung tentang perasaan sehari-hari pasien. Pertanyaan sederhana seperti “Bagaimana suasana hati akhir-akhir ini?” atau “Apakah Ibu sering merasa cemas atau mudah marah?” dapat membuka percakapan. Banyak perempuan tidak menyadari bahwa keluhan emosional berkaitan dengan perubahan hormon. Tanpa pengkajian aktif, masalah psikologis dapat terlewat. Literatur kesehatan mental perempuan menyarankan skrining rutin untuk depresi dan ansietas pada masa menopause (Gordon et al., 2020).

Gangguan tidur juga perlu dikaji karena berhubungan erat dengan kesehatan mental. Pasien dapat mengalami sulit tidur, sering terbangun, atau tidur tidak nyenyak akibat keringat malam. Kurang tidur menyebabkan kelelahan dan menurunkan toleransi terhadap stres. Kondisi ini memperburuk emosi negatif pada siang hari. Pedoman menopause modern menempatkan kualitas tidur sebagai indikator penting kesejahteraan psikologis (The North American Menopause Society [NAMS], 2022).

Aspek citra tubuh (*body image*) sering memengaruhi kepercayaan diri perempuan. Kenaikan berat badan, kulit kering, atau rambut rontok dapat membuat pasien merasa kurang menarik. Perasaan ini kadang menurunkan motivasi bersosialisasi. Beberapa pasien memilih menarik diri dari lingkungan karena malu. Literatur menyebutkan bahwa persepsi tubuh berhubungan dengan kualitas hidup dan fungsi seksual perempuan menopause (Faubion, 2023).

Hubungan interpersonal dengan pasangan dan keluarga juga perlu dieksplorasi. Penurunan libido atau nyeri saat hubungan dapat menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Kurangnya komunikasi sering menyebabkan salah paham. Pasien mungkin merasa bersalah atau tidak didukung. Pendekatan keluarga dianjurkan dalam praktik kesehatan perempuan untuk meningkatkan dukungan emosional (NAMS, 2022).

Peran sosial dan pekerjaan turut memengaruhi kondisi psikologis. Perempuan usia produktif sering memiliki tanggung jawab ganda sebagai pekerja dan

pengurus rumah tangga. Kelelahan kronis dan tekanan kerja dapat memperparah stres. Gangguan konsentrasi atau mudah lupa berdampak pada performa kerja. Literatur menyatakan bahwa stres psikososial berkaitan dengan gangguan siklus reproduksi (Santoro et al., 2021).

Faktor budaya juga perlu dipertimbangkan selama pengkajian. Di beberapa masyarakat, topik menopause atau seksualitas dianggap sensitif sehingga pasien enggan bercerita. Stigma ini membuat keluhan psikologis tersembunyi. Perawat perlu menciptakan suasana aman dan tidak menghakimi. Pendekatan komunikasi empatik terbukti meningkatkan keterbukaan pasien (World Health Organization [WHO], 2022).

Sebagai contoh, seorang perempuan usia 39 tahun datang dengan keluhan haid berhenti dan sering marah tanpa sebab. Saat diwawancarai, ia mengaku sulit tidur, merasa tidak percaya diri, dan sering bertengkar dengan suami. Pasien juga merasa tertekan karena pekerjaan menumpuk. Temuan ini menunjukkan adanya kombinasi faktor biologis dan psikososial. Kasus tersebut menggambarkan pentingnya pengkajian menyeluruh, bukan hanya fokus pada gejala fisik (Gordon et al., 2020).

Ringkasan Poin-Poin Pengkajian Psikososial Komprehensif pada Dugaan Menopause Dini

1. Tujuan pengkajian

- Menilai dampak emosional, sosial, dan budaya
- Mengidentifikasi stresor psikologis
- Menentukan kebutuhan dukungan/konseling
- Melengkapi data anamnesis & fisik

2. Kondisi emosional (*mood*) (skrining depresi & ansietas)

- Mudah marah/tersinggung
 - Sedih berkepanjangan
 - Cemas/gelisah
 - *Mood swing*
 - Menangis tanpa sebab jelas
- Contoh pertanyaan wawancara:
- “Akhir-akhir ini Ibu lebih sering merasa sedih atau cemas tidak?”
 - “Apakah Ibu merasa lebih mudah marah dibandingkan sebelumnya?”
 - “Apa yang biasanya Ibu lakukan saat merasa stres?”
 - “Apakah pernah merasa putus asa atau kehilangan semangat?”
 - “Seberapa sering perasaan tersebut muncul dalam seminggu?”

3. Kualitas tidur (berhubungan dengan emosi & konsentrasi)

- Sulit tidur
- Sering terbangun
- Keringat malam
- Tidak segar saat bangun
- Mengantuk/kelelahan siang hari

Contoh pertanyaan wawancara:

- “Jam berapa biasanya Ibu tidur dan bangun?”
- “Apakah sering terbangun karena keringat malam atau rasa panas?”
- “Saat bangun pagi, badan terasa segar atau lelah?”
- “Apakah rasa lelah mengganggu aktivitas harian?”
- “Apakah perlu tidur siang karena kelelahan?”

4. Fungsi kognitif (dampak defisiensi estrogen pada otak)

- Sulit konsentrasi
- Mudah lupa (*brain fog*)
- Penurunan produktivitas kerja

Contoh pertanyaan wawancara:

- “Apakah Ibu merasa lebih sulit fokus atau mudah lupa?”
- “Apakah pekerjaan rumah/kantor terasa lebih berat dari biasanya?”
- “Kegiatan apa yang sekarang terasa paling melelahkan?”
- “Apakah keluhan ini memengaruhi produktivitas kerja?”
- “Apakah Ibu pernah menunda aktivitas karena tidak bertenaga?”

5. Citra tubuh & kepercayaan diri (memengaruhi kualitas hidup & seksual)

- Merasa gemuk/berubah bentuk tubuh
- Kurang percaya diri
- Menarik diri dari sosial
- Merasa “menua lebih cepat”

Contoh pertanyaan wawancara:

- “Bagaimana perasaan Ibu terhadap perubahan bentuk tubuh akhir-akhir ini?”
- “Apakah kenaikan/penurunan berat badan membuat Ibu kurang percaya diri?”
- “Apakah Ibu jadi jarang bertemu teman atau ikut kegiatan sosial?”
- “Apakah Ibu merasa ‘menua lebih cepat’ dibanding teman sebaya?”
- “Apa yang paling mengganggu dari perubahan fisik tersebut?”

6. Relasi pasangan & seksual

- Penurunan libido
- Nyeri saat hubungan
- Menghindari keintiman

- Konflik dengan pasangan
- Dukungan emosional dari pasangan
Contoh pertanyaan wawancara:
- “Apakah ada perubahan dalam hubungan dengan pasangan sejak haid tidak teratur?”
- “Apakah Ibu merasa nyaman saat berhubungan intim?”
- “Apakah ada nyeri atau kekeringan yang mengganggu?”
- “Apakah Ibu bisa berbicara terbuka dengan pasangan tentang keluhan ini?”
- “Menurut Ibu, dukungan pasangan sudah cukup atau belum?”

7. Peran sosial & pekerjaan (stres kronis memperburuk gejala)

- Beban kerja tinggi
- Peran ganda rumah tangga–karier
- Stres finansial
- Gangguan performa kerja
Contoh pertanyaan wawancara:
- “Bagaimana beban kerja Ibu sehari-hari?”
- “Apakah Ibu merasa kewalahan dengan peran rumah tangga dan pekerjaan?”
- “Apakah ada tekanan finansial atau tanggung jawab tambahan?”
- “Apakah Ibu punya waktu untuk istirahat atau diri sendiri?”
- “Apa yang paling membuat Ibu stres belakangan ini?”

8. Dukungan sosial

- Dukungan keluarga
- Teman/komunitas
- Seseorang untuk berbagi cerita
- Rasa kesepian/isolasi
Contoh pertanyaan wawancara:
- “Siapa yang biasanya Ibu ajak bicara saat ada masalah?”
- “Apakah keluarga memahami kondisi yang Ibu alami?”
- “Apakah Ibu merasa mendapat dukungan atau justru merasa sendirian?”
- “Adakah teman/komunitas yang membantu secara emosional?”
- “Hal apa yang paling Ibu butuhkan dari orang terdekat saat ini?”

9. Faktor budaya & keyakinan (hambatan akses layanan Kesehatan)

- Tabu membicarakan menstruasi/menopause
- Malu mencari bantuan
- Persepsi negatif tentangopause
Contoh pertanyaan wawancara:

- “Apakah Ibu merasa nyaman membicarakan masalah reproduksi atau menopause?”
- “Apakah ada kepercayaan keluarga/budaya yang memengaruhi cara Ibu melihat kondisi ini?”
- “Apakah Ibu pernah menunda berobat karena malu atau takut?”
- “Menurut Ibu, apa arti menopause bagi diri Ibu?”
- “Apa harapan Ibu terkait kesehatan ke depan?”

Tips komunikasi untuk perawat

- Gunakan bahasa sederhana & tidak menghakimi
- Dengarkan aktif (*eye contact*, anggukan, refleksi perasaan)
- Beri waktu pasien menjawab
- Jaga privasi
- Validasi perasaan pasien (“Wajar Ibu merasa seperti itu”)

D. Pemeriksaan Penunjang

Evaluasi klinis pada perempuan dengan dugaan menopause dini tidak berhenti pada anamnesis dan pemeriksaan fisik. Data objektif dari pemeriksaan penunjang dibutuhkan untuk memperkuat dugaan penurunan fungsi ovarium. Hasil laboratorium membantu membedakan menopause dini dari penyebab lain seperti gangguan tiroid atau kehamilan. Pemeriksaan ini juga bermanfaat untuk menilai risiko komplikasi jangka panjang. Pedoman reproduksi modern menekankan kombinasi penilaian klinis dan tes penunjang untuk diagnosis yang akurat (ESHRE Guideline Group, 2024).

Pemeriksaan hormonal menjadi komponen utama dalam evaluasi menopause dini. Kadar *Follicle Stimulating Hormone* (FSH) biasanya meningkat ketika ovarium tidak lagi responsif terhadap stimulasi. Nilai FSH yang tinggi dan persisten menunjukkan berkurangnya cadangan folikel. Pemeriksaan dilakukan lebih dari satu kali untuk memastikan hasil konsisten. Literatur menyebutkan bahwa peningkatan FSH merupakan penanda biokimia penting pada *premature ovarian insufficiency* (Kapoor, 2023).

Selain FSH, kadar estrogen terutama estradiol (E2) juga perlu dinilai. Estradiol yang rendah menggambarkan penurunan produksi hormon ovarium. Kombinasi FSH tinggi dan estradiol rendah memperkuat dugaan menopause dini. Data ini membantu menjelaskan munculnya gejala seperti *hot flushes* dan kekeringan vagina. Tinjauan endokrinologi reproduksi menegaskan bahwa pemeriksaan kedua hormon ini sering digunakan sebagai standar evaluasi awal (Santoro et al., 2021).

Anti-Mullerian Hormone (AMH) juga semakin sering digunakan untuk menilai cadangan ovarium. Hormon ini diproduksi oleh folikel kecil di ovarium. Nilai AMH rendah menunjukkan jumlah folikel yang tersisa semakin sedikit. Pemeriksaan ini bermanfaat terutama pada perempuan usia muda dengan gangguan haid. Literatur menyebutkan bahwa AMH membantu memprediksi fungsi ovarium secara lebih sensitif (Kapoor, 2023).

Tes kehamilan perlu dilakukan pada setiap perempuan usia reproduksi dengan amenore. Amenore tidak selalu berarti menopause dini. Kehamilan harus disingkirkan terlebih dahulu sebagai penyebab paling umum berhentinya haid. Pemeriksaan sederhana ini mencegah kesalahan diagnosis. Pedoman klinis merekomendasikan tes β -hCG sebagai langkah awal sebelum evaluasi hormonal lanjutan (ESHRE Guideline Group, 2024).

Gangguan tiroid dapat menimbulkan gejala mirip menopause. Hipotiroidisme maupun hipertiroidisme dapat menyebabkan haid tidak teratur dan perubahan suasana hati. Pemeriksaan TSH dan hormon tiroid membantu membedakan kedua kondisi tersebut. Identifikasi dini penting karena gangguan tiroid dapat diobati. Literatur kesehatan perempuan menyarankan skrining fungsi tiroid pada evaluasi amenore (Santoro et al., 2021).

Pemeriksaan metabolik diperlukan untuk menilai risiko jangka panjang. Profil lipid, kadar glukosa darah, dan fungsi hati membantu mendeteksi sindrom metabolik. Defisiensi estrogen diketahui berhubungan dengan peningkatan kolesterol LDL dan resistensi insulin. Data laboratorium ini berguna sebagai dasar intervensi gaya hidup. Tinjauan klinis menunjukkan bahwa menopause dini meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular (Faubion, 2023).

Penilaian kesehatan tulang juga penting dilakukan. Pemeriksaan densitas tulang menggunakan *Dual-energy X-ray Absorptiometry* (DEXA) membantu mendeteksi osteopenia atau osteoporosis. Perempuan dengan menopause dini berisiko kehilangan massa tulang lebih cepat. Hasil pemeriksaan menjadi dasar pemberian edukasi dan terapi pencegahan. Pedoman ESHRE merekomendasikan skrining densitas tulang pada kelompok risiko tinggi (ESHRE Guideline Group, 2024).

Ultrasonografi (USG) pelvis dapat digunakan untuk menilai ukuran ovarium dan uterus. Ovarium yang mengecil atau jumlah folikel antral yang sedikit mengarah pada penurunan fungsi ovarium. Pemeriksaan ini juga membantu menyingkirkan kelainan struktural seperti kista atau tumor. USG bersifat non-invasif dan relatif mudah dilakukan. Literatur menyebutkan bahwa USG mendukung evaluasi anatomi sistem reproduksi perempuan (Kapoor, 2023).

Sebagai contoh, seorang pasien usia 36 tahun datang dengan amenore enam bulan dan *hot flushes*. Hasil laboratorium menunjukkan FSH tinggi, estradiol rendah, dan AMH sangat rendah. Tes kehamilan negatif dan fungsi tiroid normal. Pemeriksaan DEXA menunjukkan penurunan densitas tulang ringan. Kombinasi temuan ini menguatkan diagnosis menopause dini serta membantu perawat merencanakan edukasi dan tindak lanjut. Pendekatan berbasis bukti seperti ini direkomendasikan dalam praktik kesehatan perempuan modern (Faubion, 2023; Santoro et al., 2021).

BAB 7

Menyusun Diagnosis dan Rencana Asuhan Keperawatan

Asuhan keperawatan pada perempuan dengan menopause dini disusun secara sistematis melalui tiga tahap utama, yaitu penetapan diagnosis, penentuan luaran, dan perencanaan intervensi. Ketiga komponen ini saling berkaitan dan membentuk alur berpikir klinis yang logis. Diagnosis menjelaskan respons pasien terhadap masalah kesehatan, luaran menggambarkan target perbaikan, dan intervensi berisi tindakan yang dilakukan perawat. Pendekatan terstruktur ini membantu perawat bekerja lebih fokus dan terukur. Standarisasi bahasa SDKI–SLKI–SIKI direkomendasikan dalam praktik keperawatan profesional di Indonesia (PPNI, 2017).

Respons yang muncul pada menopause dini umumnya melibatkan aspek fisik, psikologis, dan sosial. Penurunan estrogen dapat menimbulkan gangguan tidur, nyeri sendi, kelelahan, kecemasan, serta perubahan citra tubuh. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi kesehatan, tetapi juga kualitas hidup sehari-hari. Data hasil pengkajian perlu dianalisis untuk menentukan masalah prioritas. Literatur kesehatan perempuan menekankan bahwa pendekatan holistik lebih efektif dibandingkan fokus pada satu gejala saja (Faubion, 2023).

Pada tahap diagnosis, perawat mengidentifikasi pola respons pasien menggunakan istilah SDKI. Contohnya meliputi gangguan pola tidur, ansietas, nyeri kronis, disfungsi seksual, defisit pengetahuan, dan risiko osteoporosis. Diagnosis disusun berdasarkan data subjektif dan objektif yang relevan. Penetapan yang tepat membantu mengarahkan perencanaan tindakan selanjutnya. Tinjauan klinis menunjukkan bahwa keluhan vasomotor dan gangguan tidur merupakan masalah paling sering pada menopause (Santoro et al., 2021).

Setelah diagnosis ditetapkan, perawat menentukan luaran atau hasil yang diharapkan menggunakan SLKI. Luaran berfungsi sebagai indikator keberhasilan asuhan keperawatan. Target dibuat spesifik, terukur, dan realistis sesuai kondisi pasien. Contohnya adalah kualitas tidur membaik, tingkat kecemasan menurun, atau pengetahuan pasien meningkat. Penggunaan indikator objektif memudahkan evaluasi perkembangan pasien (PPNI, 2019).

Intervensi keperawatan kemudian disusun berdasarkan SIKI. Intervensi mencakup tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pada menopause dini, fokus intervensi sering berupa edukasi, manajemen gejala, dukungan emosional, dan pencegahan komplikasi. Perawat berperan sebagai edukator, konselor, sekaligus advokat kesehatan perempuan. Literatur praktik menopause menyatakan bahwa pendekatan nonfarmakologis sangat membantu dalam pengelolaan gejala (NAMS, 2022).

Sebagai ilustrasi, pasien dengan *hot flushes* dan sulit tidur dapat ditegakkan diagnosis gangguan pola tidur. Luaran yang diharapkan adalah tidur 6–8 jam per malam dan rasa segar saat bangun. Intervensi meliputi edukasi *sleep hygiene*, teknik relaksasi, dan pengaturan lingkungan kamar. Pendekatan sederhana ini terbukti efektif mengurangi keluhan vasomotor. Studi klinis menunjukkan bahwa manajemen tidur berperan penting dalam kualitas hidup perempuan menopause (Santoro et al., 2021).

Pada pasien dengan kecemasan atau *mood swing*, diagnosis ansietas atau koping tidak efektif dapat dipertimbangkan. Luaran difokuskan pada penurunan tingkat kecemasan dan peningkatan kemampuan mengelola stres. Intervensi berupa komunikasi terapeutik, konseling, dan latihan napas dalam. Dukungan keluarga juga dianjurkan untuk memperkuat adaptasi emosional. Literatur kesehatan mental perempuan menegaskan pentingnya dukungan psikososial selama masa transisi menopause (Gordon et al., 2020).

Masalah muskuloskeletal memerlukan perhatian khusus karena berkaitan dengan risiko jangka panjang. Diagnosis dapat berupa nyeri kronis atau risiko penurunan integritas tulang. Luaran ditujukan pada berkurangnya nyeri dan peningkatan aktivitas fisik. Intervensi meliputi latihan beban ringan, edukasi kalsium dan vitamin D, serta pencegahan jatuh. Pedoman ESHRE merekomendasikan upaya pencegahan dini osteoporosis pada perempuan dengan menopause dini (ESHRE Guideline Group, 2024).

Kebutuhan edukasi sering menjadi fokus utama dalam asuhan. Banyak perempuan belum memahami penyebab dan dampak menopause dini. Diagnosis defisit pengetahuan membantu perawat merencanakan pendidikan

kesehatan terstruktur. Luaran berupa peningkatan pemahaman pasien mengenai kondisi dan cara perawatan diri. Edukasi yang baik meningkatkan kepatuhan dan rasa percaya diri pasien dalam mengelola gejala (Faubion, 2023).

Secara keseluruhan, integrasi SDKI, SLKI, dan SIKI membuat asuhan keperawatan lebih sistematis dan mudah dievaluasi. Setiap langkah saling mendukung dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik bagi pasien. Pendekatan ini membantu mahasiswa memahami hubungan antara teori dan praktik klinik. Perencanaan yang jelas juga meningkatkan keselamatan dan efektivitas pelayanan. Literatur praktik kesehatan perempuan mendukung penggunaan model terstandar untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan (Santoro et al., 2021; PPNI, 2017).

Tabel 7.1 Perencanaan Asuhan Keperawatan Menopause Dini (SDKI–SLKI–SIKI)

Masalah utama	Diagnosis (SDKI)	Luaran (SLKI) - Target	Intervensi kunci (SIKI)
Sulit tidur, hot flushes	Gangguan pola tidur	Tidur cukup & berkualitas	Sleep hygiene, relaksasi, lingkungan nyaman
Cepat lelah	Kelelahan	Energi meningkat	Manajemen energi, istirahat terjadwal, latihan ringan
Nyeri sendi/kaku	Nyeri kronis	Nyeri berkurang, mobilitas baik	Kompres hangat, ROM exercise, edukasi aktivitas
Cemas/gelisah	Ansietas	Pasien tenang, cemas menurun	Komunikasi terapeutik, napas dalam, konseling
Mood swing/stres	Koping tidak efektif	Koping adaptif	Manajemen stres, dukungan keluarga, konseling
Tidak percaya diri	Harga diri rendah situasional	Percaya diri meningkat	Edukasi body image, penguatan positif
Nyeri saat hubungan	Disfungsi seksual	Kenyamanan seksual meningkat	Edukasi pelumas, komunikasi pasangan
Kurang paham menopause	Defisit pengetahuan	Pengetahuan meningkat	Pendidikan kesehatan, leaflet, diskusi
Berat badan naik	Ketidakseimbangan nutrisi	IMT terkontrol	Diet seimbang, olahraga rutin
Risiko osteoporosis	Risiko penurunan integritas tulang	Tidak terjadi fraktur	Kalsium-vit D, latihan beban, pencegahan jatuh
Risiko penyakit jantung	Risiko perfusi tidak efektif	TD & lipid terkontrol	Monitoring vital, diet sehat, aktivitas fisik
Konflik keluarga	Gangguan peran keluarga	Hubungan harmonis	Konseling keluarga, edukasi menopause

Cara cepat mengingat:

- Gejala fisik → kenyamanan & fungsi
- Gejala psikologis → emosi & coping
- Risiko jangka panjang → pencegahan
- Kurang pengetahuan → edukasi

BAB 8

Intervensi Keperawatan dan Penatalaksanaan Kolaboratif

A. Edukasi dan Konseling Kesehatan

Pendekatan edukasi kesehatan memegang peran sentral dalam asuhan keperawatan pada perempuan dengan menopause dini. Banyak pasien datang dengan keluhan fisik tanpa memahami bahwa penyebabnya berkaitan dengan perubahan hormonal. Ketidaktahuan ini sering menimbulkan kecemasan dan salah persepsi terhadap kondisi tubuhnya. Informasi yang jelas membantu pasien merasa lebih tenang dan mampu mengelola gejala secara mandiri. Perawat bertindak sebagai sumber informasi yang terpercaya dan mudah diakses. Literatur kesehatan perempuan menegaskan bahwa edukasi meningkatkan kualitas hidup dan kepatuhan terhadap perawatan (Faubion, 2023).

Materi edukasi dimulai dari pemahaman dasar tentang perubahan fisiologis yang terjadi. Pasien perlu mengetahui bahwa penurunan estrogen memengaruhi berbagai sistem tubuh seperti tulang, jantung, tidur, dan emosi. Penjelasan sederhana dengan bahasa sehari-hari lebih mudah dipahami dibanding istilah medis yang kompleks. Edukasi ini membantu pasien menghubungkan gejala yang tampak tidak berkaitan menjadi satu gambaran utuh. Ketika pasien memahami penyebabnya, rasa takut biasanya berkurang. Kajian klinis menunjukkan bahwa pemahaman penyakit berhubungan dengan peningkatan coping adaptif (Santoro et al., 2021).

Keluhan vasomotor seperti *hot flushes* dan keringat malam sering menjadi fokus utama edukasi. Perawat dapat menjelaskan cara menghindari pemicu seperti makanan pedas, kafein, atau suhu ruangan panas. Teknik sederhana seperti mengenakan pakaian tipis berlapis dan ventilasi kamar yang baik cukup membantu. Latihan relaksasi napas dalam juga dapat menurunkan intensitas gejala. Pendekatan nonfarmakologis ini aman dan mudah

diterapkan di rumah. Pedoman menopause modern merekomendasikan intervensi gaya hidup sebagai langkah awal manajemen gejala (NAMS, 2022).

Kualitas tidur perlu dibahas secara khusus karena banyak perempuan mengalami insomnia. Pasien dianjurkan menjaga jam tidur yang teratur dan membatasi penggunaan gawai sebelum tidur. Lingkungan kamar yang gelap, sejuk, dan tenang mendukung istirahat yang lebih baik. Minuman berkafein pada malam hari sebaiknya dihindari. Kebiasaan sederhana ini sering kali memberi perbaikan signifikan tanpa obat. Literatur menunjukkan bahwa sleep hygiene efektif memperbaiki gangguan tidur pada masa menopause (Santoro et al., 2021).

Aspek nutrisi juga termasuk komponen penting dalam edukasi kesehatan. Asupan kalsium dan vitamin D membantu menjaga kepadatan tulang. Pola makan seimbang dengan buah, sayur, dan protein rendah lemak mendukung kesehatan jantung. Pembatasan gula dan lemak jenuh membantu mencegah kenaikan berat badan. Edukasi gizi perlu disesuaikan dengan budaya makan lokal agar lebih realistis. Studi epidemiologi menyatakan bahwa gaya hidup sehat menurunkan risiko komplikasi jangka panjang pada menopause dini (Faubion, 2023).

Aktivitas fisik memberikan banyak manfaat bagi perempuan dengan menopause dini. Latihan beban ringan membantu mempertahankan massa tulang dan kekuatan otot. Olahraga aerobik seperti jalan cepat atau bersepeda meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Aktivitas fisik juga merangsang pelepasan endorfin yang memperbaiki suasana hati. Perawat dapat mendorong pasien memulai secara bertahap sesuai kemampuan. Pedoman klinis menyebutkan bahwa olahraga rutin berkontribusi pada keseimbangan fisik dan psikologis (ESHRE Guideline Group, 2024).

Edukasi mengenai kesehatan mental tidak kalah penting. Perempuan perlu memahami bahwa perubahan emosi selama menopause adalah hal yang wajar secara biologis. Teknik manajemen stres seperti relaksasi, meditasi, atau berbagi cerita dengan orang terdekat dapat membantu. Perawat dapat mengajarkan strategi koping sederhana yang mudah dipraktikkan. Dukungan sosial terbukti meningkatkan ketahanan psikologis pasien. Literatur kesehatan mental perempuan menunjukkan bahwa intervensi psikososial menurunkan risiko depresi pada masa menopause (Gordon et al., 2020).

Kesehatan seksual juga perlu dibicarakan secara terbuka dan sensitif. Banyak pasien merasa malu mengungkapkan keluhan kekeringan vagina atau nyeri saat hubungan seksual. Edukasi tentang penggunaan pelumas berbasis air

dan komunikasi dengan pasangan dapat meningkatkan kenyamanan. Perawat perlu menciptakan suasana aman agar pasien merasa dihargai. Informasi yang tepat membantu mempertahankan keharmonisan hubungan keluarga. Pedoman praktik menopause menekankan bahwa fungsi seksual merupakan bagian dari kualitas hidup (NAMS, 2022).

Edukasi kesehatan bertujuan memberdayakan pasien agar mampu merawat dirinya sendiri. Pengetahuan yang baik meningkatkan kepercayaan diri dan partisipasi aktif dalam pengobatan. Perawat berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pendamping selama proses adaptasi. Edukasi yang konsisten membantu mencegah komplikasi jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip promotif dan preventif dalam keperawatan komunitas. Literatur praktik kesehatan perempuan mendukung bahwa intervensi edukatif merupakan fondasi utama manajemen menopause dini (Faubion, 2023; Santoro et al., 2021).

B. Manajemen Gejala

Penanganan gejala pada perempuan dengan menopause dini bertujuan meningkatkan kenyamanan, fungsi sehari-hari, dan kualitas hidup. Keluhan yang muncul sering bersifat kombinasi antara fisik, psikologis, dan sosial sehingga memerlukan pendekatan menyeluruh. Perawat berperan penting dalam mengajarkan strategi nonfarmakologis sebelum atau bersamaan dengan terapi medis. Intervensi sederhana sering kali efektif jika dilakukan secara konsisten. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip promotif dan preventif dalam keperawatan komunitas. Literatur kesehatan perempuan merekomendasikan manajemen gejala berbasis gaya hidup dan edukasi pasien (Faubion, 2023).

1. Gejala vasomotor (hot flushes, keringat malam)

- Gunakan pakaian tipis dan menyerap keringat
- Atur ventilasi/AC, suhu ruangan sejuk
- Hindari pemicu: kafein, makanan pedas, stres, rokok
- Minum air cukup
- Latihan relaksasi atau napas dalam
- Catat frekuensi gejala untuk evaluasi

2. Gangguan tidur (insomnia, sering terbangun)

- Terapkan *sleep hygiene* (jam tidur tetap setiap hari)
- Hindari gawai/kopi 2–3 jam sebelum tidur
- Lingkungan kamar gelap, tenang, sejuk
- Mandi air hangat sebelum tidur

- Teknik relaksasi/meditasi ringan
- Batasi tidur siang terlalu lama

3. Kelelahan & penurunan energi

- Atur jadwal aktivitas dan istirahat seimbang
- Lakukan aktivitas bertahap sesuai toleransi
- Konsumsi makanan bergizi seimbang
- Hidrasi adekuat
- Evaluasi anemia atau gangguan tidur
- Dorong olahraga ringan rutin

4. Nyeri sendi/otot & risiko osteoporosis

- Latihan beban ringan (jalan cepat, tangga, *resistance band*)
- Latihan rentang gerak (ROM)
- Kompres hangat saat nyeri
- Asupan kalsium dan vitamin D cukup
- Paparan sinar matahari pagi
- Edukasi pencegahan jatuh di rumah

5. Kenaikan berat badan & risiko metabolik

- Diet seimbang: tinggi serat, rendah lemak jenuh
- Batasi gula sederhana
- Makan teratur porsi kecil
- Monitoring berat badan berkala
- Olahraga aerobik minimal 30 menit/hari
- Konseling gizi bila diperlukan

6. Ansietas, *mood swing*, stres emosional

- Komunikasi terapeutik & dukungan emosional
- Latihan relaksasi, *mindfulness*, dzikir/meditasi sesuai budaya
- Aktivitas menyenangkan (hobi, sosial)
- Dukungan keluarga/kelompok sebaya
- Edukasi bahwa perubahan emosi bersifat biologis
- Rujukan profesional kesehatan jiwa bila berat

7. Gangguan konsentrasi (*brain fog*)

- Tidur cukup
- Buat catatan/*to-do list*
- Kerjakan tugas satu per satu
- Istirahat singkat di sela aktivitas
- Latihan kognitif ringan (membaca, *puzzle*)
- Kelola stres harian

8. Masalah seksual (kekeringan vagina, dispareunia, libido menurun)

- Gunakan pelumas berbasis air
- *Foreplay* lebih lama
- Komunikasi terbuka dengan pasangan
- Jaga kebersihan genital
- Konseling seksual bila diperlukan
- Rujukan medis untuk terapi lokal estrogen bila indikasi

9. Pencegahan risiko jangka panjang (jantung & tulang)

- Cek tekanan darah, gula darah, lipid rutin
- Berhenti merokok
- Aktivitas fisik teratur
- Pola makan sehat jantung
- Skrining densitas tulang sesuai anjuran
- Kepatuhan kontrol kesehatan berkala

C. Pengaturan Nutrisi dan Aktivitas Fisik

Perubahan metabolik pada menopause dini sering memengaruhi berat badan, massa tulang, serta kesehatan jantung. Penurunan estrogen menyebabkan distribusi lemak bergeser ke area perut dan laju metabolisme melambat. Kondisi ini meningkatkan risiko obesitas sentral, dislipidemia, dan resistensi insulin. Kebiasaan makan dan pola aktivitas fisik berperan besar dalam mengendalikan risiko tersebut. Intervensi berbasis gaya hidup menjadi strategi utama yang aman dan mudah diterapkan. Literatur kesehatan perempuan merekomendasikan modifikasi nutrisi dan olahraga sebagai pilar penting manajemen jangka panjang (Faubion, 2023).

1. Prinsip umum gaya hidup sehat

- Pola makan seimbang + olahraga teratur
- Pertahankan IMT normal
- Hindari rokok dan alkohol
- Tidur cukup dan manajemen stres
- Monitoring berat badan berkala
- Edukasi berkelanjutan oleh perawat

2. Kebutuhan kalsium & vitamin D (kesehatan tulang)

- Kalsium $\pm$ 1000–1200 mg/hari
- Vitamin D 600–800 IU/hari
- Konsumsi susu rendah lemak, tempe, tahu, ikan teri, sayuran hijau
- Paparan sinar matahari pagi 10–15 menit
- Suplementasi bila asupan kurang
- Skrining densitas tulang pada kelompok risiko

3. Pola makan seimbang untuk metabolisme & jantung

- Perbanyak sayur, buah, dan serat
- Protein sehat: ikan, ayam tanpa kulit, kacang-kacangan
- Lemak sehat: alpukat, kacang, minyak zaitun
- Kurangi lemak jenuh & gorengan
- Batasi gula sederhana dan minuman manis
- Kurangi garam untuk mencegah hipertensi

4. Pengaturan porsi & kebiasaan makan

- Makan teratur 3 kali + selingan sehat
- Hindari makan larut malam
- Gunakan piring kecil untuk kontrol porsi
- Minum air putih cukup
- Catat asupan makanan bila perlu
- Edukasi *mindful eating*

5. Aktivitas fisik aerobik (kesehatan jantung & berat badan)

- Jalan cepat, bersepeda, berenang, senam
- Minimal 30 menit/hari, 5 kali/minggu
- Intensitas sedang (masih bisa bicara saat olahraga)
- Lakukan pemanasan & pendinginan
- Mulai bertahap sesuai toleransi
- Pantau denyut nadi dan kelelahan

6. Latihan beban (kekuatan tulang & otot)

- *Resistance band*, *dumbbell* ringan, *squat*, naik tangga
- 2–3 kali/minggu
- Fokus otot kaki, punggung, dan panggul
- Tingkatkan beban perlahan
- Mencegah osteoporosis & jatuh
- Kombinasikan dengan latihan keseimbangan

7. Fleksibilitas & relaksasi (nyeri sendi & stres)

- Peregangan ringan setiap hari
- Yoga atau pilates
- Latihan pernapasan
- Mengurangi kekakuan sendi
- Membantu kualitas tidur
- Menurunkan stres emosional

8. Edukasi perilaku sedentari

- Kurangi duduk terlalu lama

- Berdiri atau berjalan tiap 1 jam
- Gunakan tangga daripada lift
- Aktivitas rumah tangga aktif
- Batasi *screen time* berlebihan
- Tingkatkan gerak harian sederhana

Contoh edukasi praktis dapat diberikan dalam bentuk rencana aktivitas harian yang sederhana dan mudah diterapkan di rumah. Pasien dapat memulai hari dengan sarapan bergizi seperti *oatmeal*, buah segar, dan susu rendah lemak untuk menjaga energi serta kesehatan tulang. Pada waktu siang, menu seimbang seperti nasi merah, sayuran, dan ikan bakar membantu memenuhi kebutuhan serat, protein, dan lemak sehat. Camilan sehat seperti kacang atau tempe kukus dapat dikonsumsi di antara waktu makan untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Sore hari dapat diisi dengan aktivitas fisik ringan seperti jalan cepat selama 30 menit guna mendukung kesehatan jantung dan metabolisme. Pada malam hari, pasien dianjurkan makan dalam porsi ringan dan tidur cukup, disertai jadwal olahraga mingguan yang teratur agar kebiasaan sehat dapat dipertahankan dalam jangka panjang (Santoro et al., 2021; Faubion, 2023).

D. Dukungan Psikologis

Perubahan hormonal pada menopause dini sering memengaruhi kondisi emosional perempuan secara nyata. Banyak pasien melaporkan perasaan cemas, mudah marah, sedih, atau kehilangan motivasi tanpa sebab yang jelas. Keluhan ini bukan sekadar reaksi psikologis, tetapi berkaitan dengan perubahan neurokimia akibat penurunan estrogen. Dampaknya dapat mengganggu hubungan keluarga, pekerjaan, dan kualitas hidup sehari-hari. Perawat perlu memahami bahwa aspek mental sama pentingnya dengan gejala fisik. Literatur menunjukkan bahwa dukungan psikologis berperan besar dalam meningkatkan adaptasi perempuan selama transisi menopause (Gordon et al., 2020).

Pendekatan awal yang paling sederhana adalah komunikasi terapeutik. Perawat memberi ruang aman agar pasien dapat bercerita tanpa merasa dihakimi. Sikap empati, kontak mata, dan mendengarkan aktif membantu membangun kepercayaan. Banyak pasien merasa lega hanya dengan didengar. Hubungan yang baik memudahkan perawat menggali masalah lebih dalam. Pendekatan komunikasi seperti ini direkomendasikan dalam praktik kesehatan perempuan modern (Faubion, 2023).

Intervensi berikutnya berfokus pada edukasi emosional. Pasien perlu memahami bahwa perubahan suasana hati selama menopause bersifat biologis dan umum terjadi. Pengetahuan ini membantu mengurangi rasa takut atau anggapan bahwa dirinya “lemah”. Edukasi juga meningkatkan kemampuan pasien mengenali tanda stres sejak dini. Ketika pasien paham penyebabnya, ia lebih siap mencari bantuan. Literatur menyebutkan bahwa pemahaman kondisi kesehatan meningkatkan koping adaptif (Santoro et al., 2021).

Teknik manajemen stres dapat diajarkan sebagai strategi praktis. Latihan napas dalam, relaksasi otot progresif, atau meditasi ringan membantu menenangkan sistem saraf. Aktivitas spiritual sesuai keyakinan pasien juga dapat memberi efek menenangkan. Teknik ini mudah dipraktikkan di rumah tanpa alat khusus. Perawat dapat mendemonstrasikan langsung selama sesi edukasi. Pendekatan nonfarmakologis ini terbukti menurunkan tingkat kecemasan (Gordon et al., 2020).

Dukungan keluarga memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan psikologis. Pasien yang merasa dipahami cenderung lebih stabil secara emosional. Perawat dapat melibatkan pasangan atau anggota keluarga dalam sesi konseling singkat. Edukasi keluarga membantu mereka memahami perubahan perilaku pasien. Lingkungan yang suportif mengurangi konflik rumah tangga. Pedoman menopause modern menekankan pentingnya dukungan sosial dalam manajemen gejala (NAMS, 2022).

Selain keluarga, dukungan kelompok sebaya juga bermanfaat. Bertemu dengan perempuan lain yang mengalami kondisi serupa dapat menumbuhkan rasa kebersamaan. Pasien merasa tidak sendirian menghadapi masalahnya. Diskusi kelompok sering menjadi tempat berbagi pengalaman dan solusi praktis. Perawat dapat memfasilitasi kelas edukasi atau *support group* sederhana. Literatur menyebutkan bahwa dukungan komunitas meningkatkan kualitas hidup perempuan menopause (Faubion, 2023).

Masalah psikologis yang lebih berat memerlukan rujukan profesional. Gejala seperti depresi berkepanjangan, gangguan tidur berat, atau pikiran negatif ekstrem perlu ditangani oleh psikolog atau psikiater. Kolaborasi ini merupakan bagian dari penatalaksanaan interdisiplin. Perawat berperan mendeteksi dini dan mengarahkan pasien ke layanan yang tepat. Tindakan cepat dapat mencegah komplikasi kesehatan mental. Rekomendasi klinis menekankan pentingnya skrining depresi selama masa menopause (Gordon et al., 2020).

Sebagai contoh, seorang perempuan usia 40 tahun mengeluh sering marah pada anak dan sulit tidur. Setelah diwawancarai, ia merasa takut tidak lagi produktif karena haid berhenti lebih cepat. Perawat memberikan edukasi tentang menopause dini dan mengajarkan teknik napas dalam. Pasien juga diajak berdiskusi bersama suami agar mendapat dukungan di rumah. Dalam beberapa minggu, emosinya lebih stabil dan kualitas tidur membaik. Kasus ini menunjukkan bahwa intervensi psikologis sederhana dapat memberi dampak nyata (Santoro et al., 2021).

Secara keseluruhan, dukungan psikologis membantu perempuan beradaptasi secara sehat terhadap perubahan hidup. Intervensi ini melengkapi perawatan fisik dan meningkatkan keberhasilan terapi. Perawat memiliki peran strategis sebagai pendamping emosional sekaligus edukator. Pendekatan yang hangat dan sistematis membuat pasien lebih percaya diri menghadapi masa menopause. Dukungan berkelanjutan mendorong kualitas hidup yang lebih baik. Literatur praktik kesehatan perempuan menegaskan bahwa manajemen psikososial merupakan komponen utama asuhan komprehensif (Faubion, 2023; NAMS, 2022).

E. Farmakologi/*Hormone Replacement Therapy* (HRT) dan Rujukan

Pendekatan nonfarmakologis sering menjadi langkah awal dalam mengelola gejala menopause dini, namun sebagian pasien tetap memerlukan terapi medis. Keluhan seperti *hot flushes* berat, insomnia persisten, nyeri sendi, atau gangguan psikologis dapat mengganggu fungsi sehari-hari. Dalam kondisi tersebut, kolaborasi dengan tenaga medis diperlukan untuk pemberian terapi farmakologis yang tepat. Perawat berperan dalam edukasi, pemantauan efek samping, serta memastikan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Penatalaksanaan ini dilakukan secara individual sesuai kondisi klinis pasien. Literatur menyatakan bahwa terapi hormonal dapat memberikan manfaat signifikan pada perempuan dengan menopause dini jika digunakan secara tepat (NAMS, 2022).

Terapi yang paling sering digunakan adalah *Hormone Replacement Therapy* atau terapi sulih hormon. Pemberian estrogen bertujuan menggantikan hormon yang menurun sehingga gejala vasomotor dan urogenital berkurang. Pada perempuan yang masih memiliki uterus, estrogen biasanya dikombinasikan dengan progesteron untuk melindungi endometrium. Kombinasi ini membantu mencegah hiperplasia endometrium. Penggunaan HRT dilakukan dengan dosis efektif terendah sesuai indikasi. Pedoman klinis

menunjukkan bahwa manfaat HRT pada usia muda dengan menopause dini lebih besar dibanding risikonya (Faubion, 2023).

Selain meredakan gejala, terapi hormonal juga berperan dalam pencegahan komplikasi jangka panjang. Estrogen membantu mempertahankan kepadatan tulang dan menurunkan risiko osteoporosis. Hormon ini juga memberi efek protektif pada sistem kardiovaskular bila diberikan pada periode awal menopause. Pasien dengan menopause dini berisiko lebih tinggi mengalami penyakit jantung jika tidak mendapat terapi yang sesuai. HRT dapat membantu menekan risiko tersebut pada kelompok tertentu. Kajian endokrinologi menyebutkan bahwa terapi hormonal mendukung kesehatan tulang dan metabolik (ESHRE Guideline Group, 2024).

Meski demikian, penggunaan HRT memerlukan evaluasi menyeluruh. Tidak semua pasien cocok menerima terapi hormonal. Riwayat kanker payudara, penyakit tromboemboli, atau gangguan hati menjadi pertimbangan penting. Perawat perlu melakukan skrining awal dan mengkaji faktor risiko sebelum merujuk pasien. Pemantauan berkala selama terapi juga diperlukan untuk mendeteksi efek samping. Literatur menekankan pentingnya seleksi pasien secara hati-hati dalam pemberian HRT (NAMS, 2022).

Selain terapi hormonal, beberapa obat nonhormonal dapat digunakan sebagai alternatif. Antidepresan dosis rendah seperti SSRI atau SNRI dapat membantu mengurangi *hot flashes* dan gangguan *mood*. Obat penenang ringan atau terapi tidur dapat dipertimbangkan pada insomnia berat. Suplemen kalsium dan vitamin D direkomendasikan untuk menjaga kesehatan tulang. Obat antihipertensi atau penurun lipid diberikan bila terdapat risiko kardiovaskular. Pendekatan kombinasi sering digunakan sesuai kondisi klinis pasien (Santoro et al., 2021).

Perawat memiliki peran penting dalam edukasi penggunaan obat. Pasien perlu memahami cara minum obat yang benar, waktu pemberian, serta kemungkinan efek samping. Informasi yang jelas membantu meningkatkan kepatuhan terapi. Perawat juga memantau keluhan seperti nyeri payudara, perdarahan tidak normal, atau sakit kepala. Catatan harian gejala dapat membantu evaluasi terapi. Pendekatan edukatif terbukti meningkatkan keberhasilan pengobatan jangka panjang (Faubion, 2023).

Kolaborasi interdisiplin menjadi bagian penting dalam penatalaksanaan. Perempuan dengan menopause dini sering membutuhkan konsultasi dengan dokter spesialis kandungan, endokrinolog, atau psikiater. Rujukan dilakukan bila gejala kompleks atau terdapat komorbiditas. Kerja sama tim membantu

menentukan terapi yang paling aman dan efektif. Perawat berperan sebagai koordinator layanan dan pendamping pasien. Model kolaboratif ini direkomendasikan dalam praktik kesehatan reproduksi modern (ESHRE Guideline Group, 2024).

Sebagai contoh, seorang pasien usia 37 tahun mengalami *hot flushes* berat dan densitas tulang menurun. Setelah pengkajian, dokter meresepkan HRT kombinasi estrogen-progesteron. Perawat memberikan edukasi cara penggunaan dan memantau tekanan darah serta keluhan efek samping. Pasien juga dirujuk ke ahli gizi dan fisioterapis untuk program latihan tulang. Dalam beberapa bulan, gejala berkurang dan kualitas hidup membaik. Contoh ini menunjukkan pentingnya pendekatan kolaboratif antara farmakologi dan intervensi gaya hidup (NAMS, 2022).

Terapi farmakologis dan rujukan medis melengkapi intervensi keperawatan nonfarmakologis. Penggunaan obat harus disesuaikan dengan kebutuhan individu dan dipantau secara ketat. Perawat berperan sebagai edukator, advokat, dan penghubung antarprofesi. Pendekatan komprehensif membantu pasien mendapatkan manfaat maksimal dengan risiko minimal. Kombinasi edukasi, pemantauan, dan kolaborasi tim meningkatkan keberhasilan terapi. Literatur kesehatan perempuan mendukung strategi terpadu ini untuk manajemen menopause dini (Faubion, 2023; Santoro et al., 2021).

BAB 9

Pendidikan dan Promosi Kesehatan

A. Strategi Edukasi Pasien dan Keluarga

Upaya pendidikan kesehatan pada perempuan dengan menopause dini tidak hanya ditujukan kepada pasien, tetapi juga kepada keluarga terdekat. Kondisi ini memengaruhi peran sosial, emosi, dan hubungan interpersonal sehingga dukungan lingkungan sangat dibutuhkan. Banyak perempuan merasa cemas atau salah paham karena kurang informasi tentang perubahan tubuhnya. Edukasi yang tepat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan kemampuan adaptasi. Perawat berperan sebagai pendidik sekaligus fasilitator pembelajaran kesehatan. Literatur kesehatan perempuan menyatakan bahwa pendekatan edukasi keluarga meningkatkan keberhasilan manajemen menopause secara menyeluruh (Faubion, 2023).

Strategi edukasi perlu dirancang sesuai kebutuhan, tingkat pendidikan, dan budaya pasien. Bahasa sederhana lebih mudah dipahami dibanding istilah medis yang rumit. Media visual seperti gambar, *leaflet*, atau video membantu memperjelas pesan. Materi disampaikan bertahap agar tidak membebani pasien. Evaluasi pemahaman perlu dilakukan dengan metode tanya jawab atau *teach back*. Pendekatan edukasi partisipatif terbukti meningkatkan retensi informasi (Santoro et al., 2021).

Keluarga, terutama pasangan, perlu dilibatkan sejak awal. Perubahan *mood* dan fungsi seksual sering memengaruhi hubungan rumah tangga. Pemahaman pasangan membantu mengurangi konflik dan meningkatkan empati. Diskusi bersama dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka. Perawat dapat mengadakan sesi edukasi singkat yang melibatkan keluarga. Pedoman menopause modern merekomendasikan dukungan sosial sebagai faktor protektif kesehatan mental (NAMS, 2022).

Materi edukasi juga perlu mencakup aspek gaya hidup sehat. Informasi tentang nutrisi seimbang, aktivitas fisik, dan manajemen stres penting untuk mencegah komplikasi. Pasien diajak memahami bahwa perubahan kecil yang konsisten memberi dampak besar. Contohnya berjalan kaki rutin atau mengurangi gula harian. Edukasi berbasis praktik lebih efektif daripada teori saja. Studi menunjukkan bahwa intervensi gaya hidup berkontribusi pada perbaikan kualitas hidup perempuan menopause (Faubion, 2023).

Pendekatan kelompok dapat menjadi strategi tambahan yang efektif. Kelas edukasi atau *support group* memberi kesempatan pasien berbagi pengalaman. Interaksi sosial membantu mengurangi rasa kesepian. Diskusi kelompok juga memunculkan solusi praktis dari pengalaman nyata. Perawat berperan sebagai fasilitator dan pemberi klarifikasi informasi medis. Literatur komunitas kesehatan menyebutkan bahwa dukungan sebaya meningkatkan motivasi perubahan perilaku (World Health Organization [WHO], 2022).

Pemanfaatan media digital semakin relevan dalam promosi kesehatan. Informasi dapat disampaikan melalui pesan singkat, media sosial, atau aplikasi kesehatan. Konten edukasi singkat memudahkan pasien mengakses informasi kapan saja. Metode ini cocok untuk perempuan usia produktif yang sibuk bekerja. Perawat tetap perlu memastikan sumber informasi terpercaya. Pendekatan teknologi membantu memperluas jangkauan promosi kesehatan (Santoro et al., 2021).

Evaluasi hasil edukasi menjadi bagian penting dari proses pembelajaran. Perawat menilai apakah pasien mampu menjelaskan kembali informasi yang diterima. Perubahan perilaku seperti pola makan sehat atau olahraga rutin dapat menjadi indikator keberhasilan. Umpan balik dari pasien membantu memperbaiki metode edukasi. Pendekatan evaluatif memastikan intervensi berjalan efektif. Literatur praktik keperawatan menekankan pentingnya monitoring berkelanjutan dalam pendidikan kesehatan (Faubion, 2023).

Sebagai contoh, seorang perempuan usia 38 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan haid berhenti selama delapan bulan, sering merasa panas mendadak, mudah marah, dan sulit tidur. Ia mengaku takut karena mengira dirinya mengalami penyakit serius atau tidak lagi “normal” sebagai perempuan. Kondisi tersebut membuatnya menarik diri dari keluarga dan sering bertengkar dengan suami. Perawat kemudian melakukan sesi edukasi terstruktur menggunakan bahasa sederhana dan media gambar tentang apa itu menopause dini, penyebab hormonalnya, serta pilihan penanganan. Pasien diajak memahami bahwa gejalanya bersifat biologis dan dapat

dikendalikan. Edukasi awal ini menurunkan kecemasan dan membuat pasien lebih terbuka untuk berdiskusi (Santoro et al., 2021).

Pada pertemuan berikutnya, perawat mengundang suami pasien untuk ikut sesi keluarga. Suami dijelaskan bahwa perubahan emosi dan penurunan libido bukan karena sikap istri, melainkan akibat penurunan estrogen. Diskusi ini membantu menghilangkan kesalahpahaman yang sebelumnya memicu konflik rumah tangga. Perawat juga menekankan pentingnya dukungan emosional dan komunikasi yang empatik. Pasangan kemudian sepakat membuat jadwal aktivitas bersama agar istri tidak merasa sendirian. Pendekatan keluarga seperti ini terbukti meningkatkan kesejahteraan psikologis perempuan menopause (NAMS, 2022).

Edukasi dilanjutkan dengan rencana aksi harian yang konkret dan terukur. Pasien diminta mencatat jam tidur, frekuensi *hot flushes*, serta pola makan selama satu minggu. Perawat memberikan contoh menu sehat sederhana dan latihan jalan kaki 30 menit setiap sore. Suami ikut menemani olahraga sebagai bentuk dukungan. Pasien juga diajarkan teknik napas dalam setiap kali merasa cemas atau panas mendadak. Strategi berbasis perilaku ini membantu pasien merasa memiliki kendali atas tubuhnya (Faubion, 2023).

Setelah dua minggu, pasien melaporkan perubahan yang cukup nyata. Frekuensi *hot flushes* berkurang, tidur lebih nyenyak, dan emosi lebih stabil. Ia mulai kembali aktif mengurus rumah dan bercengkerama dengan anak-anak. Berat badan turun satu kilogram karena pola makan lebih teratur. Suami menyatakan komunikasi mereka membaik dan konflik berkurang. Perubahan kecil namun konsisten menunjukkan dampak langsung dari edukasi yang aplikatif (Santoro et al., 2021).

Evaluasi satu bulan kemudian memperlihatkan peningkatan kualitas hidup yang signifikan. Pasien tampak lebih percaya diri dan tidak lagi merasa “sakit”. Ia mampu menjelaskan kembali apa itu menopause dini dan cara mengatasinya. Kepatuhan terhadap olahraga dan diet mencapai lebih dari lima hari per minggu. Suami dan keluarga juga ikut menerapkan pola hidup sehat bersama. Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi yang melibatkan keluarga menghasilkan efek jangka panjang yang lebih kuat (Faubion, 2023).

Pengalaman tersebut menggambarkan bahwa edukasi kesehatan tidak cukup hanya memberi informasi satu arah. Perawat perlu mengombinasikan penjelasan ilmiah, keterlibatan keluarga, rencana tindakan nyata, serta evaluasi berkala. Pendekatan ini mengubah pengetahuan menjadi perilaku. Pasien tidak hanya paham, tetapi juga mampu melakukan perubahan.

Dampaknya terlihat pada aspek fisik, emosional, dan sosial sekaligus. Literatur kesehatan perempuan menegaskan bahwa intervensi edukasi berbasis keluarga meningkatkan hasil klinis secara bermakna (NAMS, 2022).

Dari sisi praktik keperawatan, strategi ini dapat direplikasi di berbagai *setting* layanan. Perawat dapat membuat paket edukasi singkat berisi *leaflet*, jadwal aktivitas, dan buku catatan gejala. Setiap kunjungan digunakan untuk mengevaluasi kemajuan pasien. Metode *teach back* memastikan pasien benar-benar memahami materi. Pendekatan sederhana ini meningkatkan keterlibatan pasien dalam perawatan dirinya. WHO menekankan bahwa pemberdayaan pasien merupakan inti promosi kesehatan modern (WHO, 2022).

Jika diterapkan secara luas, edukasi yang komprehensif dapat menurunkan beban komplikasi jangka panjang. Perempuan lebih cepat mengenali gejala, mencari pertolongan, dan menjalani gaya hidup sehat. Risiko osteoporosis, penyakit jantung, dan gangguan psikologis dapat ditekan sejak dini. Kualitas hidup meningkat tidak hanya bagi pasien, tetapi juga keluarganya. Dampak promotif dan preventif ini selaras dengan tujuan keperawatan komunitas. Literatur menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan adalah investasi efektif dalam pencegahan penyakit kronis (Santoro et al., 2021).

Contoh kasus tersebut menegaskan bahwa edukasi yang detail, personal, dan melibatkan keluarga memberi hasil yang nyata. Informasi berubah menjadi aksi, dan aksi menghasilkan perbaikan kesehatan. Perawat berperan sebagai penggerak perubahan perilaku, bukan sekadar pemberi nasihat. Ketika pasien merasa dipahami dan didampingi, motivasi untuk sembuh meningkat. Pendekatan seperti ini membuat intervensi keperawatan lebih bermakna dan berkelanjutan. Praktik berbasis bukti mendukung strategi edukasi intensif sebagai komponen utama manajemen menopause dini (Faubion, 2023; NAMS, 2022).

B. Program Pencegahan Di Komunitas

Isu menopause dini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kesehatan masyarakat secara luas. Banyak perempuan usia produktif tetap aktif bekerja dan berperan dalam keluarga, sehingga gangguan kesehatan pada fase ini dapat memengaruhi produktivitas komunitas. Pendekatan komunitas membantu menjangkau perempuan yang belum datang ke fasilitas kesehatan. Fokusnya bukan sekadar memberi informasi, melainkan menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku sehat. Perawat komunitas berperan sebagai penggerak perubahan sosial sekaligus edukator

kesehatan. Strategi pencegahan berbasis populasi terbukti efektif menurunkan risiko penyakit kronis pada perempuan usia pertengahan (World Health Organization [WHO], 2022).

Program pencegahan di komunitas menekankan deteksi dini dan intervensi awal. Banyak perempuan tidak menyadari bahwa gangguan haid atau *hot flushes* bisa menjadi tanda menopause dini. Kegiatan skrining sederhana seperti pengisian kuesioner gejala atau pemeriksaan tekanan darah dapat dilakukan di posyandu, puskesmas, atau tempat kerja. Identifikasi awal membantu perempuan memperoleh penanganan lebih cepat. Pendekatan ini lebih proaktif dibanding menunggu pasien datang berobat. Literatur menyebutkan bahwa deteksi dini meningkatkan kualitas hidup jangka panjang (Faubion, 2023).

Kegiatan penyuluhan massal dapat disesuaikan dengan konteks budaya lokal. Perawat dapat memanfaatkan pertemuan PKK, pengajian, atau arisan sebagai media edukasi kesehatan perempuan. Bahasa yang digunakan sebaiknya sederhana dan dekat dengan keseharian masyarakat. Materi berfokus pada gejala awal, gaya hidup sehat, dan kapan perlu memeriksakan diri. Pendekatan informal seperti ini sering lebih efektif karena terasa akrab. Strategi berbasis komunitas meningkatkan partisipasi perempuan yang sebelumnya enggan ke fasilitas kesehatan (Santoro et al., 2021).

Pembentukan kelas kesehatan perempuan menjadi salah satu model yang dapat diterapkan. Kelas ini berisi diskusi rutin tentang nutrisi, olahraga, kesehatan mental, dan pencegahan osteoporosis. Peserta dapat berbagi pengalaman sehingga tercipta dukungan sebaya. Perawat bertindak sebagai fasilitator yang memberikan informasi berbasis bukti. Suasana kelompok membantu meningkatkan motivasi perubahan perilaku. Studi komunitas menunjukkan bahwa edukasi kelompok lebih efektif dibanding edukasi individu saja (WHO, 2022).

Program aktivitas fisik bersama juga berperan dalam pencegahan. Senam pagi, jalan sehat, atau yoga komunitas dapat dijadwalkan secara rutin. Kegiatan ini membantu menjaga berat badan, kesehatan jantung, dan kepadatan tulang. Selain manfaat fisik, interaksi sosial meningkatkan kesehatan mental. Partisipasi bersama membuat perempuan lebih konsisten berolahraga. Literatur klinis menegaskan bahwa aktivitas fisik rutin menurunkan risiko komplikasi menopause dini (Faubion, 2023).

Aspek nutrisi dapat didukung melalui kampanye makanan sehat di lingkungan sekitar. Perawat dapat bekerja sama dengan kader kesehatan untuk mempromosikan konsumsi sayur, buah, dan sumber kalsium lokal seperti tempe atau ikan teri. Demonstrasi memasak menu sehat dapat menarik minat masyarakat. Pendekatan ini membantu keluarga memahami bahwa pola makan sehat tidak harus mahal. Perubahan kecil dalam kebiasaan makan memberi dampak jangka panjang. Kajian epidemiologi menunjukkan bahwa diet seimbang mendukung kesehatan metabolik perempuan menopause (Santoro et al., 2021).

Kolaborasi lintas sektor memperkuat keberhasilan program pencegahan. Kerja sama dengan sekolah, tempat kerja, atau organisasi perempuan memperluas jangkauan sasaran. Misalnya, skrining kesehatan reproduksi di kantor atau seminar kesehatan di kampus. Perawat dapat mengoordinasikan kegiatan bersama tenaga medis lain. Model kolaboratif mempermudah akses layanan kesehatan. Pendekatan terpadu direkomendasikan dalam praktik kesehatan masyarakat modern (WHO, 2022).

Program pencegahan di komunitas berfokus pada pemberdayaan kolektif, bukan hanya edukasi individu. Perawat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat dan deteksi dini. Pendekatan ini mengurangi beban penyakit sebelum masalah menjadi berat. Upaya promotif dan preventif memberikan manfaat jangka panjang bagi perempuan dan keluarganya. Kegiatan berbasis komunitas selaras dengan prinsip keperawatan komunitas dan kesehatan masyarakat. Literatur global menegaskan bahwa intervensi populasi merupakan strategi efektif dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan usia pertengahan (WHO, 2022; Santoro et al., 2021).

C. Peran Perawat Sebagai *Educator* dan *Advocate*

Perubahan kesehatan pada masa menopause dini sering terjadi perlahan dan tidak selalu disadari oleh perempuan. Banyak pasien datang dengan keluhan terpisah seperti sulit tidur, mudah marah, atau nyeri sendi tanpa memahami keterkaitannya. Situasi ini menempatkan perawat pada posisi strategis sebagai sumber informasi yang paling dekat dengan masyarakat. Perawat bukan hanya pemberi tindakan klinis, tetapi juga pendidik kesehatan yang membantu pasien memahami tubuhnya sendiri. Informasi yang tepat dapat mengurangi ketakutan dan meningkatkan rasa kontrol diri. Literatur kesehatan perempuan menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan tenaga kesehatan berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas hidup pasien (Faubion, 2023).

Sebagai *educator*, perawat bertugas menjelaskan kondisi menopause dini dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Penjelasan perlu disesuaikan dengan latar belakang pendidikan serta budaya pasien. Materi yang disampaikan mencakup perubahan hormon, gejala, pencegahan komplikasi, dan cara perawatan mandiri. Media visual seperti *leaflet* atau poster membantu memperjelas informasi. Metode *teach back* dapat digunakan untuk memastikan pasien benar-benar mengerti. Pendekatan edukatif yang interaktif terbukti meningkatkan retensi pengetahuan dan perubahan perilaku (Santoro et al., 2021).

Perawat juga berperan mengajarkan keterampilan praktis, bukan sekadar teori. Pasien dapat dilatih mencatat gejala harian, mengatur jadwal tidur, atau memilih menu sehat. Demonstrasi latihan fisik ringan memberi contoh langsung yang mudah ditiru. Keterampilan ini membantu pasien mengelola gejala secara mandiri di rumah. Ketika pasien mampu melakukan perawatan diri, ketergantungan pada layanan kesehatan berkurang. Pendekatan pemberdayaan seperti ini direkomendasikan dalam praktik promotif preventif (World Health Organization [WHO], 2022).

Selain sebagai pendidik, perawat berfungsi sebagai *advocate* atau pembela kepentingan pasien. Tidak semua perempuan memiliki akses atau keberanian untuk menyuarakan kebutuhan kesehatannya. Sebagian merasa malu membicarakan masalah reproduksi atau seksual. Perawat dapat membantu menyampaikan keluhan pasien kepada tim medis secara profesional. Tindakan ini memastikan pasien memperoleh pelayanan yang adil dan sesuai haknya. Peran advokasi diakui sebagai bagian penting praktik keperawatan modern (Faubion, 2023).

Advokasi juga berarti melindungi pasien dari informasi yang salah. Banyak mitos tentang menopause beredar di masyarakat, seperti anggapan bahwa gejala harus “ditahan saja” atau terapi hormon selalu berbahaya. Perawat perlu meluruskan kesalahpahaman tersebut dengan bukti ilmiah. Edukasi berbasis fakta membantu pasien membuat keputusan rasional. Keputusan yang tepat berdampak pada pencegahan komplikasi jangka panjang. Literatur menunjukkan bahwa literasi kesehatan yang baik meningkatkan kepatuhan terapi (Santoro et al., 2021).

Peran perawat semakin luas dalam konteks keluarga. Perawat dapat menjembatani komunikasi antara pasien dan pasangan. Penjelasan tentang perubahan emosi atau seksual membantu mengurangi konflik rumah tangga. Keluarga yang memahami kondisi pasien cenderung lebih suportif. Dukungan sosial mempercepat adaptasi psikologis perempuan menopause. Pedoman

praktik menopause menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dalam perawatan (NAMS, 2022).

Di tingkat komunitas, perawat dapat menjadi penggerak program promosi kesehatan. Kegiatan seperti kelas kesehatan perempuan, skrining rutin, atau senam bersama dapat diprakarsai oleh perawat. Tindakan ini memperluas dampak edukasi dari individu menjadi populasi. Perempuan yang sebelumnya tidak terjangkau layanan kesehatan menjadi lebih mudah diakses. Pendekatan komunitas membantu mencegah masalah sebelum menjadi berat. WHO menegaskan bahwa tenaga kesehatan komunitas memiliki peran kunci dalam pemberdayaan masyarakat (WHO, 2022).

Contoh nyata dapat terlihat pada seorang pasien usia 40 tahun yang merasa putus asa karena haid berhenti lebih awal. Setelah mendapatkan edukasi tentang menopause dini, ia mulai mengatur pola makan dan berolahraga. Perawat juga membantu menyampaikan keluhannya kepada dokter sehingga ia mendapat terapi yang sesuai. Suaminya dilibatkan dalam sesi konseling sehingga hubungan mereka membaik. Dalam beberapa minggu, pasien lebih percaya diri dan aktif kembali bekerja. Perubahan ini menunjukkan bahwa kombinasi peran edukator dan advokat memberi dampak langsung pada kualitas hidup (Faubion, 2023).

Perawat memiliki posisi unik untuk memengaruhi kesehatan perempuan secara luas. Peran sebagai pendidik membekali pasien dengan pengetahuan dan keterampilan. Peran sebagai advokat memastikan hak kesehatan pasien terpenuhi. Kedua fungsi ini saling melengkapi dan menghasilkan dampak nyata pada kesejahteraan fisik maupun emosional. Ketika perawat aktif menjalankan kedua peran tersebut, asuhan keperawatan menjadi lebih bermakna dan berkelanjutan. Literatur praktik kesehatan perempuan mendukung bahwa keterlibatan perawat secara edukatif dan advokatif meningkatkan hasil kesehatan secara signifikan (Santoro et al., 2021; WHO, 2022).

Daftar Pustaka

- Agrawal, P. K. (2025). Menopause across Asia: a comprehensive meta-analysis of age at menopause and urban–rural differences. *[Meta-analysis, open access]. Journal of Regional Menopause Studies*. Retrieved from PubMed Central. (meta-analysis covering Asian countries including Indonesia).
- Amalyah, R. (2024). Factors associated with menstrual disorders in Indonesia: prevalence and related determinants. *Health Science Journal*, (details).
- Anas, M., dkk. (2022). *Gambaran klinis menopause dan cara mengatasinya* (Surabaya Biomedical Journal). Universitas Muhammadiyah Surabaya. Retrieved from <https://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/8586/1/gambaran%20klinis%20menopause.pdf>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik kesehatan dan kesejahteraan perempuan Indonesia*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/29/5d308763ac29278dd5860fad/statistik-penduduk-lanjut-usia-2023.html>
- Basic Health Research (Riskesdas) data cited in local Indonesian studies indicate irregular menstrual cycles in women aged 10–59 years. (2018). *Riset Kesehatan Dasar 2018*. Ministry of Health, Republic of Indonesia.
- Diyu, I. A. N. P. (2022). *Menopausal symptoms in women aged 40–65 years in Denpasar* (cross-sectional study). (Institute of Technology and Health Bali). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/412311-menopausal-symptoms-in-women-aged-40-65-5f378fa9.pdf>
- ESHRE Guideline Group on Premature Ovarian Insufficiency. (2024).
- ESHRE guideline: *Premature ovarian insufficiency (update 2024)*. European Society of Human Reproduction and Embryology.
- Faubion, S. S. (2023). Premature menopause and primary ovarian insufficiency: Long-term health consequences. *Current Opinion in Obstetrics & Gynecology*, 35(4), 287–292. <https://doi.org/10.1097/GCO.0000000000000887>
- Federici, S., Rossetti, R., Moleri, S., Munari, E. V., Frixou, M., Bonomi, M., & Persani, L. (2024). Primary ovarian insufficiency: Update on clinical and genetic findings. *Frontiers in Endocrinology*, 15, 1464803. <https://doi.org/10.3389/fendo.2024.1464803>
- Fitri, S., Sofianita, N. I., & Octaria, Y. C. (2024). Factors influencing the menstrual cycle of female college students in Depok, Indonesia. *Amerta Nutrition*, 8(3 SP), 94–104.

- Gordon, J. L., Whitcomb, B. W., & Randolph, J. F. (2020). Depression risk across the menopausal transition: Systematic review and meta-analysis. *Menopause*, 27(11), 1317–1327. <https://doi.org/10.1097/GME.0000000000001605>
- Hickey, M., & Elliott, J. (2022). Female reproductive anatomy and physiology in clinical practice. *The Lancet Women's Health*, 6(3), 145–154.
- Jambarsang, S., Khodayarian, M., Sefidkar, R., Yoshany, N., et al. (2023). Prevalence of premature ovarian insufficiency (POI) and its relationship with female reproductive factors in Iranian women: A cross-sectional study from the Persian (Shahedieh) cohort data. *BMC Women's Health*, 23, 467. <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02620-9>
- Kapoor, E. (2023). Premature ovarian insufficiency: Clinical recognition and early management. *Current Opinion in Endocrine and Metabolic Research*, 28, 100435. <https://doi.org/10.1016/j.coemr.2023.100435>
- Ma'rifah, U. (2019). *Analisis komparasi usia menopause antara wanita urban dan rural* (thesis). Repository Universitas Muhammadiyah Surabaya. https://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/5857/1/YUANITA_%2871%29_pdf.pdf
- Permana, N. Z. M., Lestari, P., Akbar, M. I. A., & Yuliati, I. (2023). Clinical profile of menopause women in Batam, Makassar, and Surabaya. *Indonesian Journal of Obstetrics & Gynecology Science*, 6(1), 79–95. <https://www.obgynia.com/obgyn/index.php/obgynia/article/view/450>
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2017). *SDKI*.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2019). *SLKI & SIKI*.
- Rostami Dovom, M., Bidhendi-Yarandi, R., Mohammad, K., Farahmand, M., Azizi, F., & Ramezani Tehrani, F. (2021). Prevalence of premature ovarian insufficiency and its determinants in Iranian populations: Tehran lipid and glucose study. *BMC Women's Health*, 21, 79. <https://doi.org/10.1186/s12905-021-01228-1>
- Santoro, N., Epperson, C. N., & Mathews, S. B. (2021). Menopausal symptoms and their management. *JAMA*, 325(20), 2057–2066. <https://doi.org/10.1001/jama.2021.6373>
- Shuster, L. T., Rhodes, D. J., Gostout, B. S., Grossardt, B. R., & Rocca, W. A. (2021). Premature menopause or early menopause: Long-term health consequences and preventive strategies. *Maturitas*, 143, 34–41. <https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2020.08.008>
- The North American Menopause Society. (2022). The 2022 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. *Menopause*, 29(7), 767–794. <https://doi.org/10.1097/GME.0000000000002028>
- Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2021). *Principles of anatomy and physiology* (16th ed.). Wiley.
- World Health Organization. (2022). *Integrated care for older people (ICOPE): Guidelines on community-level interventions*. World Health Organization.
- Zilfia, A. F. (2023). *[BAB I Pendahuluan — contoh studi daerah tentang usia menopause dan faktor terkait]*. (Laporan/tesis yang membahas data Indonesia, 2023). (contoh studi/publikasi lokal; rujukan lokal provinsi/daerah).

Sinopsis

Perubahan kesehatan reproduksi pada perempuan tidak selalu terjadi sesuai usia yang diharapkan. Sebagian perempuan mengalami menopause lebih cepat, bahkan saat masih berada pada fase produktif kehidupan. Kondisi ini sering datang dengan keluhan yang beragam, mulai dari gangguan haid, hot flushes, kelelahan, perubahan emosi, hingga risiko penyakit jangka panjang seperti osteoporosis dan kardiovaskular. Banyak kasus tidak terdeteksi dini karena gejalanya dianggap wajar atau kurang dipahami. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan kualitas hidup keluarga. Situasi ini menuntut peran aktif perawat sebagai tenaga kesehatan terdepan yang paling dekat dengan pasien.

Menopause Dini: Memahami Perubahan, Memperkuat Peran Perawat dalam Deteksi, Pencegahan, dan Asuhan Holistik hadir sebagai panduan komprehensif bagi mahasiswa dan praktisi keperawatan untuk memahami fenomena menopause dini secara utuh. Buku ini mengulas konsep dasar anatomi dan fisiologi reproduksi, proses hormonal, serta patofisiologi menopause dini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Pembahasan dilengkapi dengan faktor risiko biologis, genetik, gaya hidup, hingga aspek psikososial dan budaya yang relevan dengan konteks perempuan Indonesia. Setiap materi dikaitkan langsung dengan praktik klinik sehingga pembaca tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam pelayanan nyata.

Lebih dari sekadar teori medis, buku ini menekankan pendekatan keperawatan holistik. Pembaca diajak mempelajari pengkajian komprehensif, penetapan diagnosis berbasis SDKI, perencanaan luaran (SLKI), serta intervensi (SIKI) yang sistematis. Strategi edukasi kesehatan, manajemen gejala, dukungan psikologis, nutrisi, aktivitas fisik, hingga kolaborasi farmakologis dibahas secara praktis dan aplikatif. Contoh kasus, tabel ringkasan, serta panduan langkah demi langkah membantu mempermudah pembelajaran dan praktik. Pendekatan ini dirancang agar perawat mampu memberikan asuhan yang aman, empatik, dan berbasis bukti.

Buku ini juga memperkuat peran perawat sebagai educator dan advocate. Perawat tidak hanya merawat gejala, tetapi juga memberdayakan perempuan dan keluarganya untuk memahami, mencegah, serta mengelola menopause dini secara mandiri. Perspektif komunitas dan promosi kesehatan turut disajikan untuk memperluas dampak asuhan dari individu ke masyarakat. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang tepat, perawat dapat menjadi agen perubahan yang meningkatkan kualitas hidup perempuan di berbagai tahap kehidupan.

Disusun secara runtut, kontekstual, dan relevan dengan praktik keperawatan di Indonesia, buku ini diharapkan menjadi referensi utama dalam pembelajaran maupun pelayanan klinik. Mahasiswa akan memperoleh fondasi ilmiah yang kuat, sementara praktisi mendapatkan panduan tindakan yang nyata. Melalui buku ini, menopause dini tidak lagi dipandang sebagai masalah tersembunyi, melainkan kondisi yang dapat dikenali, dicegah, dan dikelola bersama.

Perubahan kesehatan reproduksi pada perempuan tidak selalu terjadi sesuai usia yang diharapkan. Sebagian perempuan mengalami menopause lebih cepat, bahkan saat masih berada pada fase produktif kehidupan. Kondisi ini sering datang dengan keluhan yang beragam, mulai dari gangguan haid, hot flushes, kelelahan, perubahan emosi, hingga risiko penyakit jangka panjang seperti osteoporosis dan kardiovaskular. Banyak kasus tidak terdeteksi dini karena gejalanya dianggap wajar atau kurang dipahami. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan kualitas hidup keluarga. Situasi ini menuntut peran aktif perawat sebagai tenaga kesehatan terdepan yang paling dekat dengan pasien.

Menopause Dini: Memahami Perubahan, Memperkuat Peran Perawat dalam Deteksi, Pencegahan, dan Asuhan Holistik hadir sebagai panduan komprehensif bagi mahasiswa dan praktisi keperawatan untuk memahami fenomena menopause dini secara utuh. Buku ini mengulas konsep dasar anatomi dan fisiologi reproduksi, proses hormonal, serta patofisiologi menopause dini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Pembahasan dilengkapi dengan faktor risiko biologis, genetik, gaya hidup, hingga aspek psikososial dan budaya yang relevan dengan konteks perempuan Indonesia. Setiap materi dikaitkan langsung dengan praktik klinik sehingga pembaca tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam pelayanan nyata.

Lebih dari sekadar teori medis, buku ini menekankan pendekatan keperawatan holistik. Pembaca diajak mempelajari pengkajian komprehensif, penetapan diagnosis berbasis SDKI, perencanaan luaran (SLKI), serta intervensi (SIKI) yang sistematis. Strategi edukasi kesehatan, manajemen gejala, dukungan psikologis, nutrisi, aktivitas fisik, hingga kolaborasi farmakologis dibahas secara praktis dan aplikatif. Contoh kasus, tabel ringkasan, serta panduan langkah demi langkah membantu mempermudah pembelajaran dan praktik. Pendekatan ini dirancang agar perawat mampu memberikan asuhan yang aman, empatik, dan berbasis bukti.

Buku ini juga memperkuat peran perawat sebagai educator dan advocate. Perawat tidak hanya merawat gejala, tetapi juga memberdayakan perempuan dan keluarganya untuk memahami, mencegah, serta mengelola menopause dini secara mandiri. Perspektif komunitas dan promosi kesehatan turut disajikan untuk memperluas dampak asuhan dari individu ke masyarakat. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang tepat, perawat dapat menjadi agen perubahan yang meningkatkan kualitas hidup perempuan di berbagai tahap kehidupan.

ISBN 978-634-7556-47-9



Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

